

前 言

犬是人类的朋友。经过训练的犬，可以牧羊、牧马、放猪、狩猎、看门、侦察、追踪、送信、教人等。犬肉是佳肴美味，犬皮可以加工成裘皮，犬的内脏可以入药。目前，世界的养犬业发展得很快，在一些发达国家，养警犬和玩赏犬非常普遍。改革开放以来，我国的养犬业有了较大的发展，涌现出一批养菜犬、种狼犬的专业户，玩赏犬也开始引入。为了适应我国养犬业发展的需要，我们编写了《养犬与犬病防治》一书。

本书较详细地介绍了犬的品种、饲养管理、训练原理和方法、犬病防治等内容。文字通俗，简明易懂，理论和实际结合的较紧密。不仅适用于广大养犬者，而且也是广大养犬科技工作者的参考读物。但由于我们的水平所限，书中肯定有不妥之处，恳请广大读者指教。

编著者

1991年10月

目 录

一、犬的品种..... (1)

(一) 超大型犬..... (1)

1. 大丹 (1) 2. 圣伯纳犬 (2) 3. 俄国牧羊犬 (2)
4. 马士迪夫犬 (3) 5. 大白熊犬 (3) 6. 土佐犬 (3)

(二) 大型犬..... (4)

1. 獾犬 (4) 2. 拉布拉多猎犬 (4) 3. 阿富汗犬 (5)
4. 笃宾犬 (6) 5. 牧羊犬 (6) 6. 大麦町犬 (7) 7. 秋田犬 (7)
8. 潘音达犬 (7) 9. 老式英国牧羊犬 (7)
10. 万能犬 (8) 11. 灵缇 (8) 12. 威玛拉娜犬 (8)

(三) 中型犬..... (9)

1. 松狮犬 (9) 2. 巴吉度犬 (9) 3. 拳师犬 (10) 4. 斗牛犬 (10)
5. 西伯利亚爱斯基摩犬 (11) 6. 英国雪达犬 (11)
7. 北海道犬 (12) 8. 纪州犬 (12) 9. 甲斐犬 (13)
10. 四国犬 (13) 11. 长胡牧羊犬 (13) 12. 克伯伦猎犬 (13)
13. 斗牛獾 (14)

(四) 小型犬..... (14)

1. 西藏拉萨犬 (14) 2. 米格鲁犬 (15) 3. 西藏獾 (15)
4. 可卡犬 (15) 5. 腊肠犬 (16) 6. 小雪娜瑞犬 (16)
7. 喜乐蒂犬 (17) 8. 骑士查理王犬 (17) 9. 凯恩獾 (17)
10. 西高地白獾 (18) 11. 贝多林登獾 (18) 12. 波士顿獾 (18)
13. 猎狐獾 (19) 14. 苏格兰獾 (19) 15. 史基獾 (19)
16. 柴犬 (19)

(五) 超小型犬..... (20)

1. 獅子犬 (20) 2. 北京犬 (20) 3. 哈巴犬 (21) 4. 齐娃娃 (21) 5. 约克夏梗 (22) 6. 马耳他犬 (22) 7. 博美犬 (23) 8. 贵妇犬 (23) 9. 蝴蝶犬 (24) 10. 小曼彻斯特梗 (24)

二、犬的饲养管理..... (25)

(一) 犬的饲养..... (25)

(二) 犬的管理..... (32)

(三) 妊娠母犬的饲养管理..... (37)

(四) 仔犬的饲养管理..... (38)

(五) 幼犬的饲养管理..... (41)

(六) 观赏犬的饲养管理..... (45)

三、犬的训练..... (58)

(一) 训练犬的理论依据..... (59)

(二) 训练犬的方法..... (67)

(三) 训练中应注意的几个问题..... (82)

四、犬病的防治..... (84)

(一) 口腔异常、流涎和咽下困难的疾病..... (84)

(二) 下痢和伴有血便、粘液便、
脂肪便的疾病..... (92)

(三) 表现努责、腹痛和便秘的疾病 (103)

(四) 腹部膨大的疾病 (109)

(五) 呕吐和腹部压痛的疾病 (113)

(六) 伴有鼻汁和发咳的疾病 (118)

(七) 出现呼吸困难的疾病	(124)
(八) 心音、脉搏异常和可视粘膜 发绀的疾病	(131)
(九) 排尿异常的疾病	(132)
(十) 骨、关节异常和跛行的疾病	(139)
(十一) 眼的疾病	(144)
(十二) 耳的疾病	(148)
(十三) 产科疾病	(152)
(十四) 出现神经症状和运动麻痹的疾病	(158)
(十五) 贫血和出血性素质疾病	(163)
(十六) 皮肤疾病	(168)

一、犬的品种

犬是最早被人类驯化的家畜之一，至少约在1万多年前就已被驯养了，并使它很好地适应了人类生活环境。犬是人类的忠实伴侣动物。

犬有很多品种，据英国犬学家哈巴德统计，世界上大约有850多个犬种。这些品种有些是因地理、气候等自然条件不同而形成的；有的是因社会经济发展的需要，通过科学方法经人工培育而成的。对犬的品种分类，目前尚无统一标准。现在国际通用犬种约划分6—7类：猎鸟、猎兽、作业、狩猎、牧畜、玩赏、其他。如按现实饲养用途分析，是作业犬和伴侣犬占多数。如按体型大小分，则分为超大型犬、大型犬、中型犬、小型犬和超小型犬。据一些资料记载，被世界公认的犬种有121种。现将犬的主要品种介绍如下。

（一）超大型犬

超大型犬是所有犬中最大的一种。体型大，力大而勇猛，聪明、温顺，忠实于主人，是人类可以信赖的朋友。

1. 大丹 原产地丹麦，大丹的意思即是“丹麦的大狗”。个性温顺，注意力集中，是忠实于主人的护卫犬和看家犬。

仔犬出生重650克，60日左右可达13公斤。5—6周左

右断奶。出生后为柔软的短毛，4—6个月左右第一次换毛，换成有光泽的短而密的被毛。毛色为黄褐色、黑色、黑白花、白底有不规则黑色斑点等。生后3个月左右断耳。

成犬体重为60—70公斤，身高：公犬为70.2厘米；母犬为71.1厘米。被毛短而厚，平滑富有光泽。毛色为黄褐色、虎斑、青色、黑色、黑白色、黄褐色，全身有黑色斑点，吻部呈黑色等。头呈长方形，长而窄，鼻梁骨愈宽愈好。杏眼有神，尾根粗，尾尖细，静止时尾下垂。

2. 圣伯纳犬 原产地瑞士，是使役犬种之一。以救助大雪中迷路旅客而著称，用于看家和救难。过去是短毛犬，现在为长毛犬。个性温顺、聪明，忠实于主人，如何挑逗也不生气。

仔犬出生重650克左右，60日左右可达13公斤。5—6周间断奶。出生后为柔软的短毛，4—6个月左右第一次换毛。分为短毛型和长毛型。短毛型为全身密布短毛，尾和大腿部有少量的长毛；长毛型全身密布中等程度的长毛，尾和大腿部毛色较深。毛色为白地带有红黄褐色斑、红黄褐色地带有白色斑、白地带有虎皮色斑等。一般在嘴的周围、尾尖、前胸和足部伴有白色。

成犬体重为80—90公斤。公犬身高为69.8厘米，母犬为64.7厘米。毛质稠密、光滑，毛色同仔犬，个别的有吻白，在颜面中心通至额头。头大且宽，头顶略呈圆形，有一点突出。鼻梁短而直，鼻尖大，呈黑色。眼略小，下陷，两眼距离宽。尾根高，尾长而下垂。

3. 俄国牧羊犬 又名波索犬，属于猎犬之一。原产地苏联。个性感觉敏锐，胆大，富有高雅的气质和风貌。属看家犬、玩赏犬、猎犬。

仔犬出生重600克左右，60日可达10公斤。5—6周、右断奶。出生后为柔软的短毛，随着生长而变长。4—6个月第一次换毛，头部、耳部、前肢的前部和后肢的飞节以下为光滑的短毛，其他部位则为长而美丽的绢丝状毛。毛色有各种各样的颜色。

成犬体重为40—55公斤。公犬身高为71.1厘米；母犬为66厘米。被毛呈绢丝状卷曲的长毛，头、耳和四肢的前面为平滑的短毛，颈、胸部、后躯及尾部有密而美丽的饰毛。头窄且长，鼻梁窄、直而细长。耳小，向后方倾斜，兴奋时向前方呈半立状。毛色为白地，褐、黄褐、灰、黑色斑等。眼睛略斜，眼眶呈黑色者为佳。尾长，有饰毛，保持优雅的低垂状。

4. 马士迪夫犬 又名獒犬、西藏獒。原产地中国西藏，后由腓尼基人运至英国繁殖。可作为看家犬、斗犬，亦可用于军犬。个性勇敢、温顺，忠实于主人。成犬体重为75—95公斤，公犬身高为76.2厘米以上，母犬为69.8厘米以上。被毛为平滑的短毛，上毛粗，下毛短而密。毛色为银虎斑色、黄褐虎斑色、黑虎斑色以及杏色等。眼大小适中，色暗者为佳。

5. 大白熊犬 又名比里牛斯山犬。原产地西班牙比里牛斯山脉。个性温顺、忠实，与狼和熊搏斗时，十分勇敢、镇静。是大型美丽的看家犬，也可作拖运犬。成犬体重，公犬为45.3—56.7公斤，母犬为40.8—52.1公斤。公犬身高68.5—81.2厘米，母犬为63.5—73.6厘米。被毛分为上毛和下毛，上毛粗而厚，下毛柔软密生。毛色为白色、白地头部有黄褐色斑、灰色斑等。尾部有饰毛。

6. 土佐犬 又名日本打斗犬。原产地日本四国地方。

是巨大斗犬之一，也可用于看家。个性沉着冷静，具有强忍耐力，胆大而有勇气，忠实和顺从于主人。成犬体重，公犬为48公斤以上，母犬比公犬稍轻些。身高为67—73厘米。被毛富有光泽，为密布全身的坚硬短毛。毛色为红色、红黄褐色、红黄褐色地白斑、白地红黄褐色斑，嘴呈黑色。

（二）大型犬

大型犬用途十分广泛，可作为警犬、军犬、猎犬、看家犬、牧羊犬、作业犬、导盲犬以及赛犬。是最受养犬者所喜欢的犬种。

1. 狼犬 又名德国牧羊犬。原产地德国。过去为牧羊犬，由于有计划的繁殖选育，已成为今日的优秀狼犬，驰名于世界，是优秀犬种之一。可作为警犬、军犬，也可用于导盲。个性勇敢，嗅觉敏锐，有强的观察力、记忆力、忍耐力，并且具有正确的判断能力，忠实于主人。

仔犬出生重为400克左右。5—6周断奶。60日可达8公斤。生后为柔软的短毛，随着生长而变长。4—6个月第一次换毛。被毛分为上毛和下毛。上毛为直而坚固的长毛，下毛为柔软的短毛，头及四肢下部毛短。毛色为黄褐色、褐色、黑色、黑褐色和狼灰色等。

成犬体重为30—40公斤。公犬身高为60.9—66厘米，母犬为55.8—60.9厘米；典型毛色为黑背黄腹色，其他同仔犬。头部额略宽，中央呈水平状，额沟明显可见。鼻梁直，唇宽，嘴长且有力。杏眼，大小适中，色暗。尾巴长度至飞节部，被毛密生，静止时呈刀状下垂，兴奋时会直立。如有卷毛则为缺点。

2. 拉布拉多猎犬 原产地英国。是加拿大拉布拉多半

岛的本地犬，1822年被引到英国，经过改良繁殖，1903年被公认为新犬种。个性机智、灵敏，嗅觉锐敏，非常活泼，猎性好。十分忠实和顺从主人。可作为猎犬、看家犬、导盲犬。

仔犬出生重为400克左右。60日可达8公斤。5—6周断奶。生后为柔软的短被毛。生长至4—6个月第一次换毛。毛色为黑色、黄色、巧克力色等，若有杂色斑则不佳。

成犬体重，公犬为27.2—34公斤；母犬为24.9—31.7公斤。公犬身高为57.1—62.2厘米，母犬为54.6—59.6厘米。被毛毛质及毛色同仔犬。头宽，前额平，头部略大。鼻梁长，鼻尖宽，鼻孔大。嘴长力强。耳根在头的后方，小而且宽，垂于面颊的后方。眼睛大小适中，色以黑色或褐色为好。尾巴粗而且长，上扬时不超过背线。

3. 阿富汗犬 原产地阿富汗。是灰犬种中最大的一种。1907年在英国犬展中首次亮相。个性聪明、沉着、机智。具有特殊的风貌，精悍的“奔驰”的体型，是特别美的犬种。

仔犬出生重450克左右。5—6周左右断奶。60日可达6.5公斤。生后为柔软的短毛，随着生长而变长，10—18个月第一次换毛，全身被满柔软如绢丝状的长毛，脸上为密而短的毛，头、耳、足部毛更长。毛色较多，有金色、奶油色、黄褐色、黑褐色、灰色等。

成犬体重为27—33公斤。公犬身高68.5厘米，母犬为63.5厘米。头盖骨长但不窄，后头部隆起。鼻梁直而长，鼻孔大，鼻端呈黑色。眼呈三角形，眼角略上扬。耳朵下垂，紧贴于面颊。前脚直立，后脚、后腿及胫部长，肌肉发达。尾根低，被以长毛，尾的后三分之一上扬。毛质及毛色同仔

犬。

4. 笃宾犬 又称杜博文警犬。原产地德国，是使役犬之一。是勇敢机敏犬种，具有正确判断力，能够守卫主人的财产。个性敏锐、忠实、聪明、胆大。嗅觉灵敏，记忆力极强。可作为警犬、军犬，为养犬爱好者所欣赏的犬。

仔犬出生重为400克左右。5—6周时断奶。60日可达8公斤左右。生后为柔软的短毛，5—6个月时第一次换毛，换为坚硬密生的短直毛，光滑明亮。毛色为黑色、红黄褐色、淡黄褐色、蓝灰色等，前胸部有白色毛者不良。有断耳、断尾习惯，必须断耳使其竖立。一般在生后3个月左右断耳，生后3—7日断尾。

成犬体重为22—30公斤。公犬身高66—71.1厘米，母犬为60—66厘米。头呈长楔形，鼻梁与额平行，鼻端呈黑色。嘴深长，下颌力强。眼呈黑褐色或褐色。四肢肌肉发达，后肢跳跃力强。毛色为黑色，或褐色带黄褐色斑。断尾时由根部切断，仅留5厘米以内。

5. 牧羊犬 原产地英国苏格兰。牧羊犬分为长毛牧羊犬和短毛牧羊犬。牧羊犬个性锐敏，忠实，温顺，智力强，气质高雅。具有惊人的牧羊技能，是理想的牧羊犬。

仔犬出生重为400克左右，60日可达7公斤左右。4—6个月左右第一次换毛，长毛种下毛为柔软密生的短毛，上毛除头和足以外为长的刚毛；短毛种下毛为柔软的短毛，上毛为粗硬的短毛。毛色为白黄色、白黑色、黄褐白色等。

成犬体重，公犬为27.2—34公斤，母犬为22.6—29.4公斤。公犬身高60—66厘米，母犬为55.8—60.9厘米。毛色有各种颜色，以黑褐色地，颈毛纯白色为最优良犬。头呈楔形，鼻梁直，以笔直者为佳。眼呈杏形，明亮，眼球为暗褐

色。尾巴长，静止时低垂于两腿之间。

6. **大麦町犬** 又名斑点犬。原产地南斯拉夫。记忆力强，有耐久力，适于赛跑。体格健壮，防卫本能发达，是理想的看家犬。也可作为猎犬、拉车犬、军犬等。体重为20—27公斤。身高为55—63厘米。毛质为短而稠密的平滑的硬毛。毛色为全身纯白，有黑色与褐色斑点，黑色斑呈小圆形，斑色愈浓者愈佳，褐色斑者，不允许有其他色斑存在。尾呈鞭状。

7. **秋田犬** 原产地日本大馆地方。该犬沉着、顺从、活泼、聪明，是忠实的犬种，为理想的护卫犬。也可作为看家犬、斗犬、猎兽犬、玩赏犬。成犬体重为35—45公斤，身高为58—70厘米。毛质为短而柔软密生的下毛和稍硬且直的上毛。毛色为胡麻、红色、淡红色、黑色、虎皮色以及白色等。

8. **潘查达犬** 又名英国波音达犬。原产地英国。嗅觉非常锐敏，当嗅到猎物时，以鼻子、身躯和尾呈一直线指向目标为其特征。步伐快，忍耐力强，聪明，温顺，擅于游泳。可作为看家犬、猎犬。全身被以密生而硬的短毛。毛色为白色、柠檬色、橙黄色、红褐色、黑色斑。成犬体重，公犬为24.9—34公斤，母犬为20.4—29.4公斤。公犬身高63.5—71.1厘米，母犬为58.4—66厘米。

9. **老式英国牧羊犬** 原产地英国，是牧羊犬种之一，擅于将迷失的牛、羊追回。可作为牧羊犬、看家犬、玩赏犬。个性聪明，性情温顺，勇敢，速度快，耐寒力强。1865年初次在狗展中登场。头非常大，稍呈正方形，灰白色眼睛是其特征。耳垂于头的侧方，被以长的饰毛。毛质为适当硬度的上毛和细而柔软的下毛。毛色为灰色、蓝灰色，有的有

白斑或蓝灰色白斑。成犬体重为36—40公斤。公犬身高55.8厘米以上，母犬稍低于公犬。

10. 万能犬 又名亚雷特梗。原产地英国。是梗犬中最大的一种。个性机智、聪明，具有锐敏的视觉、听觉和嗅觉。适应力、记忆力均强。可作为看家犬、警犬、军犬、猎犬。头长而平，两眼间距窄。鼻梁长，呈长方形，鼻端呈黑色。嘴长力强，眼大小适中。有断尾习惯，生后3—7日断尾，断去三分之一。被毛呈细针状粗刚毛，下毛柔软密布全身。毛身为黑色和黄褐色、铁灰色和黄褐色；头部、耳、前胸和躯干下部，四肢和尾的腹侧为黄褐色。有的犬前胸有小白斑。成犬体重为20—27公斤。公犬身高58.4厘米，母犬比公犬稍低些。

11. 灵捷 又名格利犬、大灰狗。原产地埃及。由埃及输入到英国，被称为 Graius，在英国繁殖而成。该犬速度快，在沙漠中狩猎小动物，擅长狩猎野兔、鹿、狼等。个性温和聪明，嗅觉敏锐，善于发现猎物。因跑得快而成为赛犬，也可作为看家犬。头狭长，鼻梁直，鼻端呈黑色。嘴长，尖端细。耳小且薄，保持向后方倾斜，兴奋时向前方直立。尾巴细而长，下垂。被毛为美丽而平滑的短毛。毛色为黑色、灰白色、白色、黄褐色等。成犬体重为29—35公斤，身高为60—65厘米。

12. 威玛拉娜犬 原产地德国的威玛地方。原为威玛宫廷犬，在宫廷内繁殖，为足不出户的犬种。1929年时才输入到美国。个性活泼，敏锐，胆大。既可狩猎，也可搬运猎物。可作为看家犬、猎犬。头略长，鼻梁直，鼻端呈灰色。上唇延伸至两颧。耳长且宽，上部略大，垂于两颊的后方。眼睛明亮，呈琥珀色，有的呈蓝灰色。尾巴粗且长，有断尾习惯，断尾五分之三。被毛为富有光泽、平滑的短毛。毛色

为银灰色、黄灰色。成犬体重为24—34公斤，身高为57—67厘米。

(三) 中型犬

中型犬在家中饲养，平均体重为11—13公斤，身高为41—60厘米。中型犬种类很多，分布在世界各地，如在中国北方寒冷平原的松狮犬，状似小鹿；身轻如燕的惠比特犬；有悠久历史的斗牛犬；擅于狩猎的巴吉度犬；适于作警犬的拳师犬等。

1. 松狮犬 又名熊狮犬。原产地中国，是一种古老犬种，已有3千年历史，在中国北部地方饲养。1987年输入到英国，被称之为“翘翘”。该犬嗅觉敏锐，体力强，胆大，机敏，对主人忠实。可作为看家犬、玩赏犬。

仔犬出生重为300克左右。5—6周断奶。60日可达6公斤。生后为柔软的短毛，随着生长而变长。4—6个月第一次换毛，换成上毛略粗且长，下毛柔软而密，毛丰富且密，是这种犬的独特被毛。毛色为黑色、白色、黄褐色、红色、茶褐色等。

成犬体重为25—30公斤。公犬身高50—60厘米，母犬比公犬稍低。头大，头盖骨宽且平，鼻梁短而宽，鼻端大，呈黑色。耳小，呈三角形。嘴短而宽，上唇盖住下唇，舌头表面呈紫黑色是本犬的特征。眼小，下陷，色暗。尾根高，紧紧地卷于背上。

2. 巴吉度犬 又名巴斯克提。原产地德国。在法国、比利时，因为擅长追踪鹿、兔、山雉，被人们所喜爱。这种犬为体长腿短的体型，犬名巴吉度即法语“矮个子”的意思。个性温顺，嗅觉极锐敏，忠实于主人。可作为玩赏犬、看家

犬、猎犬。

仔犬出生重300 克左右。5—6 周断奶。60日可达6 公斤。生后为柔软的短毛，4—6 个月左右第一次换毛，全身密布硬而短的毛，毛色为白色、黑褐色、黄褐色等。

成犬体重为20—30公斤。身高公母犬均为30—35厘米。头部大且长，前额有深的皱纹。鼻梁直，鼻端大，呈黑色。嘴长有力。耳特大且宽，下垂超过鼻端。尾粗且长，直立稍弯曲。毛色头部、躯干和尾等部位大部分为黑和黄褐色、吻部、胸部、四肢、尾的尖端等部位，多数为白地黄褐色斑犬，白地黑斑犬、白犬。也有黑色和褐色犬。

3. 拳师犬 原产地法国。该犬在搏斗开始擅于使用前脚，似人类拳击师，因此而得名拳师犬。个性机敏、勇猛、力强，服从性高，忠实于主人。可作为警犬、军犬、看家犬。

仔犬出生重400 克左右，5—6 周断奶。60日可达7 公斤。生后为柔软的短毛。4—6 个月左右第一次换毛，毛质为密布全身的、富有光泽的短毛。毛色为黄褐色，有虎斑。生后3—4 个月进行断耳。生后3—7 天断尾。

成犬体重为25—30公斤。公犬身高57.1—63.5厘米，母犬为53.3—59.6厘米。头与口的比例适中，脸上有皱纹，并有黑面罩。白鼻心，鼻端高于鼻根，颊部发达。耳心须整形，修成垂直立耳。断尾四分之三。毛质与毛色同仔犬，但虎斑纹清晰、胸与足尖为白色者为佳。

4. 斗牛犬 原产地英国。具有特异的体型，体大结实，肩宽，颈部短粗，两腿间宽阔。过去勇敢、凶猛；如今温顺，忠实于主人。可作为看家犬、玩赏犬。

仔犬出生重250克左右，5—6 周断奶。60日可达5.5公

斤。生后为柔软的短毛，4—6个月左右第一次换毛。换成富有光泽、平滑、密而短的毛。毛色为淡褐色、虎斑色、虎斑与白色、红褐色等。

成犬体重，公犬约为22.6公斤，母犬约为18.4公斤。身高35—45厘米。头非常大而短，嘴短。耳呈玫瑰花瓣形，小而薄，两耳距离越宽越好。眼睛呈圆形。前腿短，骨粗且弯曲。尾巴短，尾根粗，尾尖细。

5. 西伯利亚爱斯基摩犬 原产地苏联。个性勇敢，力强，刚毅，富于活动性，持久力超群。可作为看家犬、雪橇犬。

仔犬出生重约300克。5—6周断奶。60日可达6公斤左右。出生后为柔软的短毛，4—6个月第一次换毛，换成柔软很密的下毛和密布全身中等长度稍柔软的上毛。毛色为各种各样颜色。

成犬体重约22公斤。公犬身高53.3—59.6厘米，母犬为50.8—55.8厘米。毛色从黑色到纯白色和各种花纹。目前可见到黑色系的犬，多数在吻部、颊部、前胸、尾部和臀部有白色毛。

6. 英国雪达犬 原产地英国。1859年初次举办雪达犬展。雪达的命名是因为它到了猎物前便坐着不动之故。个性温和、聪明。嗅觉锐敏，活泼好动。可作为看家犬、猎鸟犬。

仔犬出生重为400克左右。5—6周断奶。60日可达8公斤左右。出生后为柔软的短毛，随着生长而变长。4—6个月换毛，头部和四肢的前面为短毛，其他部位生长密密的长毛，四肢的后面有长的饰毛。毛色为黑色、白色、白地黑色、白地柠檬色、白地红褐色等。

成犬体重为25—35公斤。公犬身高63.5厘米，母犬为60.9厘米。头盖骨呈长方形，鼻梁直而长，鼻端大，呈黑色。口呈方形。耳下垂，有饰毛。尾巴长至飞节部，尾的腹侧有三角形旗状美丽的饰毛。毛色同仔犬。

7. 北海道犬 又称爱奴犬。原产地日本北海道地方，是日本中型犬。个性勇敢，感觉敏锐，胆大，忠实于主人，温顺，家性强。因为生于寒带，被毛密。可作为看家犬、猎犬。

仔犬出生重250 克左右。5—6 周左右断奶。60日可达5 公斤左右。生后为柔软的短毛，随着生长而变长，4—6 个月第一次换毛，上毛为略微坚硬的直毛，下毛为柔软密生的厚毛。毛色为红色、红褐色、白色、胡麻色、黑地黄褐色斑等。颜面部和四肢部被毛短，尾巴毛长且厚。

成犬体重为16—20公斤。公犬身高49—55厘米，母犬为46—52厘米。额宽大且平，颊部十分发达。头的长度和颊部宽度相等者为佳。鼻梁直，鼻端黑，唇和舌多数为黑色。唇紧闭，外黑。眼睛小，呈三角形。尾粗，力强，呈卷尾或半卷尾。毛色为红色乃至红褐色、白色、胡麻色、虎皮色、黑色以及黑地黄褐色斑等。眼圈、耳根周围、吻部、颊部、胸部、四肢下部、肛门周围和尾的背侧呈黄褐色。

8. 纪州犬 原产地日本。以产地分为熊野犬、太地犬和月高犬。个性勇敢，机敏，聪明，嗅觉锐敏，富有警戒心，对主人忠实。可作为看家犬、猎犬。

仔犬出生重280 克左右。5—6 周断奶。60日后可达5 公斤左右。出生后为柔软的短毛，随着生长而变长。4—6 个月第一次换毛，换成柔软密生的下毛，长度适中，坚硬且直的上毛。颜面和四肢的毛短，尾巴毛长且丰富。毛色为红

色乃至红黄褐色、白色、虎皮色、胡麻色、黑地黄褐色斑等。

成犬体重为16—23公斤。公犬身高为49—55厘米，母犬为46—52厘米。头盖较大，头顶平，有额沟。鼻梁直，鼻端小，以黑色者为佳。嘴尖而短，唇紧闭呈黑色。眼略呈三角形，虹彩为浓褐色。尾巴力强，呈卷尾或半卷尾。毛色同仔犬。

9. 甲斐犬 原产地日本山梨地方。腿部力量非常强，在山岩上狩猎羚羊、野猪、熊等。此犬的特征是均为虎斑毛色。个性勇敢，性温和，听觉、视觉锐敏，忍耐力强，富于警戒心，忠实于主人。可作为看家犬、猎犬。

成犬体重为14—20公斤。公犬身高为49—55厘米，母犬为46—52厘米。毛质略粗，上毛坚硬，下毛柔软密生。毛色为黑虎皮色、红虎皮色等。

10. 四国犬 原产地日本，是日本中型犬之一。个性锐敏，步伐轻快。可作为看家犬、猎犬。成犬体重为15—20公斤。公犬身高49—55厘米，母犬为46—62厘米。该犬具有柔软密生的下毛和坚硬、直的上毛。毛色为红色乃至红黄褐色、白色、胡麻色、虎皮色等。四国犬大多数为胡麻色，分为白胡麻色、红胡麻色和黑胡麻色等。

11. 长胡牧羊犬 原产地英国，是牧羊犬之一。个性温和，可作为牧羊犬。该犬具有柔软而短的下毛，全身密生长的上毛。这种犬的特征是胡须密生。公犬身高53.3—55.8厘米，母犬为50.8—53.3厘米。毛色为黑色、淡红黄褐色、黑褐色等，耳的内侧、眉毛、颊部、吻部、尾的腹侧、四肢的一些部位有淡黄褐色斑。

12. 克伯伦猎犬 原产地英国。可作为看家犬、猎犬。成犬体重，公犬为31.7—38.5公斤，母犬为24.9—31.7公

斤。公犬身高48.2—50.8厘米，母犬为43.2—48.2厘米。毛质为中等长度的绢丝毛，密布全身，但头部、前肢前面和后肢的飞节以下部分为短毛。相反，胸部、前肢的后侧面有丰富的饰毛。毛色为白色、白地柠檬色斑或白地橙黄色斑等。

13. 斗牛獒 原产地英国。个性活泼，机敏，胆大，忠实于主人，但性情急躁。可作为看家犬。成犬体重为18—28公斤。身高为48—56厘米。头盖长，平直。鼻梁直，鼻端呈黑色。小三角眼，以暗色者为佳。被毛短且硬，富有光泽。毛色为纯白色、虎斑色、黑色混有白色、虎斑色混有白色。纯白色者，头上可以有斑。

（四）小型犬

小型犬是玩赏犬之一。是专门作为家庭宠物的小型室内犬。犬种繁多，具有明朗的性格和风采，外形可爱，可称之为家庭犬。

玩赏犬起源不同，各国的稀奇小型犬因风土驯化而各具特色。如北京犬、马尔济斯犬、西施犬、腊肠犬和可卡犬等。

小型犬体重10公斤左右，身高以40厘米为限。饲养在室内，设置室内犬舍，放置在随时可以看到的地方。

1. 西藏拉萨犬 又名拉萨亚布苏犬。原产地中国西藏。个性非常聪明，听觉特别灵敏，是室内的优良犬种。可作为玩赏犬。

仔犬出生重为150克左右，生后5—6周断奶。60日可达1.5公斤。生后为柔软的短毛，随着育成而变长，在4—6个月第一次换毛，换成多量柔软短的下毛，硬而直的十分

长的外毛，为多种毛色的犬种，有黑色系、黄色系和褐色系以及白色毛等。

成犬体重为4.1—6.2公斤。公犬身高为25.4—27.9厘米，母犬比公犬稍小。毛色为金黄色、砂色、蜂蜜色、浓青灰色、石板色、茶色、黑色、白色、褐色等。毛质同仔犬。

2. 米格鲁犬 又名比高犬，是英国小型猎兔犬。是猎犬中最小的一种。米格鲁是法语“小家伙”的音译。擅长猎兔。1880年引入美国，在实验工作上贡献极大。个性活泼，嗅觉锐敏，小而可爱。可作为玩赏犬、看家犬、猎兔犬、实验用犬。

仔犬出生重200克左右，5—6周时断奶。60日可达2.5公斤。生后为柔软的短毛，4—6个月第一次换毛，换成全身坚硬的短毛。毛色为白色、黄褐色、灰色等。

成犬体重7.0—10公斤，身高30—40厘米。头盖骨长短适中，后头部略呈圆形。鼻梁直，鼻孔大，鼻端呈黑色。嘴前端略呈方形，耳宽大，下垂。眼睛比较大，眼球呈暗褐色。尾巴粗而长，保持高立姿势。

3. 西藏獾 原产地中国西藏。该犬嗅觉灵敏，行动灵活，依恋性强。可作为玩赏犬。

仔犬出生重250克左右。生后5—6周断奶。60日可达2.5公斤。生后为柔软的短毛，生长到4—6个月第一次换毛，换成柔软短的羊毛状下毛和长的外毛。毛色有白色、金色、灰色、烟色和黑色等。

成犬体重6.1—13.6公斤，身高35.6—40.6厘米。被毛的毛质和颜色同仔犬。

4. 可卡犬 原产地美国。是小型而美丽的犬种。个性活泼、聪明、温顺。可作为玩赏犬、看家犬、猎鸟犬。

仔犬出生重230克左右。5—6周断奶。60日可达3公斤左右。生后为柔软的短毛，随着生长变长，4—6个月开始换毛，换成绢丝状长的上毛和短而柔软的下毛。毛色多样。生后3—7日断尾。

成犬体重为7—10公斤。身高：理想的公犬为38.1厘米。母犬为35.5厘米。头盖呈圆形。鼻孔十分发达，鼻子分为黑褐两色。嘴宽，上唇下垂。杏眼。耳长，耳的长度超过鼻尖者为佳。尾需断去三分之二。头部为短毛，全身为长毛，略卷曲。耳部、胸部、腹下和四肢的后侧有饰毛。毛色为黄褐色、黑褐色、淡黄色、奶油色、黑色等。

5. 腊肠犬 又名猎獾犬，獾。原产地德国。个性聪明、锐敏、嗅觉强、勇敢，忠实于主人。可作为玩赏犬、看家犬、猎犬。

仔犬出生重150—250克。5—6周断奶。60日可达3—5公斤。出生后为柔软的短毛。4—6个月第一次换毛。毛色为黑色、巧克力色。吻部、两眼上方、前胸部、足尖及肛门周围呈黄褐色。

成犬分为小型、中型和大型。小型体重2—5公斤，中型为5—8公斤，大型为8—10公斤。身高：小型为13—20厘米，中型为20—25厘米，大型为25厘米以上。头呈弓形，鼻梁长且细，鼻端呈黑色。眼呈椭圆形，略凹。体躯长，短腿。尾巴细长，达于地面。毛质不一，有的为短毛且硬，富有光泽；有的为柔软的长毛，富有光泽；有的为厚厚的细毛。毛色为黑褐色、茶褐色、红色、红色毛尖黑等。

6. 小雪娜瑞犬 又名迷你型史劳策犬、小史柔查犬。原产地德国。个性聪明、勇敢，忠实于主人。喜欢接近儿童，为小孩之良伴。可作为玩赏犬、看家犬、警犬、军犬

等。

仔犬出生重200克左右。5—6周断奶。60日可达2公斤。生后为柔软的短毛，随着生长而变长。生后4—6个月第一次换毛，换成硬的针状长毛和柔软的密而短的下毛。毛色为黑色、灰色等。

成犬体重为6—8公斤。公母犬身高均为20.4—35.5厘米。头呈长方形，鼻端呈黑色。耳根高，必须断耳，生后2—3个月断耳。眼小，呈圆形。生后3—7日断尾。毛色为黑色、黑褐色，代表色为灰色。

7. 喜乐蒂犬 又名小型苏格兰牧羊犬。原产地苏格兰。该犬温顺，理解力强，感觉锐敏。可作为玩赏犬、看家犬和牧羊犬。

仔犬出生重约200克。5—6周左右断奶。60日可达2.5公斤左右。生后为柔软的短毛，随着生长而变长。4—6个月第一次换毛，换成柔软而短的下毛和头部、腿部以外的长刚毛。毛色为黑褐色、褐色、青蓝色等。

成犬体重为6—7公斤，身高为33—40厘米。头盖平，鼻梁长而细，鼻端呈黑色。杏眼，嘴细长，耳小。被毛的上毛长而粗，下毛短，柔软密生。毛色同仔犬。

8. 骑士查理王犬 又名查理王小猎犬、格飞利亚獾。原产地英国。个性温顺活泼，嗅觉锐敏，适于狩猎。可作为玩赏犬、狩猎犬。

成犬体重为7—10公斤。身高为30—40厘米。被毛呈绢丝状富有光泽的长毛。略卷曲。头部毛短。毛色为黑褐色、黑色、褐色、白色、栗色等。

9. 凯恩梗 又名石堆梗犬。原产地英国的苏格兰。个性勇敢，嗅觉特别灵敏，忠实于主人。不沉着，善吠。可作

为玩赏犬、看家犬。

仔犬出生重为180克左右。5—6周左右断奶。60日可达1.8公斤。生后为柔软的短毛，随着生长而变长，生后4—6个月第一次换毛，换成粗而硬的长上毛和柔软而短的下毛。原为短尾犬种。

成犬体重，公犬为6.3公斤，母犬为5.9公斤。公犬身高25.4厘米，母犬为24.3厘米。头盖短且宽，鼻梁直，鼻端呈黑色。唇宽，呈黑色。长眉毛。毛色为红褐色、灰色、黑色、黑地红褐色、灰的混合色等。

10. 西高地白梗 原产地英国西高地地方。1880年由马克先生将凯恩梗改良为白色，繁殖出纯白的新犬种。该犬为狩猎好手，速度快，效率高。个性活泼，理解力强，忠实于主人，具有华丽的被毛。可作为玩赏犬、看家犬。

仔犬出生重为250克左右。生后5—6周断奶。60日可达2.5公斤。出生后为柔软的短毛，随着生长而变长。生后4—6个月第一次换毛，换成下毛为柔软密生的短毛，上毛为粗而硬的直立长毛。毛色全部为白色。

成犬体重为5.5—9公斤。公犬身高27.9厘米，母犬为25.9厘米。头顶呈圆形，鼻梁略长且直，鼻端呈黑色，嘴呈方形，唇黑，耳呈小三角形，向前直立。尾向上直立。

11. 贝多林登梗 又名百灵顿梗、贝林登梗。原产地英国的贝多林登市。个性极温顺，忠实于主人。可作玩赏犬、猎犬。成犬体重为8—10公斤。公犬身高41.9厘米，母犬为39.3厘米。毛质厚，有独特的绵毛。毛色为暗蓝色、砂色、红褐色、黄褐色、土砂色等。头后生有冠毛，冠毛比体毛色淡。尾根粗、尾尖细。

12. 波士顿梗 原产地美国波士顿市。个性温和、聪

明、沉着，忠实于主人。在美国是最受人喜爱的犬种。可作为玩赏犬。成犬体重为7—10公斤，身高为30—40厘米。被毛短而平滑，富有光泽。理想毛色为虎斑色加白斑，白颈圈，前胸白，前脚、后脚飞节以下均为白色。生后2—3个月断耳。

13. 猎狐梗 原产地英国。个性聪明，活泼，胆大，嗅觉锐敏，精力充沛，有一点暴躁。可作为玩赏犬、看家犬、小猎犬。成犬体重为7—10公斤，身高为35—40厘米。生后4—6个月第一次换毛，上毛呈针状，粗硬，下毛为密生硬而短的毛。尾巴向上直立，生后3—7日断尾。

14. 苏格兰梗 原产地英国的苏格兰。为短脚梗之一，是苏格兰国犬。个性活泼、温顺、聪明、胆大，忍耐性强，忠实于主人。成犬体重为8—10公斤，身高为20—30厘米。上毛坚硬直立，下毛柔软密生，其特征是长胡须。毛为黑色、灰色、小麦色、褐色。尾粗直立向上。

15. 史基梗 又名斯开岛梗。原产地英国。在欧美国家被多数爱犬者所喜爱，在日本为珍奇犬种。成犬身高，公犬为20.3—25.4厘米，母犬为19—24.1厘米。上毛为硬直的长毛，下毛为柔软的短毛。毛色黑色、青黑色、灰色、白色、浅黄褐色等。

16. 柴犬 原产地日本。警惕性高，忠实于主人。可作为玩赏犬、看家犬、猎犬。成犬体重为6—10公斤。公犬身高38.4厘米，母犬为35—38厘米。上毛坚而直立，下毛柔软。头部和足部毛短，尾巴毛稍长。毛色为红色、红褐色、黑地黄褐色斑、白色等。

（五）超小型犬

超小型犬是玩赏犬中最受人们欢迎的犬种，是饲养在室内的犬，体格特小，如齐娃娃犬，可以放在口袋内，因此，以“袋犬”而闻名。体型美观、卷毛、长毛如绢，如约克夏犬、中国的西施犬，美丽大方，颇受犬主的喜欢，可以放在卧室、客厅中。体重以4公斤为限，身高约在25厘米左右。

1. 狮子犬 又名西施犬。原产地中国。是拉萨犬和北京犬交配所生。该犬由于姿态形如雄狮而得名。个性活泼，非常聪明，气质好。适于作玩赏犬、室内看家犬。在世界上享有盛名。

仔犬出生重为150克左右，生后5—6周断奶。60日可达1.2公斤。初生时为柔软的短毛，随着生长毛则变长。

4—6个月第一次换毛，换成柔软密而短的下毛和长的具有波纹的丰富的外毛，头部的长毛垂于两耳前。毛色为黄褐色和白色、黑和白色、灰和白色以及各种颜色等。

成犬体重公母犬均为4—8.1公斤，身高为20.3—27.9厘米。头盖骨宽，呈圆形，两眼距离宽。鼻梁短，鼻端宽呈黑色。口唇呈方形且短。眼大且圆，色暗，不突出。长身短脚。毛色和毛质同仔犬，额头有白和尾尖有白毛者为佳。

2. 北京犬 原产地中国。是中国最早的犬种，长期饲养在皇宫内，保持着纯血统。其美丽的容貌颇受人们宠爱。个性聪明，气质高雅，爱撒娇，个性强，容易翻脸。可作为玩赏犬。遍及世界各地，是世界有名的中国犬。

仔犬出生重150克左右，生后5—6周断奶。60日可达1.2公斤重。生后为柔软的短毛，随着生长而变长。4—6个月左右第一次换毛，换成密的下毛和粗直而柔软的长毛，

颜面部被覆短毛，颈部毛长且丰富，长达肩部。腿、尾、脚饰以长毛。毛色为多色品种。

成犬体重为3.6—5.5公斤，身高约为23厘米。头大，嘴宽而短，额深，鼻梁短，眼大且圆，突出，色暗，四肢短。成犬毛色有红色、金黄色、奶油色、黑色和白色等。以颜面黑色者最受人们喜爱。

3. 哈巴犬 又名斧头犬、八哥犬，在德国又称摩浦斯、摩浦斯猎犬，意思是皱着脸的犬。原产地中国。该犬头部如斧头（“八哥”拉丁语为“斧”的意思），因而得名。性聪明温顺，爱撒娇。在国外颇受贵妇人们的喜爱。可作为玩赏犬。

仔犬出生重为200克左右。生后5—6周断奶。60日可达2.5公斤重。生后为柔软的短毛。4—6个月第一次换毛，换成纤细的短毛和有光泽的被毛。毛色为银色、杏色、淡黄褐色、黑色等。如体毛为黑色以外的毛色，在吻部、两颊、前额、两耳等部为黑色。

成犬体重公母犬均为6.3—8.1公斤。身高约26—28厘米。头呈四角形且大，脸部皮肤形成皱襞，愈皱越好。鼻梁极短，鼻端呈黑色。唇呈四角形，宽大，上唇下垂。两眼分离，眼大且圆，向外突出。尾向上卷起，双重卷者为好。被毛为具有光泽密生的短毛。毛色同仔犬。如在背线上有黑色的斑纹者称斧斑，该犬较佳。

4. 齐娃娃 原产地墨西哥。是世界上最小的犬。是玩赏犬中最可爱的一种。个性灵敏，富有感情，聪明。分为长毛和短毛两种。可作为玩赏犬。

仔犬出生重为70克左右。生后5—6周断奶。60日可达500克重。生后为柔软的短毛。4—6个月左右第一次换毛，

换成具有光泽密生的短毛；长毛种则换成柔软且直的长毛。毛色多样。

成犬体重公母犬均在2.7公斤以内。身高为15—20厘米。头盖圆，面颊、下颌肉少，鼻尖小上翘，颜色以暗色为好。眼圆睁，两眼距离宽。耳大且直立，薄。尾呈圆柱状，向上翘，略卷。毛色一般为白色、浅褐色、巧克力色、棕色、柠檬色、黑褐色、黑色等，人们喜欢白地黑色斑、白地茶色斑等。

5. 约克夏梗 原产地英国的约克郡。该犬个性温顺，服从主人，感情丰富，胆大。可作为玩赏犬，颇受犬主的宠爱。

仔犬出生重为100克左右。生后5—6周断奶。60日可达700克重。生后的柔软的短毛，随着育成而变长，4—6个月左右换毛。换成柔软、富有光泽、光滑的绢丝状长毛。毛色为黑地黄褐色斑或黑褐色短毛。生后3—7日断尾，去掉1/3。

成犬体重公母犬均不超过3.18公斤。身高为18—20厘米。头比较小，呈圆球形。眼大小适中，不外突，眼眶为黑色。耳呈小三角形，直立。毛色为灰蓝色或蓝茶褐色。长毛出现美丽的光泽和长毛触地，需2—3年时间。以1.8—2.3公斤的中等体型犬最受欢迎。

6. 马耳他犬 又名马尔济斯犬。原产地地中海的马耳他岛。个性聪明文雅，感情丰富，活泼好动。是历史悠久的白色玩赏犬之一。在世界各地广泛存在，被犬主所喜爱。

仔犬出生重为100克左右。在5—6周左右断奶。60日可达800克重。出生后为柔软的短毛，随着育成而变长，4—6个月左右第一次换毛，换成全身被以绢丝状美丽的长

毛，无下毛。毛色为纯白色，耳朵上有淡黄色斑。

成犬体重公母均在3.1公斤以内，身高为20—25厘米。头略呈圆形，口唇长度适中，鼻端和唇为黑色，眼睛色暗，眼眶呈黑色。耳下垂，有浓密的长毛，身上无体臭。

7. 博美犬 又名丝毛犬、松鼠犬。原产地德国。个性活泼聪明。叫声如钟鸣。可作为玩赏犬、看家犬。

仔犬出生重为100克左右。生后5—6周断奶。60日为800克重。生后为柔软的短毛，随着生长而变长。4—6个月时第一次换毛，换成柔软短的下毛和粗而直的上毛。毛色多样，有单色或混有不同色的斑。

成犬体重公母均为1.3—3.1公斤，身高为20厘米左右。有类似狐狸的圆锥状头，嘴尖，口唇突出。鼻端呈黑色。眼呈圆形。腿后部有饰毛。尾巴被以长毛，高高翘起，卷在背上。毛色为黑色、红色、巧克力色、奶油色、茶褐色、白色与茶色斑。

8. 贵妇犬 又名贵宾犬。原产地德国。个性聪明。脱毛少，无体臭。是玩赏犬的最受欢迎的犬。驰名于世界。

仔犬出生重大型的为300克左右，中型的为200克左右，小型的为60克左右。60日大型可达6公斤左右，中型可达2公斤左右，小型可达1公斤左右。生后的柔软的短毛，随着生长而变长，4—6个月第一次换毛，换成柔软而短的下毛和密而厚的长毛为上毛。毛色为各种各样的单色毛。生后3—7日断尾，断去二分之一。

成犬体重大型的为5.5公斤以上，中型的为3.5—5.5公斤，小型的为1.5—3.5公斤。大型的身高为38厘米以上，中型的为28—38厘米，小型的为28厘米以下。头略呈窄圆形，面颊平。鼻孔大，鼻端略上翘。眼睛呈卵形，耳朵长而且

大，垂于颊部，被以饰毛。被毛为密生绢丝状毛，应加以修饰，剪成各种形。毛色为白色、奶油色、茶褐色、蓝灰色等。

9. **蝴蝶犬** 又名巴比伦犬。原产地西班牙。个性活泼灵敏，体质健壮，温顺。可作为玩赏犬。体重为3—5.5公斤。身高为25—30厘米。头比较小，被以短毛，鼻梁短尖，鼻端为黑色。口唇长度适中，唇宽。眼圆形，略大。耳大，有立耳或垂耳。尾有饰毛，卷曲于背上。被毛有光泽，呈绢丝状。毛色为红白色、黑白色、红宝石色、白色等。头部具有对称的色斑。

10. **小曼彻斯特梗** 原产地英国的曼彻斯特镇。个性温顺，感觉锐敏，富有警戒心。可作为玩赏犬。成犬体重为3—5.4公斤，身高为23—31厘米。头比较长，头盖狭，前额部更长。鼻梁直，鼻端黑。嘴尖，眼睛小。耳朵大，向正前方直立。尾巴长而且细，向上稍弯。被毛为黑褐色，非常短，富有光泽。

二、犬的饲养管理

犬是比较容易饲养和管理的动物。我国广大农村养犬是有啥喂啥，粗放管理。但是，由于养犬的用途、数量、品种不同，其要求也是不同的。如果养犬为了巡逻、警戒、玩赏或肉用，养的数量又比较多，那饲养管理就显得非常重要。只有科学饲养和管理，才能收到事半功倍的效果。

（一）犬的饲养

1. 犬必需的营养物质 犬的身体是由营养物质组成的。这些营养物质主要包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质和水等。

（1）蛋白质。犬身体的主要成分是蛋白质。在有机体的生命活动中，蛋白质是起决定性作用的。机体需要不断地补充蛋白质，以便更新衰老和被破坏的细胞，保证生长发育、维持繁殖和抵抗疾病的需要。如饲料中蛋白质不足，仔犬生长缓慢、发育不良、性成熟晚，容易感染疾病；母犬产后泌乳不足；公犬则出现性欲低，精液质量差，甚至造成母犬空怀。

动物性和植物性饲料中均含有蛋白质。瘦肉含蛋白质20.6%，鱼中含17—20%，鸡蛋中含12.6%，牛奶中含3.6%，大米中含8.1%，小米中含9.7%，高粱中含13.5%，玉米面中含10.8%，马铃薯中含2.1%，白菜中含1.4%，胡

萝卜中含1.4%。实验证明，动物性蛋白质优于植物性蛋白质。这是因为饲料中的蛋白质被犬吃食后，胃肠的消化酶将其分解为氨基酸而被吸收。只有被分解成各种必需氨基酸的蛋白质才真正具有完全的营养价值。动物性蛋白质含的必需氨基酸全面，而且营养比例适当，因而营养价值高。反之，植物性蛋白质营养价值就低些。长期用植物饲料喂狗，容易引起贫血、生长缓慢等情况。因此，在每天的饲料中，动物性饲料中蛋白质含量至少占全部饲料中蛋白质含量的1/3。幼犬每日每公斤体重需要动物性蛋白质4.7克；成年犬每天每公斤体重需要可消化蛋白质4克，其中动物性蛋白质不得少于1.5克。

（2）碳水化合物。包括淀粉和纤维素。淀粉是犬身体所需热量的主要来源，并有助于脂肪的氧化。当犬体内的碳水化合物不足时，就要动用体内的脂肪和蛋白质来供应热能，时间长了，犬就会消瘦，影响生长、繁育和训练；反之，则形成脂肪蓄积，犬就会过胖，同样影响发育和训练。纤维素是一种不易消化的物质，但可促进胃肠运动。大部分植物性饲料中的主要成分是碳水化合物，如高粱、玉米、大米及蔬菜等。幼犬每日每公斤体重需要碳水化合物为17.6克。

（3）脂肪。脂肪不仅是犬体内潜能的来源。给犬提供热能防御寒冷，而且是脂溶性维生素的溶剂。犬体内的特殊脂类，如脑磷脂、固醇等，对构成各种细胞和调节代谢过程是必需的。如果缺乏脂肪，轻者影响犬的生长发育，重者容易发生脂溶性维生素缺乏症等疾病。如果供给的脂肪过剩也不好，引起犬体肥胖。

犬所需的脂肪主要是从饲料中获得，猪肉、羊肉、蛋黄

等饲料中含脂肪较丰富。幼犬每日每公斤体重需要脂肪为1.1克，成年犬需1克左右，如按每日需要脂肪量折合成干物质计算，以含12—14%为宜。

(4) 矿物质。矿物质对幼犬的生长，维持成年犬的健康和正常的繁殖都是不可缺少的。犬必需的矿物质元素有钙、磷、钠、氯、铜、铁、锌、钴、碘、锰、镁、硫、钾、硒、氟等。其中最重要的是钙、磷、氯、钠、铜、铁、钴、碘。犬如果缺乏钙、磷，或钙、磷比例失调时，幼犬生长停滞，发生消化障碍和佝偻病，成年犬则患软骨病，甚至性机能遭到破坏。饲料中钙、磷比例以2:1为好。氯和钠对饲料的消化、水的代谢及血液渗透压的维持都有重要作用。犬的饲料缺氯和钠时则食欲降低，并能降低饲料中营养物质的利用。因此，食盐是一种不可缺少的矿物质饲料。铁、铜、钴等元素与犬的健康关系密切。铁、铜、钴不足时，会使血红蛋白和红血球数量减低，严重时发生营养性贫血。过量的碘对狗有害，但碘不足，会使怀孕的犬多产弱仔。为了预防碘不足，间隔一定时间，可在饲料中加少许碘化食盐或碘化钾。

(5) 维生素。维生素又叫维他命，故名思义，是维持生命的物质。具有促进生长、繁殖，保证神经系统正常发育，增强对疾病的抵抗力和消除有毒物质毒害的作用。对犬最重要的维生素有维生素A、B族、C、D、E等。维生素A在鱼肝油中含量多，植物性饲料中只含有胡萝卜素而没有维生素A，但胡萝卜素在犬体内借助于胡萝卜素酶的作用，可以转化为维生素A。维生素B族包括几十种维生素，其中最重要的有维生素B₁、B₂、B₆、PP。牛奶、谷类饲料、豆类饲料中均含有。维生素C也叫抗坏血病维生素，牛

奶、西红柿和新鲜蔬菜中含量较多。维生素D是骨骼生长所必需的，牛奶、鱼肝油、菠菜中含量丰富，太阳光照射也可以生成维生素D。维生素E又叫生殖维生素，缺乏时生殖机能紊乱，谷物、牛奶、蛋黄、肝脏中，以及新鲜蔬菜中均含有。

(6) 水分。水是生命所必需的。各种营养成分的消化、吸收、运输和废物的排出，体温的调节，母犬泌乳等，都必须有水分的参与。饮水不足，影响体内代谢过程。因缺水而使体重消耗20%时，犬就会死亡。因此，要保证犬对水的需要，一只犬一昼夜要供给5—7升水。

2. 犬的饲料 犬的饲料分为动物性饲料、植物性饲料，调味性饲料和添加剂类饲料。

(1) 动物性饲料。动物性饲料是犬的主食，因为犬是食肉性动物。常用马、牛、羊、猪和鸡、兔、鱼肉及其下脚料等。警犬、军犬也有喂鸡蛋和牛奶的。在肉类中以马肉为最好，因马肉含蛋白质较多，脂肪较少，适于犬的习性，易于消化而且经济。也可根据本地区市场情况采用不同的动物性饲料。广东的“狗王滔”以猪皮或鱼类的下脚料作为动物性饲料，饲喂商品犬（菜犬）效果很好。

(2) 植物性饲料。可分为粮食和无刺激性的蔬菜类。粮食类有大米、小米、高粱米、玉米、小麦、玉米面、面粉及大豆饼、菜籽饼等；蔬菜类有大白菜、胡萝卜、菠菜、马铃薯、甘薯、冬瓜、南瓜等。

(3) 调味饲料。食盐、酱油、大酱渣等。

(4) 添加剂、矿物质以及维生素等。饲料中矿物质和维生素的含量往往不能满足犬的需要，因此，要在日粮中补充适量的骨粉、贝壳粉、盐和铁盐等。

在国外，专门有供应犬食品的商店，供应为犬制作的罐头及其它食品。

3. 犬的日粮标准 犬的日粮标准以犬的品种、年龄、体格、训练、作业的种类以及季节不同而异。一般中等体格健康的成年犬、普通的训练和作业的犬，每日日粮热能约为2500大卡（1卡=4.18焦耳）。其日粮标准如下：

肉类	400克（煮熟前）
米、麦、蔬菜	700克（煮熟前）
食盐	10—20克

我国农村和城郊一般养犬（看家犬）不太重视日粮标准。只喂一些人们剩余的饭菜。犬易消瘦、患病。饲养商品犬要养成体大而肥壮，因此，必须给予一定的饲料，以满足犬生活和育肥的需要。现将广东“狗王酒”喂养商品犬的日粮标准介绍如下：一般每只中等犬，大米每日平均100—150克，猪皮和鱼类的下脚料50—100克，再加上适量的青菜、甘薯等，煮成粥状，放少许盐、金霉素、穿心莲等抗菌物质，然后喂给。

中等犬一般喂到10—15公斤重即可上市。

实验动物用犬的饲料标准见表1。

4. 饲料的调制 犬喜食温料熟食。将饲料加工煮熟后，加入调味品以及添加剂等，可以增进食欲，易消化吸收，获得良好的营养效果。为了减少饲料中的营养物质在加工过程中的损耗，调制时应注意以下几点：

（1）生肉或内脏，应以冷水洗净切碎，煮熟，再混入蔬菜类，短时间内煮沸，使之成为混合的菜肉汤。

（2）蔬菜类先洗净，再切碎，有些块根类的菜，如萝卜、薯类尽量不要削皮，放入肉锅煮至熟而不烂。

表 1 实验动物用犬一昼夜的饲料标准 (克)

犬的年龄	植物性和动物性饲料								维生素饲料				矿物质饲料		
	肉	米	面食	青根植物	菜植物	牛乳	乳液	动物性脂肪	鸡蛋	鱼肝油	酵母	胡萝卜	绿色植物	盐	骨粉
成年犬	350	250	300	400	—	100	10			8.0	6	60	100	10	14.0
哺乳仔犬	50	50	70	50	150	20	3		隔日一个	0.5	1	5	10	0.5	4.3
1—3个月小犬	150	100	150	150	400	—	4			3.0	2	20	40	5.0	11.0
4—6个月小犬	250	150	150	200	300	—	6			5.0	4	30	60	8.0	13.0

(3) 米类不必多次过水, 以清水淘净砂土为原则, 以保证养料充分利用。经单独煮成粥后混入菜肉汤, 充分混合后, 加入少量食盐

(4) 犬食的温度避免过冷或过热, 一般为 40°C 左右 (不得超过 50°C)。但夏季可以给冷食, 冬季给以温食。

(5) 如利用剩余菜饭喂犬时, 应注意少放盐或不放盐, 以免增加咸度, 降低食欲, 严重者引起食盐中毒。

(6) 犬食应现做现吃, 最好不过夜。炎热夏季剩饭易腐败变质。变质的饲料决不能喂犬, 以防食物中毒或发生其它疾病。

5. 喂养 对犬进行正确地饲喂也十分必要, 在喂养中应注意以下几点:

(1) 喂犬要定时、定量、定地点和定温度。喂犬的时间要固定, 不可错前错后。要在犬舍内喂饲, 不可到处乱喂。犬的食量按需要定量, 不能时多时少, 一般达九分饱即可。食物不要过冷过热。

(2) 食具要每只犬一个专用, 不得串换, 用后清洗干

净，放置时防止苍蝇，保持清洁，定期煮沸消毒，防止传染疾病。

(3) 喂食次数，一般成年犬每日喂 2 次，1 岁以内的犬每日喂 3 次，3 个月以内的仔犬每日喂 4 次，2 个月龄以内的仔犬每日喂 5 次，1 个月龄以内的仔犬每日喂 6 次。商品犬（莱犬）一般每日喂 2 次。孕犬、哺乳犬和病犬，可酌情掌握。

(4) 喂犬时注意观察其吃食情况，如剩食或不吃等，应查明原因，采取措施。剩食应取走或过一段时间再喂，不能长时期放在犬舍里，既不卫生，又易养成犬的坏习惯。

(5) 喂食前后均不应进行剧烈活动。

(6) 利用剩余饭菜时，要注意尖锐的鱼刺、鱼骨，辛辣刺激等食物，以防口腔受伤，刺激其嗅觉。

(7) 实验动物用犬给饲次数及其数量见表 2。

表 2 实验动物用犬给饲次数及其数量

犬的年龄	一日给饲次数	一次给饲量 (公斤)	一昼夜给饲量 (公斤)
断乳至 4 个月	6	0.4—0.5	2.4—3.0
4 至 6 个月	5	0.6—0.9	3.0—4.5
6 至 12 个月	3	1.5—2.0	4.5—6.0

6. 犬的饮水 犬的正常生命活动离不开水，在犬舍内要放置水盆或饮水器，充分给水。

(1) 水盆和饮水器应保持清洁。夏季经常换水或补充水。在犬舍内给水不足时，到野外饮沟渠的不洁水、河水、

雪水等，易患消化器官疾病或受寄生虫的侵袭，应特别注意。

(2) 水质要好，保持清洁卫生。在夏季，若供水不足，易发生消化不良、便秘、热射病等。

(3) 禁止喝污水、混浊不洁水以及冰冷的水，必要时可进行消毒（100毫升水加0.4克明矾，或1立方米水中加入漂白粉5克）。

(4) 运输中应充分给水。犬在运输途中，尤其是长途运输更应注意给水。给水时应把车停在树荫下或背风向阳的地方。

(二) 犬的管理

为了使犬健康的生长，除了供给犬充足的营养物质外，还需要给犬创造一个良好的生存条件和加强管理等。

1. 犬舍地址的选择及建筑要求 犬舍是犬栖息的场所。犬舍的结构、环境条件以及管理的好坏，对犬的健康、繁殖和训练影响极大。因此，必须给犬建一个舒适的圈舍。

(1) 犬舍地址的选择。大群饲养的犬舍应选择环境清静，地势高燥，稍有坡度或平坦的砂土地。犬舍的地下水位应低，雨后不积水。犬舍要建在水源充足，水质较好，交通方便，易接电源的地方，且与住宅、交通要道、畜禽饲养场、厕所、污水坑和化工厂等有一定的距离。

(2) 犬舍的建筑要求。犬舍的建筑要掌握因地制宜、经济实用的原则，既要坚固耐用，又要符合犬的生活习性和卫生条件。首先，犬舍要有采光与通风设备，日光和空气是犬生命所必需的。犬如果缺少光照，体内合成维生素D就会受到干扰，就要患软骨病和皮肤病。如果犬舍空气不新鲜，

轻则影响犬的食欲和兴奋性，重则可使犬发生二氧化碳或氨气、硫化氢等气体中毒。因此，犬舍要经常保持光照和通风。犬舍应安装采光窗，采光窗的面积为犬床的 $\frac{1}{5}$ 或 $\frac{1}{7}$ ，一般安装玻璃窗，夏季通风、防蚊，冬天保暖。犬舍的自然换气要充分，冬季可安装特殊的人工换气装置。其次，犬舍要有防湿与排水设备。犬舍过于潮湿可使犬得皮肤病，犬舍空气过于潮湿可使犬无力、气喘，易患传染病。犬舍内空气相对湿度以30—40%为好。犬舍要有排水通道，犬床应高于地面20—30厘米。第三，犬舍要有保温与防暑设备：高温和低温对犬的健康均不利，高温可使犬中暑，低温可使犬患呼吸器官疾病。为了防止高温、严寒对犬的不良影响，夏天要注意犬舍通风，防止太阳直射，冬天要防寒，及时铺垫草，加盖防风席，犬床上设置睡箱，使犬舍温度保持在 15°C 左右，产房内要保持在 $15-18^{\circ}\text{C}$ 。第四，犬舍要设运动场。运动是犬的特性，因此，犬舍应设逍遥运动场，一般6平方米大小。运动场场地以水泥或三合土为好。运动场要稍有坡度，便于排水。

（3）犬舍的结构。根据养犬的数量和品种不同，犬舍可采用封闭式、半封闭式两种。封闭式即为房舍式，用砖瓦水泥建筑，门窗可用钢木结构，运动场的隔墙用角铁、钢管和铁丝网围成，既防止撕咬，又便于清扫、洗刷和消毒。半封闭犬舍像农村建的猪圈一样，上边用铁丝网罩上，以防犬逃走。也可将住房稍加改造用来养商品犬。饲养一二头犬可设立活动犬舍，即在屋内设置犬箱，其高1.0米，宽1.0米，长1.2米。

犬舍的面积根据养犬的数量和犬的需要而定。犬舍总面积至少为10—12平方米，高为2.2米。一般情况下，犬居室为

2—3平方米；繁殖母犬居室为3—4平方米；幼犬因群居，其居室面积不能小于6—8平方米。大规模饲养，还应设立病犬护理室，建在正常犬舍下风向50米以外处为宜。每栋犬舍的一端应设立管理人员工作室、饲料间和调料间。最好设上下水道、采暖和照明设备。

2. 犬舍的管理 犬舍的管理主要有以下几点：第一，犬舍内要设木制的犬床或铺以平整的木板代替，观赏犬可在其主人的室内设置犬箱。冬季，在犬床或犬箱内铺上旧垫子或旧毛毯、棉被、垫草，并要勤晒、勤换，每1—2周更换一次；夏天撤掉铺垫物。第二，保持舍内卫生。养小型观赏犬或养少量犬时，应训练其在室外排粪尿。每次喂完后或睡前、清晨起来时，让犬在舍外散步十几分钟，以排净大小便。饲养犬较多时，犬舍每日清扫3次，随时清除粪便，每月大清扫一次，并用草木灰水或2%来苏儿水消毒地面和墙壁。第三，犬舍要通风、透光，冬暖夏凉。犬舍内空气要新鲜，采光要充分。天气炎热时，窗户要打开，以通风降温或向地面洒水降温。盛夏要避免日光直射犬头部，可搭凉棚遮荫；天气冷时，要定时开窗通气。严冬季节，犬舍四周要采取保暖措施，舍温控制在12℃左右。第四，要保持犬舍周围的环境卫生。犬的粪便要定点堆放发酵，以杀死寄生虫卵；夏季，粪堆或粪池内要喷洒石灰水或石炭酸水消毒；要消灭犬舍附近的蚊、蝇和老鼠；犬舍周围要及时清扫，清除垃圾和杂草，犬舍周围的排水沟要通畅；犬舍周围要栽树，既可遮荫，又可防风。

3. 犬体的卫生和修饰 保持犬体卫生，可以使犬皮肤新陈代谢旺盛，增强犬的体质，避免传染皮肤病或其它疾病。

(1) 梳刷。犬体的梳刷可以除去污垢、灰尘，促进皮肤血液循环，消除疲劳，增加食欲，春季可以促进夏毛更新，秋季可以促进冬毛生长。经常梳刷可以保持犬体干净，改善皮肤的血液循环，使其新陈代谢旺盛，增强皮肤的抵抗力，有利于犬的健康。梳刷犬体还能促进人犬亲和，提高犬的训练和使用效果。

一般情况下，成年犬每天梳刷一次。在风雨天或训练、执行任务以后都要进行梳刷，在春秋换毛季节要早晚各梳刷一次。梳刷方法是由头至尾，从上到下依次进行。即右手持棕毛刷从颈部到肩部、背、胸、腰、腹、后躯，梳刷完一侧再刷对侧，最后梳刷四肢和尾部。梳刷时用棕毛刷先逆毛梳刷，将毛层刷开除去污物。如梳刷不开，可换硬刷梳刷，然后再顺毛梳刷。整个梳刷过程要一刷接一刷，遍及全身，不要疏漏。梳刷动作要轻，使犬感到舒适而无疼痛，不要用力过猛。头部、阴囊、阴门、肛门和趾间等毛稀的地方不要疏刷，要用毛巾或干净的布片擦洗。但观赏犬和爱玩犬的头部毛较厚，要用毛刷梳刷。

梳刷一般在喂食后进行，喂食时不要梳刷。梳刷下来的杂毛要集中埋掉。千万不能落在食槽里或饲料里。因为犬吃了过多的毛，易得毛球病。梳刷时要注意观察犬是否患皮肤病或寄生虫病，如发现要及时治疗。在梳刷时，如划伤犬皮肤要涂碘酊消毒。梳刷用具要每犬单独使用，避免混用。

(2) 洗澡。洗澡可使犬体干净、卫生。因为犬身上分泌一种蜡样分泌物，粘在毛、皮肤以及项圈上，散发一种难闻的“犬气”味道。尤其是爱玩犬和观赏犬更应经常洗澡。洗澡的次数应根据季节和犬体的污染情况而定。夏季要经常洗澡，春秋可选晴天、气温稍高时进行。如果气温在15℃以

下时，应在室内用温水洗浴，冬季应有采暖设备。

给犬洗澡的方法是，如果大群饲养，应设犬浴室，夏天也可在河里洗，如果养少量犬或爱玩犬，可在室内用40℃温水洗浴。无论在什么地方洗，都要先使犬熟悉水性，逐渐适应，不要强迫，以免使犬形成不良反射。当犬入水后，先用手把水轻轻撒到犬身上，待犬适应后，再浸洗皮毛，用肥皂或药皂搓洗，再用清水反复漂洗，冲掉肥皂沫，用毛巾擦干。犬的面部不能用水洗，更不能用肥皂，只能用湿毛巾擦洗。切不可把肥皂水或清水弄到犬的耳朵里和眼睛里。洗完后，让犬晒太阳以晒干被毛，或用电吹风吹干，以免感冒。

（3）美容。一般来说，观赏犬要进行美容，主要包括梳毛、刷毛、拔毛、剃毛、剪毛、烫毛、修趾甲等措施。观赏犬每天要梳毛和刷毛，使毛保持整洁、光泽。拔毛是拔除杂毛或刚毛，剪毛是将身上或头部的毛剪齐。烫毛是用电吹风把头毛、颈毛、尾毛吹烫成花样。趾甲过长会给犬带来不适的感觉，应定期检查、修剪。

4. 犬的散放和运动 正确地对犬进行散放和运动，不仅可以增强犬的体质和各器官的机能，以及调整犬的神经活动，而且可以使犬养成良好的习性，有利于犬的训练和使用。

（1）散放。散放是一种使犬处于自由状态的轻松活动。每次喂食后散放10—15分钟。犬被较长时间关在犬舍内或拴系时，至少每隔2—3小时散放10分钟左右。每次训练前或训练后，让犬自由活动10分钟左右，以缓解紧张状态。

（2）运动。运动是一种使犬处于紧张状态的激烈活动。军犬、警犬、警戒犬、猎犬、看门犬运动要坚持经常，不要间断。每天要坚持两次运动，每次不少于半小时，运动

的方法多种多样，可以采取随自行车奔跑、爬山、长途行走、游泳和通过障碍等多种形式。运动量要根据犬的年龄、体质、训练和使用强度，以及犬的身体状况来掌握。运动开始时，速度要慢些，逐渐加快，当犬的呼吸加速时即可放慢速度。犬运动以后，不要让犬立即卧下或进舍内，也不要给水喝，要让犬自由运动一会儿，待犬平静下来以后，再让犬休息。

生后6个月以内的小狗，主要进行卫生保健自由活动，每次运动20分钟左右。6个月以内未成年狗主要进行基本训练运动，以锻炼其筋骨。观赏犬主要进行逍遥运动。

（三）妊娠母犬的饲养管理

在妊娠母犬的饲养上主要着眼点是增强体质、胎儿发育健全和防止流产。

首先不摄取对母犬和胎儿有害物质，供给优质饲料，后半期给予易消化的富于蛋白质和含有磷酸钙的饲料。其次要注意不要喂得太饱，胃容积太大易造成胃扩张。急剧扩张易压迫胎儿造成流产，不给凉冷饲料和过凉的水，防止流产。

犬舍比平时更应清洁，干燥，防止犬床潮湿，给予多量垫草保暖。白天牵至运动场进行日光浴（晒太阳）。拴系时，防止冷风侵袭，拴在避风有阳光的地方。夏季为避免日光直接照射，可拴系树荫处。

适当运动不但可促进母体及胎儿的血液循环，增强新陈代谢，母子康健，而且分娩时容易产出。但必须避免咬架和跳跃等剧烈运动。

（四）仔犬的饲养管理

1. 仔犬生后的护理 生后一周内的主要护理工作是保温、防压、吃足初乳、固定好奶头，及时补乳和喂饲，解决好母犬无奶和多产仔犬的哺育问题。

（1）保温防风。保温是提高成活率的关键。仔犬在出生一周内，由于环境变化，由母体内恒温到外界的变温或低温。同时仔犬被毛稀少，皮下脂肪少，保温能力差，由于大脑皮层发育不全，体温调节机能较低，适应能力差，活动能力不强，易被母犬压死踩伤。接触不到母犬的仔犬易受冻挨饿而死。护理人员要加强看护，如发现被母犬压住的仔犬，要及时取出。

为了保温，可在相邻的两个犬室间设有火墙、土暖气等采暖设备。

（2）吃足初乳。仔犬体内无抗体，而产后3天内母犬分泌的初乳中含有丰富的多种抗体。新生仔犬得不到抗体很难成活。因此，初生的仔犬应尽早吃到初乳，而且应该吃足，补足体内的抗体。

（3）固定奶头。如果仔犬吃奶不固定好奶头，就会发生强夺弱食，仔犬发育不均，死亡率高。为提高仔犬的成活率，必须固定奶头。用人工辅助固定，生后绝大多数可自行固定奶头，对吃不上母乳的仔犬，特别是瘦弱的仔犬，帮助它们找到乳量较多的乳头吸吮。

（4）仔细观察和掌握仔犬的发育状况。饲养人员每天要对仔犬逐个称重，并记录好，以便从体重的变化情况了解母犬泌乳能力，决定是否需要补乳。一般的母犬产仔不超过6只，乳汁和乳量正常，仔犬生后5天内，每天平均增重不

少于50克。在6—10天内，每天平均增重70克左右。从第11天以后，母犬乳量不足，仔犬体重增长可能下降。因此，在此时可采取补乳措施。

(5) 补乳和喂饲。随着仔犬需要奶量的日益增加，母犬的泌乳量不足时，则需补乳。补乳以新鲜牛乳为佳，经煮沸消毒用奶瓶喂给，乳温在27—30℃。补量：15天以内的仔犬，每只补给50毫升牛乳，15—19天仔犬每只补给100毫升，至20天时则增至200毫升。每天分3—4次喂给。

仔犬出生后，最早的在9天，最迟的12—13天才开始自行睁开眼，在仔犬睁眼时要避免强光刺激，以免损伤眼睛，同时护理人员也不要给犬扒眼，以免造成不良后果。当仔犬睁眼后，就可把牛奶倒在小盘子里，让仔犬舔食。在20天左右，在牛奶中可加入少量米汤或稀饭，25天后，再加入一些浓厚的肉汤。稀饭和肉汤由20—30克逐渐增加至200—300克，每天分3—4次补给。30天后，可加入切碎的熟肉，每次15—20克，每天早晚二次补给。35天后的仔犬补饲量要逐渐增加。

补饲的食物是牛乳、鸡蛋、碎肉、稀饭等加在一起成为半流食，可以适当地给以鱼肝油、骨粉等，每天喂4—5次。一般在6周左右断乳。

仔犬在睁眼的同时产生听觉。生后3周左右犬齿开始发育，第4周门齿发育，第5周第一、二臼齿发育，第6周以后，第三臼齿发育，生后8周牙齿全部长齐。

(6) 人工哺育和过哺。母犬产仔数较多，超过8只以上时，完全由母犬哺乳对仔犬的正常发育不利，需要进行人工哺育。人工哺育的仔犬还有因母犬产仔死亡的。母犬健在，一般不应生后马上离开母犬，应该让母犬哺育一周左右。

再离开母犬。

采用人工哺育的仔犬，应放在同一个产房里，犬箱内铺以褥草或旧毛毯，以保持适当温度。人工哺育时，用酒精棉球擦拭仔犬的臀部，刺激仔犬及时排出大小便，直到睁眼后能自己排出为止。人工哺喂牛乳，用奶瓶喂给，生后10天内，白天每隔2—3小时，喂牛乳一次，夜间每隔4—6小时喂一次。每只仔犬每昼夜不少于100毫升，10—20天内哺乳量由200毫升增至300毫升，一个月后每天6次。当仔犬睁眼后则放入盘内自行吃乳。20天开始，饲喂的食品除300毫升牛乳外，其它食品种类和数量同前。

过哺就是母犬无奶、死亡或产仔过多，而使仔犬吃不到奶，给找个“奶妈”，叫做过哺。“奶妈”犬的分娩时间和原母犬分娩时间基本相同，才能保证仔犬得到充分乳汁，适应仔犬发育的需要。其方法将“奶妈”犬牵走，把过哺的仔犬放在窝内，将“奶妈”犬的乳汁涂在过哺仔犬的身上，使仔犬附上“奶妈”犬的气味，“奶妈”犬就会当成自己的仔犬给以哺乳。但也有的怀疑或咬，可给“奶妈”犬带上口笼，待允许吃奶后再摘掉口笼。

2. 仔犬的日常管理

(1) 日光浴。当出生后3—5天时，在无风暖和的日子，将仔犬抱到室外和母犬一起晒太阳，每天进行两次，每次20—30分钟左右。在极其寒冷的地区或冬季，可将仔犬放在靠近日光的玻璃窗下，让阳光直接照在仔犬身上。

(2) 运动。当仔犬睁开眼后，自己能站稳，可先在室内走动，待生长几日后，可让其在室外活动、游戏、玩耍等，初期时间可短些，以后逐渐增加时间。

仔犬出生20天后，可随母犬在室外活动场一起活动，晚

间回犬舍内。

(3) 擦拭。仔犬身上容易污染弄脏，初期母犬能及时舔去，以后护理人员每天用软布片擦拭仔犬的身体，除去污物，保持仔犬身体的清洁性，同时刺激皮肤促进血液循环加快，增强新陈代谢，有利于仔犬的健康，促进其生长。

(4) 剪修趾甲。仔犬生后2—3周左右，其前爪可能生长过长，使仔犬产生不适感，并且在吃奶时易抓伤母犬的乳房或伤及其它仔犬；因此，要及时给仔犬修剪趾甲。用剪刀和指甲刀修剪，修剪后锉平整。注意防止造成损伤。

(5) 洗澡。为了保持身体清洁，预防皮肤病，在一定时间内应进行洗澡。特别是在室内饲养犬，除保持身体清洁、预防皮肤病外，更重要的是防止犬的恶臭气味，驱除跳蚤、虱子等。洗澡次数由于犬的种类和季节不同而异。一般每日一次。

洗澡时注意事项：首先用棉球将耳堵上，防止浴水进入耳内侵害鼓膜；其次水要充足，温度不应太高，一般在25—30℃左右；再次，洗澡后一般进行自然干燥，也可用冷风或热风吹干。对长毛种犬应该采取措施，使被毛快干，以防感冒。

(五) 幼犬的饲养管理

仔犬断奶后即为幼犬，一般为生后45天至8个月。应根据幼犬的不同发育时期所需的营养物质来确定饲料数量及质量。在幼犬整个发育阶段，正是长身体的时期，必须供给充分而丰富的蛋白质、脂肪、糖类、矿物质及维生素。

1. 幼犬的饲养 欧美犬群的饲养者多利用价廉的马肉，也利用屠宰后的内脏器官，如牛的第一胃等。还可利用

鱼类以及鱼的下脚料。也可利用羊及家禽的头制成肉汤。这里介绍饲养标准，仅供参考。

除肉外，尚有蛋类、牛乳、大米、小米、麦子、蔬菜、甘薯、马铃薯、鱼肝油、骨粉等。

(1) 饲养标准。2—3个月的幼犬，每天喂4—5次，每只幼犬的日粮标准：

配方1：大米350克，麦60克，牛肉150克，甘薯250克，食盐10—15克。

配方2：牛肉或瘦猪肉200克，乳300毫升，蛋1个，大米200克，蔬菜200克，食盐10—15克。

在此期间，适当补给鱼肝油、钙片和骨粉等。

4—8个月的幼犬，食量增大，日量也应随之增加。每天喂3次。其标准如下：

牛肉（马肉、瘦猪肉、鸡肉）300—350克，乳品250—500毫升，大米（小米、高粱米等）250—500克，蔬菜200—300克，食盐15—20克。适当地补给鱼肝油、钙片和骨粉等。

(2) 饲养时注意事项。幼犬阶段的饲养很重要，首先要特别注意定时定量饲喂，一般要求一次吃完所定之食量，不应剩食。食后应将食具搬走，因犬舍内残留食饵，易招来苍蝇，容易使食物变质。其次要保证食物新鲜，不喂腐烂变质饲料，特别是肉鱼类更应注意。幼犬的饲料现做现喂，单独调制，讲究卫生，防止发生胃肠疾病和中毒。第三，食具用后清洗干净，放在日光下曝晒，或煮沸消毒，或用热水烫洗，也可用药物来消毒。第四，幼犬的主人应亲自喂犬，加强与犬的联系，及时观察幼犬吃食情况，食欲如何，吃食状态，有无剩食等。如出现问题，应查明原因，采取相应措施。喂食时切不可打吓犬，也不要有很大的声响。第五，要给

以洁净的优质水，以水盆或饮水器（深应15厘米），放在犬舍内让其自由饮用，当日换水。夏天应特别注意水质，不喝污水剩水，以防发生胃肠炎。

2. 幼犬的日常管理 加强幼犬的管理，不仅保证犬体的良好正常发育，而且对神经系统活动的发展也有直接影响。

（1）幼犬逍遥运动随母犬一起进行，每天2—3次。随着幼犬的长大，要逐渐增加时间，一般由30分钟增至60分钟。在逍遥运动的后期可进行自由的通过小沟、小障碍、爬山等锻炼。

在逐渐长大时，可牵引对环境锻炼，熟悉各种东西和声音，循序渐进，由简至繁。广泛接触环境，使幼犬对周围环境条件逐渐熟悉、适应，锻炼和培养其胆量。

（2）幼犬的卫生。搞好幼犬的卫生，可以增进健康预防疾病。

幼犬应经常刷拭和洗澡。刷拭时，不应粗暴用力过猛，要使犬有舒适感。洗澡后用干毛巾擦净，自然干燥或用冷风或热风吹干。

犬舍及犬床要经常打扫干净，及时除去粪便及污物，定期消毒。垫草经常更换和日晒。加强饮食卫生。

（3）幼犬的驱虫。幼犬阶段要进行驱虫和去势两项工作。寄生虫对犬的生长发育影响极大，因此，定期进行驱除寄生虫，保证犬体健康生长很有必要。

驱虫应在出生后2—8周时开始进行，以后每两个月进行一次，在进行前首先进行粪便检查，如发现虫卵或虫体以及节片，应及时按寄生虫种类投药驱虫。粪便堆积发酵杀死寄生虫虫卵。

(4) 幼犬的去势。室内饲养的爱玩犬或猎鸟犬以及患有睾丸炎、睾丸肿瘤等皆可施行去势手术。一般家庭饲养的看家犬不需要繁殖时，也可进行去势手术。

去势的时期，一般在生后6个月至1年。在春秋两季均可。去势应在天气晴朗、无大风的日子进行。

去势方法是，给犬带上口笼，侧卧在地上或桌上。助手保定住头部和四肢。术部消毒，在阴囊缝的一侧0.5—1厘米处，切开皮肤和总鞘膜，睾丸露出，在睾丸后方剪断阴囊韧带，在精索上方用消毒的缝合线结扎精索，在结扎线的下方0.5—1厘米处切断精索，除去睾丸。另一侧用同样方法切除，切口用碘酊消毒不必缝合。

母犬的绝育术（避孕手术），就是将其卵巢和子宫全部摘除。由于发育程度和个体不同，一般在生后4—5个月时进行。该手术较难，请兽医师进行，在此不赘述。

(5) 断尾和截耳。断尾和截耳是两项技术性较强的整形手术。有的犬断尾在外貌上好看，有的犬断尾后性情温顺。但从爱玩犬或伴侣犬为了尾部的美观，应对尾部进行整形修饰。

断尾应在生后1—2个月以内进行。

断尾方法是，术部剪毛，消毒，再在术部上方3—4厘米处，用止血带结扎止血。助手将尾部固定，保持水平位置。术者用外科刀环形切开皮肤，然后向上推移1—2厘米在尾关节处用骨钳子或直接截断。结扎血管，充分止血后，用碘酊消毒，撒布消炎粉，将皮瓣缝合即可。不全断尾，在预定切断处按上法进行即可。

不是所有的犬都进行截耳，有些爱玩犬和观赏犬为了美观、整形修饰其美丽的耳朵而进行截耳。

截耳时间一般应在生后 2—3 个月期间。按要求进行修饰，整形，由兽医师进行。

截除方法：先在术部剪毛，助手保定好犬，带上口笼。术部按常规消毒，术部进行局部浸润性麻醉，用手术刀锐性切开预定切除处的皮肤，钝性分离皮肤与软骨的间隙，并向上分离 2 厘米，在该处切除软骨后，皮肤自然形成一个套，充分止血后，撒布青霉素粉，将该处皮肤进行连续缝合，用纱布和脱脂棉包裹上，外边包扎卷轴绷带（耳绷带）固定。防止挠抓。

（六）观赏犬的饲养管理

观赏犬又叫爱玩犬、玩赏犬，指家庭养的超小型及小型美丽而且具有魅力的犬种。像被称为“口袋犬”的齐娃娃犬，“珠宝箱的犬”的约克夏犬等 5—6 种超小型犬，被称为“女性的珠宝”的马尔济斯犬，耳朵像蝴蝶的蝴蝶犬，身长脚短的腊肠犬，古代皇宫中饲养的北京犬等十几种小型犬。部分中型犬也兼有观赏的用途，比如温顺而忠于主人的斗牛犬，聪明温顺的巴古度犬等。

饲养观赏犬在经济发达的国家十分流行。我国随着改革开放的深入和人民生活水平的逐步提高，也开始引入观赏犬，尤以沿海城市为多。观赏犬因其体型小，体重轻，生活能力和抵抗疾病的能力较差，再加上长期“娇生惯养”，因而其饲养管理不同于大中型犬种和地方犬种。

1. 新生仔犬的饲养管理 观赏犬生下来至 2 个月以内，生活力很弱，需要精心饲养和管理。否则，将影响以后的生长和发育。

（1）新生仔犬的饲养。先把母犬乳房周围的毛剃净，

用温热毛巾擦洗乳房周围，以促进乳汁排出，再用酒精棉消毒乳房和其周围部分。然后让新生仔犬吃奶。开始，新生仔犬不会含乳头，也不会吸吮，慢慢地便会自行习惯。喂新生仔犬奶的时候，仔犬的姿势很重要，仔犬的四脚要着地，呈趴着姿势，头抬起吸吮。否则，仔犬极易呛着。

让新生仔犬吃到初乳十分重要。不但可以增强身体的免疫力，而且有利于胎粪的排出。如果母犬无乳或死亡，应设法找其它同期产仔母犬代哺。一般仔犬能吃到3天初乳即可，若能吃到5天则更好。以后便可以进行人工哺乳。人工哺乳，有的国家有专供犬用的奶粉，这种奶粉的特点是高蛋白质、高脂肪、低乳糖，而牛奶和人用奶粉是低蛋白质、低脂肪、高乳糖。如果用牛奶或人用奶粉喂仔犬，其浓度要加倍。否则，仔犬容易下痢而夭折。其饲喂方法很简单，把奶粉用开水溶解后，倒入奶瓶中，凉到39℃时，让仔犬四脚着地，头抬起吸吮，一次喂饱，不要间隔。出生6天以内，每3小时喂一次；出生7—19天，每4小时喂一次；出生20—29天，每5小时喂一次；出生30—35天，每6小时喂一次。35天以后，仔犬断乳，可喂给肝、蔬菜粥，即把猪肝或鸡肝切碎，新鲜的蔬菜洗净切成菜泥状，放入做好的稀面粥或米粥内煮熟，凉至39℃时喂给。粥与肝、菜泥的比例为4:1:1。喂后要勤察仔犬的粪便，如果正常，则继续喂给；如果拉稀，要停止喂给，调整比例，肝的比例缩小。一般情况下，断奶以后，不要马上喂给肉类，因为容易引起下痢造成仔犬死亡。仔犬断奶后，喂给肝蔬粥时，要逐步过渡。过渡的方法有两种：一是在仔犬33—38天阶段，每天喂奶次数逐渐减少，逐渐增加喂肝蔬粥的量；二是每次喂奶至八分饱，少喂给些肝蔬粥。待仔犬适应后再正常喂给。每天喂3—4

次，夜间不喂。

50天以后，喂给仔犬稀粥，里面加些蛋黄、煮熟的鱼肉、牛肉、鸡肉、钙片、维生素A、维生素D，喂量逐渐增加。同时给予清洁饮水。

（2）新生仔犬的管理。仔犬生下来后，擦干身上的污物或让母犬舔净，放入仔犬箱内，仔犬箱内要放些柔软的保温物，或用电灯照明取暖。仔犬出生1—6天，仔犬箱内温度要保持在30℃，6—29天仔犬箱内温度要保持在27℃，30天以后保持在25℃即可。

仔犬要单个放入仔犬箱内，或将仔犬箱分成格，每格1只。因为将仔犬放在一起，有时仔犬会将其同类的阴部当做乳头去吸吮，吸入尿液后，会导致肠炎而死亡。

仔犬出生第3天，脐带脱落；第7天进行断尾并切除狼趾；第13天开始睁眼睛；第15天耳朵张开；第18天开始站立学步；第25天眼能看清东西，耳朵能听见声音，并能喝食盆里的奶汁；第35天开始长乳齿，自己可以排便，雄犬的睾丸开始落入阴囊中，此时可以断奶。

仔犬每次喂完后，要让其排便、排尿，然后休息。在正常情况下，仔犬的排便、排尿完全依靠母犬舔其肛门和外生殖器的刺激而排出，若是母犬死亡，要每隔3小时用手指刺激肛门和外阴部，使仔犬顺利便出。否则，仔犬会因粪便堵塞无力排出而死亡。35天以后，仔犬会自行大小便，要训练其在固定地方大小便的习惯。一个月验一次粪便，发现虫卵或寄生虫，要请兽医给驱虫。

仔犬出生后20天，要经常给仔犬洗澡。但仔犬在注射犬瘟热等疫苗后14天内不要洗澡。每天要擦耳朵，定期剪趾甲。每天至少30分钟日光浴。冬天室内要注意保温，最好使

室温保持在25℃左右。

2. 2个月龄仔犬的饲养管理 此时是犬生长发育的关键阶段，如果饲养管理得法，可以得到健康活泼的观赏犬。否则，犬易患感冒、下痢和软骨病等，甚至夭折。

(1) 2个月龄仔犬的饲养。一般可喂些肉类、少量切碎的蔬菜、面包碎末及菜汤，搅拌均匀，再加点钙粉和维生素A、D各1滴。一天喂3次。至于喂量，要根据犬的体重而定。但是，犬不要喂得太饱，一般八分饱即可。每天要给予足够的新鲜饮水。

仔犬的食物不要轻易变更。如果是在市场买的仔犬或从亲友处抱养的仔犬，要问清其饮食构成，最好少要点配好的食物回家喂饲。回家后要照原配方、原味道给仔犬配食，如果要变更饮食构成也要逐步进行。给2个月龄犬配食物的原则是高蛋白、高脂肪、低乳糖、低纤维素、柔软易消化。

(2) 2个月龄仔犬的管理。要经常观察仔犬的粪便。有经验的人根据仔犬粪便形状、颜色、气味和排尿次数即可判断其健康状况。2个月龄仔犬每天大便3次，小便5—6次。健康仔犬的粪便呈条状，可以拾起来，软便、下痢便、水便、血便等都是不健康的表现；健康仔犬的粪便颜色为黄褐色，黑色的粪便说明胃肠溃疡或肠内有寄生虫；粪便特别臭说明胃酸过多，肠内发酵异常；粪便上面有白色或粉红色的虫体，说明胃肠有寄生虫，要赶快请兽医驱虫。尿呈淡黄色是健康的表现，呈深色或红色是有病的表现，应拿尿请兽医化验。

仔犬在2个月龄时就应开始训练。首先训练其记住自己的名字，在饲喂前，轻呼它的名字，抱起来，然后喂饲。这

样，经过15天左右，呼唤其名字，犬便能有所表示。每当呼唤犬的名字，犬有表示时，应拍拍脑门表示奖励，或喂给东西吃。其次，训练仔犬在固定的地方大小便。其方法是，在墙角处放一个盛有沙子的小盆，上边铺上报纸，当仔犬有大小便时，将其抱到盆里或将其引到盆里进行大小便，每当仔犬在盆里大小便时要给予奖励，或给好吃的食物，或轻拍头部，或抚摸背毛，以示满意，表示奖励；如果发现仔犬在屋内随地大小便，要用报纸卷成筒，轻打其头部，并说“坏东西”。一般情况下，经过5天的训练就可成功。当然，还要经常强化训练成果。第三，要训练仔犬握手、坐下、躺下、叫、看守等技能。训练握手的办法是，让犬伸出左前肢。一边说“伸”，一边用手拉其左前肢，主人用手握住其左前肢，当犬顺从地听其摆布，立即给以食物奖励或抚摸奖励。经过多次反复，犬即可形成条件反射。以后，只说“伸”，而不用手去拉前肢，待犬伸出左前肢时，主人再用手与其“握手”，经过若干次训练后，即可训练成功。其训练的基本原则、方法同普通犬的训练。

仔犬要保证有一定的运动量和足够的日光浴。找一个干净、阳光充足的地方，放一个皮球，任仔犬玩耍，既能晒太阳，又能达到运动的目的。2个月龄的仔犬不宜牵到马路或街上去运动。

夏天和冬天要注意保温，特别是在换季阶段和气温变化较大时更应注意防凉受潮，防止中暑。此时仔犬最容易患肠炎、感冒、传染性肝炎、犬瘟热、肠内寄生虫、疥癣、外耳炎等疾病。要按时打防疫针和注意防治。

3. 3个月龄犬的饲养管理 随着犬日龄的增长，饲养管理越来越显得越重要。

(1) 3个月龄犬的饲养。此时的食物构成基本同2个月龄时的仔犬，仍以肉类、牛肝或猪肝、蔬菜为主，混以稀饭或切碎的面包，加少量的食盐、钙粉和维生素A、D各1滴。每天喂3次。犬的食量要逐渐增加，每次尽量让其吃饱。

(2) 3个月龄犬的管理。随着日龄的增长，犬逐渐“懂事”，此时要抓紧训练和管理，以便使犬养成好的习惯。

3个月龄时犬容易抢食，或者不吃自己食盆里的食而专吃别的犬食盆里的食。这是因为在长期的自然选择中养成的一种占有欲，犬的占有欲是很强的。因此，此时犬要单独喂食，并要训练在吃食前等一下或不许到别的犬食盆里吃食的习惯。其训练方法是，当犬看到食盆里有食要吃时，一只手压住其鼻子，用严厉的声调说“等一下”，开始时，犬可能不理睬，这时用手强行将其拉开。然后用温和的声调说“吃”。每当犬听到严厉的声调和用手按压鼻子，犬倒退离开食盆时，要给予抚摸奖励或一边用手抚摸背毛，一边说“乖乖”。同样当犬听到“吃”的声音时，能主动走向食盆去吃，或用手将其推向食盆旁边而吃食时，也要给以奖励。这样经过多次反复训练，犬便能一被按压鼻子和听到严厉的“等一下”声音后，便能离开食盆。以后逐渐延长“等一下”的时间。经过一段时间的适应，逐渐撤掉按鼻子的动作，只用严厉的“等一下”的声音来命令犬，当犬能根据“等一下”声音要求而不到食盆边，或到食盆边而不吃食时，立即给予奖励。有时犬偶尔听不懂人的声音，可以用按一下鼻子，这样经过反复的训练和多次的强化，犬一听到“等一下”的声音，便能不吃食，一听到“吃”的声音便开

始吃食。这说明训练成功了。训练有素的犬很招人喜欢，主要是它们能听懂人的语言，按人的要求去做。

为了防止犬在一起抢食，或虽然分开喂，但犬去吃同伴的食而不吃自己的食。要把犬分开喂，不要几只犬一个盆。喂犬时，让他们互相不见面。犬在吃食时有把食物衔出来吃的习惯，遇到这种情况，则温和地说“不行”，把食物放回食盆，如果犬能安静地在盆里吃，则给予抚摸奖励并且口里说“乖乖”。为了防止犬在吃食时，把食物弄到盆外边，要选择稍大一些的盆，食物不要装得太满，以8分满为好。

3个月龄时，如果还没有防疫，必须到兽医院请兽医注射犬瘟热、传染性肝炎、犬麻疹等混合疫苗，每年接种一次。注射疫苗的2—3周内，不要洗澡，也不要做激烈运动。

3个月龄犬，每个月洗一次澡即可。洗澡时水温以39—40℃为好，不要将洗发精沫弄到眼里和耳朵里，洗完后，擦干或吹干，室温要不低于25℃。洗完澡后要除耳垢和剪指甲。

3个月龄时，犬便开始退掉胎毛，长出新毛，全身的毛稀而薄，是一种正常现象，但要加强饲养管理。饲料要好一些，管理上要防感冒、下痢。此时犬因为牙齿生长的刺激和习惯，喜欢乱吃地上的东西，如纽扣、小石子、塑料玩具碎片、碎骨头、针、钉、塑料袋和绒线等。这些东西吃进胃肠后，轻者刺激胃肠，重者造成胃肠堵塞和穿孔。因此，给犬的玩具要坚固，犬经常出没的地方要干净，同时要注意看管。

犬生后2.5—4个月时，是断耳的最佳时期，凡是应该

断耳的犬种，均应该请兽医断耳。

4. 4个月龄犬的饲养管理

(1) 4个月龄犬的饲养。将鱼、肉切碎煮熟，再放入少许切碎的新鲜、干净蔬菜，煮成汤状，拌以米饭或干犬食，喂时再放入少量钙粉、维生素A、D、食盐、糖。每天喂2次（早晚各一次）。中午可以少喂点蛋黄、奶酪或饼干之类食品。

(2) 4个月龄仔犬的管理。随着月龄增加，犬的胃肠容量逐渐增加，其排便次数减少，而每次排粪量增大，训练犬每天早晚各一次排粪。

要训练犬随人上下楼梯，但要防止骨折。每天有足够的晒太阳时间和运动量。如果犬两前肢站立时呈“O”形、后脚呈“X”形，说明患了软骨症或佝偻症，要增加晒太阳时间，每天至少晒2—3小时，但不要在炎热阳光下曝晒，以防中暑。晒太阳冬春季节要在中午进行，夏秋季节要在上午8—10点、下午4—6点进行。应注意在严寒的冬季和早春要防止寒风侵袭。

犬在4个月龄时开始退掉乳齿，逐渐长出永久齿，到6个月龄时长齐。此期间，犬齿龈痒得很，所以到处咬东西，比如咬拖鞋、衣物等。此时要严加管教，发现咬东西时，拿起东西在其面前晃动，说“不可以”或“坏”，时间长了，他就不会咬鞋子和衣物了。但是为了解决其牙齿痒的问题，可以给他一根熟的牛、猪骨头任其啃食。

长毛犬需要理毛、剪毛、梳毛。立耳犬、半立耳犬如果耳朵下垂，要在耳内垫塑料板矫正或耳尖绑塑料板矫正。

每月要洗2次澡，同时剪指甲、除耳垢。

5. 5个月龄犬的饲养管理

(1) 5个月龄犬的饲养。食物构成基本同4月龄，适当增加碳水化合物类食物含量，比如，增加米饭、面包、豆类等，蛋白质也要相应增加，同时加入少量的植物油。盐和维生素A、D、蔬菜不可缺少。但盐不能喂得过多，否则犬易大量饮水引起下痢。

(2) 5个月龄犬的管理。此时臼齿的乳齿也换成永久齿。要注意帮助把乳齿拔下，否则乳齿和永久齿形成二重齿。因为乳齿没有脱落，永久齿会长到乳齿的2—3倍长，不仅影响吃食，外观上也非常难看。

超小型犬很容易得牙垢，要注意请兽医清除。发现犬口臭即是患牙垢的症状，再扒开犬嘴看看牙龈即可确诊。犬患牙垢是正常现象，最好每半年定期请兽医清理一次。如果不清理，不仅口臭，而且到了4—5岁时，犬齿即掉光，影响到犬的健康和寿命。

防止咬东西和随地大小便的训练要继续强化。要注意健康检查，平时勤观察粪便，每月洗3次澡。

6. 6—7月龄犬的饲养管理 6—7月龄犬是生长发育的关键时期，因此，此期饲养管理尤为重要。

(1) 6—7月龄犬的饲养。其食物构成同5月龄，只是食量增加。要根据犬的发育情况，适当增加或减少其中的某种成分。如果犬过胖，除了增加运动外，还要减少碳水化合物和脂肪类食物的供给，适当增加富含蛋白质和含纤维素的蔬菜等食物；如果犬过瘦和背毛无光，要增加碳水化合物类食物，比如面包、米饭、馒头等，还要增加富含脂肪的食物。喂犬时，食盆不要放在地上，而要放在与犬齐胸高的椅子或垫物上。

(2) 6—7月龄犬的管理。此阶段可带犬到街上或商

店里去散步。开始时，犬不习惯，不愿意走。可给犬带上脖套，用绳牵着走，或者抱着去，回来时让其自己走。经过几次以后，犬便可跟着人去散步。散步要在早晚进行，每次30分钟左右，不能让犬太累。

散步时，有的犬跑到主人前边去，拉着主人往前跑，这是没有教养的表现。要训练犬在主人的右后边走。其方法是，犬脖套上系一根软绳，主人牵着，当犬跑到前方时，用力将其拉回，并用纸筒打它的鼻尖，口里说“不可以”，同时用严厉的语调说“在后边”。当犬在主人右后边走时，说声“乖乖”或给以抚摸奖励。经过若干次训练，犬便能跟随主人右后边走。时间长了，不用绳控制，只用口令来控制即可。

在散步过程中，要注意犬的安全，人不要离犬太远，犬的头在主人右脚后跟部即可。要防止车祸、犬互相咬伤，还要防止犬拣食杂物，发现犬捡食，要严厉制止。因为街上传染病很多，捡食很容易感染上疾病。如果有的犬恶习难改，可强行从嘴里夺回食物或其它东西，并打其鼻尖，严厉地说“不可以”。如果还不改，可在路边放一块很辣的肉，犬吃后辣得疼痛难忍，以后再也不敢捡食了。在散步中，严禁喂犬饼干或其它零食。散步要挑选空气新鲜、道路干净的地方，防止感染疾病和脚被碎玻璃等刺破。

6个月龄以后，雄犬发育逐渐成熟，有发情的表现，愿意抱人的手和脚，背部弓起，阴茎勃起。此时要轻轻打其腰部，严厉地说“不可以”。

犬还有挖洞的习惯，当发现在院子里挖洞时，令其停止，并用手轻轻拍其前脚，严厉地说“不可以”或“坏蛋”。当面用大石头把洞封死。经过几次教训后，犬便不再

挖洞了。犬挖洞的目的是为了避暑，因此，要给犬舒适的住屋，要保证冬暖夏凉，同时供给充足的饮水。

要经常给爱玩犬洗澡，夏天每周1次；春秋4周3次，冬天每个月1次。洗澡后要剪趾甲、除耳垢。

坚持经常检查犬的粪便。主要防感冒、胃肠炎、寄生虫病、软骨症等疾病。必要时请兽医检查。

7. 8个月龄犬的饲养管理 8个月龄时犬的体形已接近成犬，身体不会再长高了。

(1) 8个月龄时犬的饲养。8个月龄时超小型犬体重2.5—4公斤，每天需要560—1100卡热能；小型犬体重4—10公斤，每天需要1176—1900卡热能；中型犬体重10—20公斤，需要1960—2400卡热能。其食物构成大致是：肉类、大豆等蛋白质饲料占55%；米饭、面包等碳水化合物饲料占35%；牛油、植物油等脂肪性饲料占5%；蔬菜占5%。

每天早晚各喂1次。把肉煮熟，连同肉汤一起拌以米饭或面包、馒头，加少许骨粉、维生素A、D等喂给。

(2) 8个月龄时犬的管理。8个月龄时，雌犬开始第一次发情，阴户出血，连续2—3周，而后出血逐渐减少，阴户开始肿胀。雌犬愿意接近公犬，并要求交配。此时千万不要配种，因为犬虽然生理成熟了，但身体还没有完全成熟，待5—6个月后雌犬第二次发情时再交配。

8个月龄时要检查其牙齿，若乳齿还没有退掉，要请兽医拔除，否则，容易形成双重齿。不仅牙齿排列不整，导致口形不良，而且容易形成齿垢，导致蛀牙。

犬到8个月龄时，不大愿意听主人摆布，有反抗情绪，因此要严加管教和训练，发现错误要立即纠正，并要严厉训斥。管教犬要有耐心，并且全家人态度、口径一致才能奏

效。如果在管教时，有人发笑或态度不严肃，则影响训练的效果。比如，当犬随地大小便时，把它拉到粪尿旁，让它去嗅，强压其头部，并说“坏蛋”。让它实实在在地感到，这样做是主人不喜欢。如果在教训过程中，有人态度暧昧，小犬便会寻找同情者，对自己的错误“认识不深”，改的也不会彻底。

8个月龄以后至成年阶段犬的饲养管理基本同8个月龄时期，这里就不一一叙述了。

8. 成年犬的饲养管理 小型犬、超小型犬在生后18个月，中大型犬在生后24个月，便进入成年犬阶段。

(1) 成年犬的饲养。超小型犬、小型犬、中型犬对食物的营养需求有所区别，超小型犬对食物要求更高一些。食物中富含碳水化合物的粮食类食物可多一些，配以肉类、骨粉、蔬菜等食物，并给予少量的维生素。每日喂2次即可。

成年犬需要足够的清洁饮水，特别夏天更应满足犬的这一要求。

(2) 成年犬的管理。成年犬比较好管理。早上及晚上散步的时候，让其排粪尿，每天观察粪便状况，发现问题及时治疗或采取措施。

要给犬建造一个舒适冬暖夏凉的住所，因为超小型和小型犬对冷热比较敏感。一般用纸箱来做犬窝，里边铺上柔软的垫物，放在安静、光照充足的地方。同时给犬选一个排粪尿的地方，最好用一个小盆，里边装砂子，砂子上边铺上报纸，报纸要勤换。夏天犬住的屋子也要防蚊虫，出去散步时也要防蚊虫叮咬，因为蚊虫叮咬能传染血丝虫病。

喂犬的食物要一次喂完，剩下的食物要扔掉，夏天不要让苍蝇叮犬的食物，也不要喂腐蚀变质的食物。

成年犬因为身体已长成，有时有挑食的现象，这是一种非常不好的习惯。如果不是食物本身质量问题和犬身体不适，要及时进行纠正。其方法是，犬不吃或挑剩下食物拿下去，不给任何东西吃，下顿再喂它，如果还不吃再饿一顿，千万不要可怜它，这样，经过几次挨饿以后，便不再挑食了。

成年犬由于遗传的原因，有吠叫的习惯，不仅影响休息，而且来客人时也有伤大雅。当犬吠叫时，斥责他，并说“不可以”，当犬听了主人的话停止了吠叫，马上用抚摸进行奖励，或说“乖乖”。有的犬吠叫不止，要给戴上口罩。训练犬不吠叫应在小时候训练。

半年应进行一次健康检查，发现疾病及时治疗。由于犬经常出去散步，容易感染上跳蚤和虱子，要定期涂药进行驱除。每半年清除一次牙垢。半个月洗一次澡。

成年犬容易患血丝虫病、麻疹病、传染性肝炎、齿槽脓肿、外耳炎等，要注意防治。

9. 老年犬的饲养管理 一般犬过了6岁便进入更年期，7—8岁便进入老年期。老年犬需要喂给营养丰富的饮食，要增加蛋白质饲料的含量。食物中要减少食盐的含量，也可不给食盐。

要适当运动和给予充足的光照。每个月洗1次澡。要注意保温、防中暑。老年犬易患便秘，如果3天不排粪便，要给予洗肠。

三、犬的训练

犬不仅具有勇敢机警，胆大心细、反应灵活、善于跑跳，忠于主人等特性，而且还具有敏锐的嗅、视、听觉，因此，比较容易被训练。经过专门训练的犬，可以用于探矿、放牧、狩猎、警戒、巡逻、搜索、警卫、送信、追踪、导盲、表演、检查行李、检测煤气管道等，成为人们特殊的助手和忠实的“朋友”。大量的事实证明，一条训练有素的犬可以完成人难以完成的工作。据资料记载，在苏联卫国战争期间，有6万只军犬服役，共送了20多万份战争情报，运送了近6000公斤弹药，排除了300多座城市的地雷，救出了60万人次负伤官兵。瑞士于1971年成立了救灾犬协会，已拯救了50余人的生命，找到了400多名受害者的尸体，其成功率达90%以上。荷兰一家煤气公司一头经过训练的狼种犬检查煤气漏气准确率达100%，后到英国作业，嗅出地下200余处的煤气管道漏气。我国6岁的军犬“兰高”，在边防执勤中，多次出色地完成任务，在围歼入侵敌人战斗中，它跟踪可疑的脚印追捕，第一个勇猛地扑向敌人，和战士一起活捉敌中尉、少尉8人，荣立二等功和三等功各一次。英国军犬“朱迪”，由于在日军战俘营中表现极其勇敢顽强，并以其高度的警觉和智慧挽救了众多生命，于1946年4月29日在英国伦敦获得“动物维多利亚十字勋章”，去世后，其墓碑上写道：“一条勇士般出色的犬，它献给人类的比它得到的多

得多”。由于犬对人类有如此重要的贡献，因此，世界各国普遍重视犬的训练与应用。

（一）训练犬的理论依据

理论是实践的向导，只有掌握了犬的特性和训练犬的基本理论，才能使训练工作更加具有预见性和科学性，以收到较好的训练效果。

犬之所以能被训练，是因为它具有发达的神经系统和高级神经活动的机能。

1. 非条件反射和条件反射 反射活动是中枢神经系统的基本活动形式。伟大的生理学家巴甫洛夫把反射活动分为非条件反射和条件反射。

（1）非条件反射。先天就有，即生下来就有的反射叫做非条件反射，也就是俗话所说的“本能”。这种反射是神经系统反射活动的低级形式，它有固定的神经反射路径，不容易受客观环境影响而改变，比如初生小犬的吃奶反射，幼犬或成年犬的猎取反射等都属于非条件反射。能引起非条件反射的刺激叫非条件刺激，比如，食物一接触犬的口腔，就会引起唾液分泌。食物是非条件刺激，唾液分泌是非条件反射。

在训练犬的过程中，就是利用犬的非条件反射作为基础，施加特殊的影响手段，使犬养成我们所需要的工作能力，这些能力就是在非条件反射的基础上形成的条件反射。

（2）条件反射。通过后天接触环境、训练等而建立起来的反射，叫条件反射。换句话说，条件反射不是先天就有的，不是遗传的，而是后天获得的。条件反射是反射活动的高级形式。凡能引起条件反射的刺激叫条件刺激。条件刺激

在条件反射形成之前，对这个反射是一个无关的刺激，只有经常与某种反射的非条件刺激同时出现，才能成为条件刺激。以后单独作用时，能引起与非条件刺激相同的反射活动。比如，食物进入犬的口腔引起唾液分泌，这是非条件反射。如果食物进入口腔之前或同时，给以铃声刺激，最初铃声和食物没有联系，只是作为一个无关的刺激而出现，铃声并不能引起唾液分泌，但是，如果铃声和食物总是同时出现，或者响铃了就喂食物，经过多次结合之后，只给铃声刺激而不给食物，也能引起唾液分泌，形成了条件反射。这时的铃声就再不是无关刺激了，而成为食物到来的信号，即条件刺激。

由此可见，无关刺激与非条件刺激在时间上的结合，即强化，是形成条件反射的基本条件。这一点，在训练犬的过程中非常重要。因为从理论上讲，条件反射的形成，是由于使用不同的刺激，在犬的大脑皮层所引起的各兴奋点之间，发生了神经性接通的结果。比如，在训练过程中，为使犬对“立”的口令这一声音刺激形成条件反射，就需要在发出这一声音的同时或稍后，伴随用左手向上托起犬的后腹部，使犬作出立起来的动作。开始“立”的声音刺激通过犬的外耳，沿传入神经传入大脑，在大脑皮层的某一区域产生一个兴奋点，这时犬就表现出倾听声音的动作。接着用手向上托起犬的后腹部，又在犬的大脑皮层另一区域产生一个兴奋点，这时犬马上立起。如果把这两种刺激结合起来，就会同时在犬的大脑皮层不同区域内产生两个兴奋点。重复使用若干次后，这两个兴奋点就会从生理机能上发生联系而接通起来。此后，只要使用“立”的声音刺激，而不用用手向上托起犬的后腹部，犬就能立起来，这就是条件反射的形成。

条件反射不仅可以在非条件反射的基础上形成，而且还可以在已巩固了的条件反射的基础上形成新的条件反射，这叫二级条件反射。在训练犬的过程中使用的手势，大多数是在对口令形成了条件反射的基础上形成的。

2. 非条件抑制和条件抑制 以兴奋过程为特点的反射即条件反射和非条件反射统称阳性反射；而以抑制过程为特点的反射即非条件抑制和条件抑制，称为阴性反射。在训练中可利用犬的神经系统的抑制过程来消除犬的某些不良联系。

(1) 非条件抑制。非条件抑制是犬先天就有的。分为外抑制和超限抑制。

外抑制就是一种兴奋的出现对原来兴奋制止的现象。如，正在训练犬做某一动作时，突然在犬的周围出现了飞机轰鸣声或噪音等犬不适应的刺激，这种刺激引起的大脑兴奋使犬立即停止了正在做的动作。有时由于犬体内的某种刺激，如膀胱膨胀、直肠里有粪便等都能引起条件反射活动产生抑制。一般来说，外抑制现象是暂时的，有一些是可以通过训练来克服的。但有一些外抑制是恒定的，不能消失的。如犬某器官或局部发炎、直肠有粪便等，什么时候出现，犬就立即产生外抑制，影响训练正常进行。因此，在训练犬初期要尽量选择安静的环境，以免产生外抑制。待犬能顺利地按照口令和手势做动作时，再逐渐进入比较复杂的地点进行训练。在训练前要对犬进行健康检查和让犬排净粪便。

超限抑制又叫保护性抑制。由于刺激的强度过大，超过了大脑皮层神经细胞机能的限度而产生的。刺激强度超限越大，抑制的程度就越深。比如，突然而剧烈的声响可能引起某些犬在几天内完全处于抑制状态，不仅条件反射被抑制，

而且连某些非条件反射也都受到抑制。在训练中，过大声音的口令或过于强烈刺激以及过于频繁地进行同一动作的训练，不仅不能使犬作出正确的动作，反而会导致超限抑制的产生，使训练效果越来越坏。因此，在训练中，当发现由于对某一动作训练过于频繁或受其它刺激而产生超限抑制时，应立即停止训练或休息一下。经过一定时间的休息，犬又能很好地接受训练，顺利地做出动作。

（2）条件抑制。条件抑制只有在一定的条件下才能产生。其形成过程和条件反射一样，是后天获得的。按其发生条件，分为消退抑制、延缓抑制和分化抑制等。

消退抑制是条件刺激失去了原有的兴奋效果而重新获得了抑制作用。伟大的生理学家巴甫洛夫做过一个著名的实验，当喂给犬食物时，给以铃声，犬就分泌唾液，经过一段时间，光给铃声不给食物，犬也能分泌唾液，这就形成了条件反射。但是，久而久之，只给铃声而不给食物，犬听见铃响，也不分泌唾液了，这就产生了消退抑制。根据这一原理，我们在训练犬时，对于已经训练好的成果，要注意适当的给予强化，使其巩固，避免消退。同时对于犬在训练中产生的不良联系时，则应进行消退。比如，在训练中使用“好”的口令结合给食物强化，使犬形成了条件反射。“好”的口令就具有食物到来的信号意义，能引起犬的食物反应。但是，如果长时间只单独使用“好”的口令而不给食物强化，“好”的口令就会逐渐失去条件刺激的信号意义，犬就不再对“好”的口令发生兴奋，即产生了消退抑制。为了不使犬对“好”产生消退抑制，要经常说“好”的时候给以食物刺激。

延缓抑制：延缓抑制是培养犬忍耐能力的基础。例如，

训练犬坐下或卧下不使其随便走开，并能等待一定的时间，就是利用延缓抑制原理。它是由于延长条件刺激与非条件刺激结合的间隔时间而发生的抑制，就是在条件刺激作用后，不马上给予非条件刺激强化，而是间隔一定的时间，如3分钟以后才给予强化。这样就使兴奋性反应延缓到间歇的3分钟終了，当接近强化时才出现。

分化抑制：是犬对条件刺激相近似的其它刺激所产生的抑制。分化抑制是犬对外界复杂多变的刺激加以精确分析的基础，对于培养犬的鉴别和追踪能力具有重要作用。在训练犬进行追踪和鉴别时，因为只对犬反应正确的气味给予强化，而不强化其错误反应。所以，犬只对受到强化的气味刺激发生兴奋反应，而对未受强化的气味刺激表现抑制。分化抑制也像其它条件抑制一样，有被新异刺激的作用解除的可能。同时，大脑皮层相应中枢的兴奋性过高，也会使分化抑制遭到破坏而变为兴奋。如犬在饥饿时或刚进行了扑咬训练，由于食物中枢或防御中枢的兴奋性升高，就会解除分化抑制，犬就不能准确地辨别气味。因此，在训练中应尽量在喂食后再进行训练，以使犬做出正确的动作。

3. 犬的神经活动类型 根据犬的大脑皮层兴奋和抑制过程的强度、均衡性及灵活性等特点，可分为4种神经类型，即兴奋型、活泼型、安静型、弱型。

(1) 兴奋型。其特点是兴奋过程相对比抑制过程强，两者不均衡。行动特征是攻击性很强，好斗，总是处于活动状态。形成阳性条件反射比较容易，而形成阴性条件反射则比较困难。

(2) 活泼型。这种类型犬的特点是兴奋和抑制过程都很强，而且均衡，灵活性好。行动特征是很活泼，对一切

刺激反应很快，动作迅速。阳性或阴性条件反射都容易形成。

（3）安静型。其兴奋和抑制过程都很强，而且均衡，具有较强的忍受性，但灵活性不好。行动特征与活泼型的狗完全相反，表现极为安静。阳性和阴性的条件反射形成都比较慢，但形成后却很巩固。

（4）弱型。其特点是兴奋和抑制过程都很弱，很容易产生超限抑制。行动经常表现为“胆怯”和“颓唐”。

4. 训练中使用的刺激种类 在训练中，犬的每一种能力的养成，都是训练人员或犬的主人使用一定的刺激，有效地作用于犬的神经系统的结果。刺激的种类按其性质分为非条件刺激和条件刺激。非条件刺激包括机械刺激和食物刺激，条件刺激包括口令和手势。

（1）机械刺激。主要指抚拍、按压、扯拉牵引带、轻打以及使用刺钉脖圈等。除抚拍作为奖励手段外，其它均属于强制手段。

机械刺激能引起犬的压觉、触觉和痛觉，从而迫使犬做出相应的动作和制止某些不良行为。不同强度的机械刺激能引起犬的不同反应。弱刺激能引起弱反应，强刺激能引起强反应，超强刺激能使犬产生超限抑制，甚至产生神经症。因此，在训练中，既要防止对犬使用超强刺激，以免使犬产生超限抑制或出现害怕训练人员或逃避训练等现象，又要避免因使用刺激过轻或不敢使用刺激而妨碍条件反射的形成和巩固。一般来说，以采用中等强度的刺激比较适宜。

（2）食物刺激。在使用食物刺激时，只有当犬对食物表现足够的兴奋时，才能收到良好的效果。为了提高食物的刺激作用，在训练中可利用小块食物，在诱导犬做出动作之

前先加以逗引，以提高犬对食物的兴奋性。食物刺激能使犬迅速地形成坐、卧、吠叫、前来等条件反射，并能增进对训练人员的依恋性。但是，这种训练方法使犬的动作不易准确，对食物反应不强的犬，当环境中出现新异刺激影响时，会使训练失败。在训练中，如将机械刺激和食物刺激配合起来使用，可收到良好效果。用机械刺激来迫使犬做出一定的动作，用食物来做奖励。例如，在训练犬“坐”的动作时，训练人员在发出“坐”的口令时，用手按压腰角的机械刺激，当犬坐下来后，又立即给予食物刺激作为奖励。这种奖励既强化了犬的正确动作，又缓和了犬对机械刺激所产生的被动防御反应或抑制状态，使犬准确、兴奋地做出动作。

（3）口令。口令与相应的非条件刺激结合使用，才能使犬对口令形成条件反射。犬具有敏锐的听觉，能正确区分同一口令的不同音调，并形成条件反射。训练中使用的口令音调分为普通音调、威胁音调、奖励音调。普通音调，音量中等，并带有严格要求的意味，用以命令犬做出动作；威胁音调，声音严厉，用来迫使犬做出动作和制止犬的不良行为；奖励音调，声音温和，用来奖励犬所做出的准确动作。

（4）手势。是训练人员用手的一定姿势和形态来指挥犬的一种条件刺激。犬对手势的条件反射是结合非条件刺激或在犬对口令形成条件反射的基础上建立起来的。训练中使用的姿势要有独立性和易辨性，并要保持姿势的定型与准确性。姿势要与日常惯用动作显著地区别开。

5. 训练要领 主要包括诱导、强迫、禁止和奖励等。

（1）诱导。诱导是指用食物、物品、自身的行动等诱使犬做出某种动作，借以建立条件反射的一种手段。如在下达“坐”的口令同时，拿一块肉让犬看，不给它吃，而是将

拿肉的手徐徐抬高到犬的头顶以上，这时犬就会用眼睛盯着肉坐下来等待。训练幼龄犬时，使用诱导手段比较适宜，特别是对训练嗅认和分析气味效果较好。在使用诱导手段时要注意掌握好时机，不要始终不变的使用，防止以此取代口令、手势的作用。诱导若与一定程度的强迫手段结合使用，效果更好。对沉着安静、兴奋性不高的犬可多采用，而对兴奋灵活的犬要少用。

（2）强迫。是指使用机械刺激和威胁音调的口令，迫使犬准确而顺利地做出相应动作的一种手段。在建立条件反射初期，强迫手段的刺激强度要适中，以迫使犬做出动作，并对口令形成条件反射。比如，训练人员以普通音调发出“坐”的口令，同时结合按压腰角的机械刺激，迫使犬坐下来。这样，犬就能很快形成条件反射。当进入到复杂环境训练后，由于外界刺激的引诱，犬往往不能顺利地执行口令，常有延误做出动作的表现。这时，必须采用威胁音调的口令结合强有力的机械刺激，强迫犬做出动作，这时给予抚拍奖励或食物奖励。这样，多次结合使用的结果，犬就能对口令的威胁音调形成条件反射。以后即使单独使用威胁音调的口令，也同样能迫使犬顺利地做出动作。在使用强迫手段时要运用得及时、适度，尤其是对灵敏性较强的犬或比较胆小的犬，刺激强度则应适当小些。

（3）禁止。是训练人员为了制止犬的不良行为而采用的一种手段。它是用威胁音调发出“非”的口令，同时与强有力的机械刺激结合起来使用。比如，当犬在追捕家禽或随地拣食时，训练人员应及时用威胁音调发出“非”的口令，同时结合猛拉训练绳的机械刺激加以制止，这样反复结合使用，只使用“非”的口令，就能达到禁止的目的。在使用禁止手

段时，态度必须严肃，但不要打骂犬。每当犬闻令停止不良行为时要及时给予奖励，以肯定犬的成绩，缓和其紧张状态。

（4）奖励。奖励是为了强化犬的正确动作，巩固已养成的能力，调整其神经活动状态而采取的一种手段。奖励的手段包括食物、抚拍、衔取物品、游散和“好”的口令等。

游散是一种很好的奖励办法。当犬完成一个比较紧张的动作以后，放开犬，任其自由活动片刻，以此来缓解犬的神经紧张状态。还可利用犬对衔物的高度兴奋，满足它衔取欲望的办法来奖励，当犬完成一项预定的动作后，除了以“好”的口令奖励外，立即拿出犬比较兴奋的物品，稍加逗引后抛向远处，让犬衔取。这种奖励方法，对提高犬接受训练的积极性很有好处。

奖励在训练中虽然很重要，但要运用得法，否则，收不到好的效果。首先奖励要及时，掌握住时机；其次要根据不同的训练项目和不同神经类型的犬灵活掌握。

（二）训练犬的方法

不管是警犬、猎犬、军犬，还是看门犬、玩赏犬，其训练原理及方法基本相同。

1. 受训犬的选择 绝大多数品种的犬都能接受训练。但最理想的受训品种是狼犬，即牧羊犬种。

要挑选身体各部结构匀称、肌肉发达、雄健强壮、姿态端正的犬来训练。受训犬的最佳年龄为6个月到1岁。其体高、体长、毛色不限。但要训练警犬、猎犬、军犬，要求成年母犬最好体高不低于50厘米，公犬不低于55厘米，体长与体高比为10:9；神经类型为活泼型和兴奋型，安静型也

可；听力、视力良好，嗅觉灵敏，嗅认方式好；猎取反应、主动防御反应和食物反应占优势。

2. 训练原则 犬的训练原则是“循序渐进，由简入繁，因犬制宜，分别对待”。

(1) 循序渐进、由简入繁。犬的每一种完整能力的养成，都是按一定的程序进行训练的结果。这种程序必须符合先易后难，由简入繁，循序渐进的客观规律。一般来说，犬的能力培养程序分三个阶段。

第一阶段，是培养犬对口令建立基本条件反射的阶段。只要求犬根据口令做出动作。比如，当犬听到“坐”的口令坐下即可。在这个阶段中，必须选择清静的训练环境，以防外界引诱刺激对训练的干扰。当犬按口令做出动作时要及时给予奖励，对不正确的动作要及时耐心地加以纠正。

第二阶段，是条件反射复杂化阶段。要求犬将各个独立形成的条件反射有机地结合起来，形成一种完整的能力。同时，在犬对口令形成条件反射的基础上，建立对手势的条件反射。在这个阶段中，训练环境不宜复杂化，但可以经常更换训练环境，使犬逐渐适应复杂环境。对犬能迅速而顺利执行训练人员或主人的口令，要及时给予奖励；对犬不正确的动作和延误执行口令的行为应及时纠正，要运用强迫手段，适当增加机械刺激的强度。

第三阶段，是训练环境复杂化阶段。要求犬在有引诱刺激的情况下，仍能顺利地执行口令。开始，犬可能会对新异刺激产生探求反射和防御反射，而对口令不发生反应或延误执行口令。这时训练人员必须加强口令的威胁音调，并结合强有力的机械刺激，迫使犬做出动作。当犬一旦按要求做出动作时，要及时给予奖励。这个阶段的训练，动作不要太

难，最好在早晨或夜间进行。

通过以上三个阶段的训练，犬的基本能力初步养成，但不可能完全适应实际需要。还必须根据所在地区的气候、地理环境条件等情况，有计划地不断进行适应性锻炼，逐步提高犬的能力。

(2) 因犬制宜、分别对待。对兴奋型犬要逐步改善和发展它的抑制过程，不能急躁。比如，培养延缓抑制能力时，延缓的时间必须从最初的几秒钟开始，逐渐延长到几分钟，并要长短相结合。提高的幅度要小些，进度要慢些。对于活泼型的犬，在训练时要特别注意影响的手段，如果训练方法不当，容易产生不良联系；对于安静型的犬，在训练中需要重复口令和采取强迫手段，以培养其灵活性和提高其兴奋性，要避免连续地发出不同的口令或使用兴奋和抑制相冲突的刺激，应沉着、冷静、耐心地进行训练；对食物反应较强的犬，应多用食物刺激；对凶猛好斗的犬，应加强依恋性和服从性的训练；对有被动防御反应的犬，要用温和的音调，动作要轻，在训练中，当犬遇到害怕的事物时，要采取耐心诱导的方法，使其逐渐消除被动状态而适应训练内容；对于探求反应较强的犬，平时要多进行环境锻炼，训练前让其看一下周围环境。

3. 基础动作的训练 犬的基础动作训练内容主要有“游散、前来、坐、立、卧、叫、静、跳、登降、窜越、匍匐、衔取”等。其目的是为下一步使用科目的训练打基础。重点是培养其服从性。

(1) “游散”的训练。游散训练是使犬养成按主人指挥进行自由活动的的能力，以此来缓解犬在训练和使用中所引起的神经紧张状态，也是训练人员作为奖励犬的一种手段。

口令：“游散”；手势：右手指向犬要去的方向。

被训练的犬戴上脖套，脖套上系上绳子，训练人员用训练绳牵着犬向前奔跑，待犬兴奋后，即放长训练绳，同时以温和音调发出“游散”的口令，并结合手势指挥犬进行游散。当犬跑到训练人员面前，训练人员应立即慢慢停下，使犬自由活动几分钟，然后训练人员令犬到其身边，给以抚拍或食物奖励。这就完成一次训练，通过若干次训练后，犬便能根据训练人员的口令和手势进行自由游散。此时，可解去训练绳，使犬进行充分的自由活动，但离开训练人员不应超过20米。如离的太远，立即召唤回来，加以抚拍后继续游散。在游散时，如有的犬扑咬人、畜或随地拣食等恶习，要用训练绳控制，并及时发出“非”的口令。在整个训练中，训练人员的态度应和蔼，表情应活泼。

（2）“前来”的训练。目的是使犬在训练人员的指挥下，能顺利地来到其左侧身边坐下的能力。

口令：来；手势：左手向左平伸，然后自然地放下。

训练人员趁犬拖着训练绳游散时，先叫犬的名字，之后发出“来”的口令，同时边扯拉训练绳边向后退，以迫使犬前来。当犬来到训练人员面前，应及时给以抚拍或食物奖励。经过多次训练，犬就能根据“来”的口令顺利地跑到训练人员面前。也可用食物和能引起犬兴奋的物品诱导其前来的方法进行训练。即在发出“来”的口令同时，拿食物或物品引诱犬，当犬来到身边时，及时给以奖励。经过多次训练后，犬便对“前来”的口令和手势形成条件反射。

在此基础上进一步培养犬前来靠训练人员左侧坐下的能力。当犬前来时，用食物将犬引诱到身体左侧令其坐下，然后给予食物；也可当犬前来时，用左手将犬的脖套拉住，轻

轻向左后方带引。当犬身体转正后，令犬坐于左侧，并及时进行奖励。在刚训练时，如有的犬听到口令而不前来，训练人员应采取后退、拍手、蹲下或向相反方向急跑等容易引起犬兴奋的动作，促使犬前来。当犬来后，立即给予奖励，再以正常动作牵犬，千万不要捉犬。如果有的犬闻令后四处乱跑，应用威胁音调发出口令，并急拉训练绳迫使犬前来。当犬来到训练员跟前，应马上给予奖励。

（3）“坐下”的训练。要求犬能按要求，迅速而正确地做出坐下的动作，并保持这一动作能停留较长的时间。

口令：“坐”；手势：训练人员正面坐时，右大臂向外伸平，小臂向上垂直，掌心向前，整个成“L”式。

这个训练分三步进行。第一步训练其坐的能力。训练人员让犬靠左侧站立，然后发出“坐”的口令，同时右手上提脖套，左手按压腰角。当犬被迫做出“坐”的动作后，立即给予奖励。经过多次训练后，犬就能养成坐的能力。在此基础上进行第二步训练，即培养犬对正面坐的手势形成条件反射。其方法是用左手握住牵引绳（也叫训练绳），把犬引到自己对面，右手先做出“坐”的手势，接着发出“坐”的口令，同时左手上提牵引绳，迫使犬坐下。当犬坐下后即给予奖励。通过多次训练即可对手势形成条件反射。第三步是训练犬坐下后的延缓能力。训练人员牵着犬令其坐下，然后持牵引绳一端，慢慢离开犬1—2步远，如果犬有起立或起立走动的表现时，应立即重复“坐”的口令，并伴以牵拉训练绳，迫使犬回到原位坐下。犬如能在3—5秒钟内坐着不动，应立即给予奖励。以后逐渐延长坐的时间。当犬能在较短距离内坐着5分钟以上不动时，就可以培养犬在距训练人员20米以外处坐着。在延长距离的训练过程中，可用牵引训

练绳的办法过渡，最后去掉训练绳。

在坐下能力训练过程中，要循序渐进，不能操之过急。在训练下一个动作时，要先巩固前一个动作，并使之连贯。当犬能连贯地做出这一动作时，再把犬放到比较复杂的环境中去训练。

(4) “卧下”的训练。使犬迅速正确地卧下，并在没有命令的情况下不得起立。

口令：卧；手势：右手上举，向前平伸，手心向下。侧面卧是以右手从犬面前向下伸。

先使犬对“卧”的口令形成条件反射。其方法是，令犬坐在训练人员左侧，训练人员右腿向前迈一步，身体向前下方弯下，右手持食物引诱犬。当犬想获取时，趁机把食物从犬嘴的下方慢慢向前下方移动，同时发出“卧”的口令，并伴以向前下方牵拉训练绳。当犬卧下后，及时给予食物奖励。随着条件反射的形成，逐步将食物和机械刺激取消，而以口令和手势令犬卧下。也可用另一种方法训练，即训练人员令犬在其左侧坐下，训练人员左腿后退一步，蹲下，两手分别握住犬的两前肢，发出“卧”的口令，并将犬两前肢向前拉伸，同时用左臂压犬的肩胛。当犬正确的卧下后，立即给予奖励。

当犬具有卧下的能力时，要进一步训练其能在与训练人员隔一定距离情况下卧下的能力。先令犬坐下，走到犬的前面1—2步处，面向犬，左手持训练绳，右手作出“卧下”的手势，同时发出“卧”的口令。如一次不成功，就重复手势和口令，并向前下方拉扯训练绳。当犬卧下及时给予奖励。如果犬能在距训练人员1—2步远的距离内，根据口令和手势顺利地做出卧下动作后，可以在训练绳控制下逐步延长指

挥距离到20米远。此举成功后，应采取将训练绳放在地上进行训练，以逐步过渡到解去训练绳。如果犬因除去训练绳而不能顺利卧下时，则可采用威胁音调重复口令，并伴以机械刺激促迫犬卧下。以后逐渐减少口令而用手势指挥。

当犬养成上述能力后，应进行卧下动作的延缓训练，其方法和培养犬坐下延缓的能力相同。犬如能在20米左右距离内，按口令或手势迅速正确的卧下，延续5分钟以上即达到要求。以后可以让犬到比较复杂的环境中去训练。

(5) “站立”的训练 使犬养成在一定地点站立不动的能力。

口令：“立”；手势：右臂自下而上向前平伸，手掌向上摆动。

先使犬对“立”的口令形成条件反射。训练人员把犬带到较清静而又平坦的地方，让犬坐下。在发出“立”的口令同时，右手握犬的脖圈，左手伸向犬的后腹部向上托，以使犬立起。当犬站立起时，应及时给予奖励。经过多次训练后，当犬听到“立”的口令就能立即站起时，训练人员要逐步远离犬的身边，使犬养成站立的持久能力，其方法同坐下延缓的训练。在此基础上训练犬按训练人员的手势要求而站立，并能持续一定时间的能力。其方法是，站在犬前方，对犬做出“立”的手势，同时给以口令。如犬不站立，仍需托腹协助犬站立。经过反复训练，犬就能对手势形成条件反射。此时即可转入单独用手势指挥犬站立。在短距离内，犬能按训练人员手势要求而站立即可。

(6) 不乱咬人、畜、禽的训练

口令：“非”。

训练人员把犬带到有车辆、行人和畜禽的地方，松开训练绳使其自由活动。如犬有扑咬动作时，立即用威胁音调发出“非”的口令，同时猛拉训练绳。当犬停止扑咬后，用“好”的口令加以奖励。经反复训练后，逐步不用训练绳。直到当犬一听到口令就能不扑咬人、畜禽即可。

（7）不随地拣食和拒食陌生人给予食物的能力的训练。

口令：“非”。

训练犬不随地拣食的方法是，事先把食物放在环境清静明显的地方，牵犬接近放食物的地方，当犬有吃的表现时，立即用威胁音调发出“非”的口令，并伴以猛拉训练绳刺激，不让它吃。当犬停止拣食，应及时给以抚拍奖励。然后纵犬游散，反复训练。在此基础上，将食物放在矮草丛中等隐蔽的地方，仍采取上法进行训练。如在近距离内能制止犬拣食的不良行为，即可改用训练绳进行控制，直到除掉训练绳犬能按口令要求停止拣食为止。为了防止犬对“非”的口令的条件反射发生减弱或消退，要经常结合机械刺激予以强化。

拒食陌生人给予食物的训练方法是，训练人员把犬牵到训练场地，一名助训人员很自然地接近犬，并给予食物，如犬想吃，助训人员就轻击犬嘴。然后再让犬吃，若犬仍有吃的表现时，再给予较强的刺激。此时，训练人员发出“叫”的口令，并假装打助训人员给犬助威。当犬对助训人员吠叫，助训人员趁机逃跑，训练人员应给犬以奖励。也可采取助训人员将食物扔到犬的眼前后离去的方法，如犬要拣食，训练人员立即发出“非”的口令，并猛拉训练绳，如犬不再拣食，及时给予奖励，任其游散。在此基础上，训练应再提高

一步。训练人员用绳子把犬拴在一个物体上，训练人员躲在隐蔽的地方，手持训练绳的一端。助训人员走近犬，扔下肉块或犬喜食的食物，如犬表现取食时，训练人员在隐蔽处发出“非”的口令和猛拉训练绳，连续训练2—3次。若犬不再拣食时，助训人员离去，训练人员从隐蔽处出来，给犬以奖励和游散。

（8）跳跃的训练

口令：“跳”；手势：右手向障碍物一挥。

训练先从跳30—40厘米高的障碍物开始。训练人员把犬牵到障碍物面前，在距障碍物2—3步处令犬坐下，训练人员持训练绳一端，走到障碍物侧面对犬发出“跳”的口令，同时向障碍物的方向拉扯训练绳。当犬跳过去后，及时给予奖励。重复训练3—4次。也可用下法训练，训练人员牵犬从距障碍物5—6步处跑到障碍物跟前，此时发出“跳”的口令，同时向障碍物前上方拉扯训练绳，使犬跳过去。当犬跳过去后给予奖励。连续训练3—4次。

接着训练犬根据口令和手势独立跳跃的能力。先让犬在距障碍物3—5米处坐下，训练人员走到障碍物跟前，令犬前来。当犬跑来时，即发出“跳”的口令和手势。犬如能顺利跳过。说明已对口令和手势建立了条件反射，要及时给予奖励。以后的训练应逐渐增加高度。

（9）“登降”的训练

口令：“上”、“下”；手势：右手向障碍物一挥。

训练人员把犬带到阶梯跟前，发出“上”的口令，同犬一起登上。在上的过程中，不断发出“上”和“好”的口令。当犬走上平台，及时给予抚拍和食物奖励。之后，发出“下”的口令，带犬慢慢下来，在下的过程中，不断发出

“下”和“好”的口令。也可以用食物或物品引诱的方法来训练，把食物或物品当犬的面放在平台上或摆在阶梯的各层，然后发出“上”的口令。

当犬能上下阶梯后，可进一步训练犬根据口令和手势自己上下。其方法是，令犬在离阶梯1米处面向阶梯坐下，发出“上”的口令和做出手势，如犬表现犹豫，应提高音调重复口令。上去后，稍停一会儿，再发出“下”的口令，如犬不能根据口令走下阶梯，应发出“来”的口令，并装出要跑的样子，诱犬下来。当犬根据口令上下时，要及时给予奖励。下一步训练是在给口令的同时，配以手势。当犬能按口令和手势顺利地单独上下后，就可训练登天桥、独木桥等。其训练方法同上。

(10) “前进”的训练。使犬养成根据口令和手势，沿着一定方向前进的能力。

口令：“去”；手势：训练人员左腿跪下，右臂平伸向前，手掌向里指向前进方向。

让犬在较清静的环境坐下，训练人员在犬注意的情况下，向前走出20米左右，做假放物品的动作后返回犬的右侧。用左手握住犬的脖套，以口令和手势令犬前进。当犬到假送物品地点后，让犬坐下，迅速到犬跟前给以奖励。以后逐渐延长前进的距离到50米左右。再渐渐去掉假送物品的动作，只用口令和手势指挥犬前进。当犬能顺利按训练人员口令和手势要求前进50米左右即可。

(11) “静”的训练。主要训练犬安静的能力。

口令：“静”。

训练人员把犬带到训练场，助手轻手轻脚地走到犬的身边，当犬要叫时，训练人员及时发出“静”的口令，同时轻

击犬嘴，禁止犬叫出声来，保持安静。经过多次训练，犬就能对“静”的口令或用手轻击嘴形成条件反射。

玩赏犬对主人的依恋性很强，当和主人在一起时，它会安心地玩耍或呆在某一角落。当主人上床休息或离家时，它会发出呜咽甚至哭叫，影响主人或别人休息。因此，对其进行安静训练尤为重要。

训练方法多种多样，一是可用上法进行训练。二是给小犬准备一个小箱，里边垫一片旧垫子或破毯子作为犬窝。把小闹钟放在犬窝里旧毯子的下边，令犬进去休息，同时主人把灯闭了，上床休息，经过几次训练后，犬便能在主人闭灯后进窝休息。因有小闹钟滴答声可使犬不觉寂寞，犬便不乱跑、乱叫了。待条件反射巩固以后，便可拿掉小闹钟。

训练小犬在主人离家时安静休息的办法是，把小犬关在它常住的屋子里，准备些小犬喜欢玩的物品。当主人离开时，听到小犬叫声，主人便开门，发出“静”的口令，给些玩的东西，然后把门关上。以后逐渐延长开门观看的时间，使犬感到主人就在附近。经过多次训练后，犬便不会再吠叫或喧闹了。

(12) “定点、定时大小便”的训练。训练方法比较简单，也多种多样。一般是让犬在固定的地点饲喂，之后让犬到外边去游散，并指定地点让其排便，如果排错了地方，用手或小刷子轻轻打它，边打边说“不许这样”或“错了”。如果让犬在屋里大小便，要给犬准备一个容器，里边放上碎纸、木屑等。每次喂完以后，让犬进去排便。如果排错了地方，轻轻打它，并说“不许这样”或“错了”。经过若干次训练之后，犬便能养成定点、定时大小便的习惯。

4. 实用技能的训练 当犬经过基础动作训练以后，即可

转入实用技能的训练。主要包括扑咬、嗅物、嗅人、追踪、搜索、巡逻和警戒等训练。这里只介绍常用的几项。

（1）扑咬的训练

口令：“袭”、“放”、“注意”；手势：右手食指指向扑咬对象。

助手化好装，带好护具，隐蔽于训练场内，训练人员把犬牵到训练场内，令其朝助手隐蔽的方向坐好，对犬发出“注意”的口令，右手指向要犬注意的方向。助手听到“注意”口令后，立即出现并发出声响，以引起犬警觉。在逗引过程中注意犬的表情，犬若胆大，就逐渐接近，设法激起犬的仇视。这时训练人员发出“袭”的口令。但不立即放开犬，只有当犬的凶猛性达到足以能够扑咬的程度时，才放犬扑咬。这时助手做出害怕或逃跑的动作，引诱犬开口撕咬。当犬咬住后，助手假装与犬搏斗，训练人员不断发出“袭”和“好”的口令，并假装打助手给犬助威。3—4分钟后，助手停止搏斗，表示屈服。训练人员发出“放”的口令，使犬放口。若有的犬不放口，要用威胁音调重复“放”的口令，或同时拉扯训练绳使犬放口。犬放口后立即给以奖励。以后逐渐开始拉长距离训练。让助手离犬远一些，当发出“袭”的口令后，让犬跑一段距离追赶助手再扑咬。训练人员要跟在犬的后边，注意犬的表现并及时给予奖励。接着逐渐进行扑咬能力复杂化的训练。

（2）“警戒”的训练。使犬养成对警戒地区严密监视，以及敏锐地发现声、光及人员活动等情况的能力。

口令：“注意”、“静”；手势：右手指向警戒方向。

警戒的训练包括守候式警戒的训练和固定式警戒的训练两种。

守候式警戒的训练方法是，选择比较清静，有树木和草丛的地方。农村住户可在院子里或村边训练。初训要在清晨和傍晚进行。助手在距训练人员80—90米的地方隐蔽好。训练人员牵犬进入预定的警戒地点隐蔽起来，令犬面向警戒方向坐下或卧下，训练人员半蹲着或蹲着，左手握住训练绳，右手指向助手隐蔽的方向，低声发出“注意”的口令。此时，助手发出声音以引起犬的注意。然后助手轻轻地向训练人员方向移动，时而停止，时而移动，有间歇地发出走动时的沙沙声，训练人员也随之有间歇地对犬发出“注意”的口令，如犬对音响有竖耳细听、探身、颈背毛竖立等表现时，应及时给予抚拍奖励。当助手走到离警戒处45—50米时，训练人员发出“站住”的口令，助手闻令假装逃跑，训练人员则随即纵犬追扑。犬扑咬住助手后将其押走，立即给狗以奖励。在训练中，如犬听到动静后过早地发出吠叫或“喔喔”的声音，训练人员应轻声下“静”的口令，并结合扯拉训练绳或轻击犬嘴等刺激来制止。以后随着训练的进展，应逐渐扩大警戒的范围，延长助手行动的时间，助手发出的声音逐渐减弱，出现的方向也要经常更换，并在不同时间和不良气候条件下进行训练，以逐步提高犬在复杂气候和环境条件下警戒的能力。

固定式警戒的训练分为拴系警戒和活动警戒两种。拴系警戒的训练方法是，在比较清静的环境内，立两根2米高的柱子，柱距60米左右。两柱间拴一铁丝，拉紧，将拴犬铁链末端的铁环套入铁丝上。在黄昏或拂晓，训练人员将犬带到警戒地点，拴在铁丝上，让犬走动几次，以熟悉铁链摩擦铁丝所发出的响声。训练人员手指向前方，发出“注意”的口令。同时，向事先隐蔽好的助手发出行动信号，助手轻步向犬走

近，并发出轻微的走步声。如犬听到声音而发出叫声，助手应停止活动，训练人员以“好”的口令和抚拍进行奖励，并重复“注意”的口令。助手再次开始活动，并逐渐接近犬，此时，训练人员再次发出“袭”的口令，让犬追扑，扑住后，将助手押走。为了使犬在夜间警戒时，对发光的刺激也形成主动防御性条件反射，助手可在训练时发出一亮一灭的光亮，并经常更换隐蔽地点和从不同的方向接近犬。

当犬养成了初步警戒的能力后，进一步培养犬单独进行警戒的能力。其方法是，训练人员把犬拴在警戒线上，发出“注意”的口令后，慢慢离开犬，到不远的地方隐藏起来。这时助手从距警戒线60米处时隐时现，用上述方法进行挑逗。如犬听到声音自动吠叫，训练人员立即从隐蔽处出来给犬以奖励，并纵犬追扑。经过多次训练后，逐渐延长助手出现和逗引的间隔时间，助手发出的声音要降低，训练人员出现的次数要减少。当犬有了警戒的基本能力以后，可进一步进行警戒能力复杂化的训练，比如结合拒食、较大声响等进行训练。

如果让犬专门警戒仓库等要害场所，可将犬直接拴在仓库门口的一侧进行训练，其训练方法同上。

活动警戒的训练方法是，训练人员把犬带入警戒区内。警戒区的围墙不得低于2米，如是篱笆，密度要小，以犬不能钻过去为好。先让犬在警戒区内游散一会儿，让其熟悉环境。接着牵犬沿围墙或篱笆进行游动，不断用低声发出“注意”的口令。事先隐蔽在墙外的助手，根据预定信号发出沙沙声或敲打墙壁声，然后越墙而入，装出向犬攻击的样子。当犬发现后，随即逃跑。此时，训练人员发出“袭”的口令，纵犬扑咬，扑咬成功后将助手押走。经过反复训练之后，犬

养成对警戒范围内发现的陌生人和声音，能大声吠叫和扑咬等主动防御反应时，即可转入单独警戒训练，使犬养成训练人员不在场的情况下，仍能发现警戒区内的一些微小声、光，并能进行搜索和袭击的能力。在训练时，训练人员应在隐蔽的地点观察犬的行动。当犬吠叫或正在与助手搏斗时出来助威，给予奖励。逐渐延长活动警戒的距离，减弱声响和光亮。当犬在一般的环境和天气条件下，对100—150米以外的声、光刺激能以吠叫表示，并能搜索和勇猛的扑咬警戒区内的人时，说明警戒训练任务已完成。

（3）“巡逻”的训练

口令：“注意”、“静”；手势：右手指向警戒方向。

当警戒训练完成以后，即可进入巡逻的训练。初次训练应在黄昏或拂晓进行。选择有稀疏的丛林和独立房屋的地段内进行。地段长一般400米左右即可，地段内要有小路。训练人员牵犬在预定的巡逻路线上往返巡逻。每走50米左右停一下，用低声向犬发出“注意”的口令，当还未靠近助手隐蔽的地点时，训练人员用信号让助手从隐蔽处发出声响和出现。只要犬听到声音竖耳细听示警或发现助手时，训练人员应立即止步，发出“注意”和“好”的口令，手指助手，让犬扑咬。

在巡逻中，还要培养犬在嗅到生人气味或听到声音就停止行动，竖耳细听的能力。其方法是，助手隐蔽在距离巡逻15米左右的上风处，训练人员牵犬沿巡逻路线缓慢地前进，并发出“注意”的口令。若犬对隐蔽的助手没有反应，应继续带犬前进。如犬在返回时仍无反应，助手应发出轻微的声音，当犬发觉后即纵犬追扑。重复训练2—3次，但每次训练应更换巡逻路线。当犬已能及时准确的发现巡逻路线附近

潜伏有助手时，要逐渐增加助手人数，并隐蔽远一些，要在夜间巡逻。还可在不让训练人员知道助手隐蔽处的情况下进行训练，以使训练人员进一步掌握犬在巡逻中的表情和提高犬巡逻的能力。经过反复训练后，犬在巡逻途中能自始至终保持高度警觉，及时发现情况和勇敢扑咬助手时，表明巡逻能力已经养成。以后在巡逻中结合搜索进行训练。

（三）训练中应注意的几个问题

犬的训练是一项技术性很强、要求较高的工作。如果训练方法得当，可收到事半功倍的效果。为了达到如期的效果，还要注意以下几点。

（1）选好训练场地，注意训练卫生。训练场地要干净平整。开始训练时要选择僻静的地方，有的训练项目要求场地要宽广，有隐蔽物。训练前要让犬排大小便，训练后，要及时让犬排便，并打扫干净身上的尘土。

（2）训练中要贯彻人犬亲和的原则。建立人犬亲和的关系，又叫建立犬对主人或训练人员的依恋性，这是训练成功的关键。犬对主人或训练人员的依恋性，主要通过饲养管理、训练过程中和平时接触建立起来的。因此，在接触犬时态度应和蔼，禁止大喊大叫，举止要正常，让犬逐渐消除对自己的防御反应和探求反应，使犬熟悉自己的气味、声音、行动特点。对咬人、畜的犬，要胆大心细，沉着应付，通过喂食、呼名，使犬的感情慢慢转变，对于那些感情转化慢的犬，只要精心饲养管理和爱护，一旦建立起依恋性，往往是很牢固的。当犬对训练人员表现亲切的兴奋反应时，便可认为是犬对主人或训练人员的依恋性已经建立。但是这种关系还需要不断巩固。无论如何，在训练中不能打犬，否则，很难

建立起亲和关系，即使建立了也易破裂。

（3）劳逸结合，注意安全。训练前，要对犬进行健康检查，有病或精神状态不佳的犬，不要参加训练。训练中要劳逸结合，训练强度较大时，要注意休息。每次训练结束时，不要让犬有过度疲劳感，以免使犬丧失对训练的兴奋性，影响以后的训练。训练中注意人、犬的安全，人要戴防护器具和穿防护衣，防止被犬咬伤。训练器材要牢固，不要弄伤犬。

（4）严格按训练计划、程序进行训练。训练犬是细致科学的工作。训练前，要根据犬的情况和训练人员的技术水平，制定切实可行的计划。在训练中按计划进行。训练要按程序进行，即先进行基础动作训练，然后进行实用技能训练。训练要由低级到高级，由简单到复杂，时间由短到长，注意训练的连续性。这样，就能收到事半功倍的效果。

四、犬病防治

(一) 口腔异常、流涎和咽下困难的疾病

口 炎

口炎系指口腔粘膜炎症，其中包括齿龈炎、舌炎及硬腭的炎症。也是全身疾病和消化系统疾病时的一个分症。

病因 异物刺激，犬有采食木片、骨片、针、草芒的习惯，由于这些异物刺激而发炎；由于细菌、真菌和病毒感染而引起；因化学药剂所造成，当治疗皮肤炎用药被犬舔发病。

症状 口腔粘膜发红、肿胀、过敏、疼痛、发热，咀嚼障碍，流涎，口内恶臭、精神不振，齿龈部出血，严重者出现溃疡和假膜。真菌性感染时，形成弥漫性炎症和溃疡，粘膜表面附有白斑，排出浓厚的粘稠的唾液。

治疗 用5%的明矾溶液、0.1%高锰酸钾溶液、1—3%硼酸溶液、0.01%雷佛奴尔溶液清洗口腔，排除渗出物和污物。严重流涎者，用硫酸阿托品0.5—1毫克，皮下注射。

涂擦药物：用复方碘甘油、冰硼散撒布、硼酸甘油等药物涂擦口腔粘膜，每日1—2次。

抗生素药物：抗生素类软膏等涂擦，每日2—3次。如有体温升高者，可注射抗生素和磺胺类药物。

除去坏死组织：严重病例有坏死组织时，可采用外科手术方法除去或用 5—10% 硝酸银溶液烧灼，烧后用生理盐水清洗。

其它：给维生素制剂，维生素B₁、B₆、C和抗血浆素剂等。

表 3 口腔异常、流涎和咽下困难的疾病

疾 病	主 要 症 状
口腔异常	
口炎	咀嚼障碍，口粘膜炎症，流涎，口腔恶臭，附属淋巴结肿大
口腔异物	流涎，搔抓颜面部，采食困难，拒绝口部触诊，口粘膜炎症
齿龈炎	流涎，齿龈炎症，采食困难，咀嚼困难
扁桃腺炎	流涎，扁桃腺肿大和突出，食欲减退，恶心，咽下困难，避免开口
口唇炎	流涎，口臭，口唇粘膜发炎，口唇皮肤炎症，被毛脱落
咽头异常	
咽炎	食欲减退，流涎，咽下困难，咳嗽， <u>呕吐</u> ，咽部压痛，呼吸困难的，下颌淋巴结肿大
食道异常	
食道梗塞	不安， <u>呕吐</u> ，咽下困难，恶心
全身性疾病	
流涎症	咽下困难，流涎
钩端螺旋体病	精神沉郁，食欲减退，口腔粘膜炎症，舌炎，口臭，黄疸，发热，血便，肾部压痛
胃扩张和扭转	腹部膨满，流涎， <u>呕吐</u> ，急死，肝脏肿大，大型犬易发，突发
犬瘟热	发热，呼吸困难，结膜炎，发咳，鼻汁、下痢，癫痫，硬脑病，皮肤发疹
狂犬病	流涎，神经症状，麻痹，不安，食欲不振，异嗜
破伤风	强直性痉挛，步样强拘，开张姿势，刺激时过敏，瞬膜脱出，开口障碍，角弓反张，不能行走

口腔内异物

口腔内有异物存在，如骨片、木片、竹片等夹入齿间，

或针、竹签、草芒等刺入粘膜而引起。

病因 异嗜。有的犬有啃咬其它物品的恶癖，消化器官障碍和乳齿脱换期，啃咬硬物而引起。误食、口腔畸形和损伤、先天性硬腭断裂以及交通事故都可引起。

症状 流涎为其主要症状。异物夹于齿间时，病犬有异物感，不断用前肢抓颜面部。由于疼痛出现采食困难。检查口腔时，可发现异物，或者粘膜出现发红、肿胀，有时有出血。

治疗 除去异物。一般取出异物，口炎立即消失。除去异物后按口炎治疗。

齿 龈 炎

本病为牙龈的急性和慢性炎症。主要特征是牙龈充血和肿胀。

病因 分为原发性和继发性牙龈炎。原发性牙龈炎一般由于齿石的堆积、齿槽骨膜炎、龋齿并发。比较少见的是外伤、异物以及腐蚀性物质而引起。继发性牙龈炎，由于慢性肾炎、营养不良、慢性衰弱而引起的潜在性尿毒症等；由于犬瘟热、钩端螺旋体病等感染而发生；维生素缺乏症、重金属中毒等也可引起。

症状 病初牙龈发红、肿胀，呈海绵状而脆弱，易出血。并发口腔炎则疼痛明显，采食、咀嚼困难，流涎。重度者，形成不同程度的溃疡，可见渗出物。牙龈萎缩，大部分齿根露出，这种变化上颌犬齿明显。重金属中毒者，牙龈边缘易出血，形成所谓的“蓝线”。

治疗 病因疗法：除去齿石，治疗齿槽骨膜炎、龋齿等。局部治疗：按口炎治疗方法处置。全身疗法：重度病变者，可采用全身抗生素或磺胺制剂疗法。对症疗法：食物中添加维

生素C、B₁等。

扁桃腺炎

扁桃腺是淋巴组织的集合体。犬的扁桃腺位于咽头部，呈细长的纺锤形，部分或全部被覆以粘膜。扁桃腺有咽头扁桃腺和腭扁桃腺之分。

扁桃腺炎是由于扁桃腺受刺激和感染而发生的。主要特征是扁桃腺发红、肿胀、食欲不振、流涎等。

病因 原发性扁桃腺炎一般由细菌感染而引起的，病原菌为溶血性链球菌和大肠杆菌。另外，由玻璃片以及在扁桃腺隐窝中的异物刺激也可发生。继发性扁桃腺炎，与其它疾病并发，如幽门痉挛、胃的新生物、支气管炎等。幼犬和成犬发病多，老龄犬发病较少。

症状 急性扁桃腺炎，扁桃腺明显发红、肿胀，隐窝突出；局部散在小的坏死灶和脓肿，扁桃腺上被覆白色乃至灰色渗出物；重症者可见体温升高，高达40℃，咽下困难，噎气，常常流涎；患犬食欲不振，噎气，有的呕吐。慢性扁桃腺炎，多数与其它疾病并发，其症状与急性疾病相类似。

治疗 **局部疗法：**用盐水、2%小苏打水、3%硼酸溶液冲洗口腔，每日4—5次，局部涂布3%碘甘油，每日1—2次，或涂擦0.05—0.1%硝酸银溶液，每日1次。**全身疗法：**广谱抗生素药剂，海他西林50—250毫克，一次量，每日2—4次，肌肉注射；或用磺胺类药物，口服或注射，第一次0.25—1.0克，以后0.1—0.5克；或用地塞米松0.5—5毫克，肌肉注射，内服，每日2—3次。给予柔软的流食。

口 唇 炎

由于损伤或感染造成唇的粘膜和唇皱襞的皮肤发生急性或慢性炎症。

病因 损伤：由于尖锐物质（缝针、木片等）刺伤而发生，或发生于咬伤。附近器官炎症的蔓延：口炎、疥癣病、真菌性皮炎等。维生素B族缺乏时也可发生。

症状 一般症状是流涎，口腔恶臭，下颌前端被湿润，污秽不洁。食欲不振，病犬用前肢抓挠颜面部。唇炎的症状，粘膜发红，形成浮肿性肿胀或溃疡。慢性病例可见硬固的结节。维生素B族缺乏可见粘膜发红，干燥，唇及唇皱襞的皮肤形成龟裂和痂皮。舌和齿龈溃疡。唇皱襞皮肤炎，皮肤发红、肿胀，周围的被毛变色和脱落。慢性病例可见附着黄色或褐色的恶臭的渗出物。

治疗 除去病因，患部消炎。首先在患部剪毛，用消毒药液清洗干净。用2%硼酸溶液、0.1%高锰酸钾溶液、0.2—0.5%单宁酸溶液洗净患部。涂擦碘甘油或抗生素软膏以及肤氢松软膏，每日2—3次。

顽固性病例可用外科手术切除病灶部，或用冷冻方法以及5—10%硝酸银溶液除去不良的肉芽组织。

咽 头 炎

咽部粘膜及粘膜下层的炎症。咽头是由鼻部、口腔和喉头部所组成，是消化器官和呼吸器官的一个部分，进行呼吸和咽下运动。

病因 以口腔、鼻腔和扁桃腺等邻近器官炎症的波及为最多。其次是并发于犬瘟热、传染性肝炎以及钩端螺旋体病

等全身性传染病。某些细菌（链球菌、葡萄球菌等）的感染、异物的损伤、热及化学物质的刺激也可发生。

症状 食欲不振，体温升高，流涎，咳嗽，口吐粘稠性泡沫样物，咽下时疼痛，张嘴伸颈时疼痛。时间长时出现呼吸困难，下颌淋巴结肿胀。

治疗 忌给刺激性食物、硬固食物，给以易消化的流食。用盐水、2—3%硼酸溶液或苏打水冲洗口腔。涂布碘甘油于口粘膜上。投给强的松龙1—2毫克/公斤体重，每日分两次投服。全身给以抗生素药物或磺胺类药物治疗。

食道梗塞

食道被食块或异物阻塞不通的疾病。

病因 多数由食块或混入食物中的异物突然停滞于食道内引起，例如兽骨、鸡骨以及大的鱼骨等。其次则由于小石、球以及玩具等，在戏耍时误咽所造成。有时由于胃中的异物借呕吐之机逆转入食道而阻塞。

症状 完全阻塞发病急，病犬不安，流涎，食欲废绝，头颈部敏感，采食后立即吐出，逐渐脱水。不完全阻塞时流食和饮水可以通过，固形食物则吐出，咳嗽。锐利的异物长时间阻塞，引起食道壁坏死以至穿孔。

治疗 治疗方法由于异物位置、形状以及食道损伤程度而有所不同。如在颈部食道阻塞，尽量从口腔中取出。首先确定其位置，然后注入一定量的油剂于食道中，采取往口腔推送的方法。或者注入油剂后，用硬胶管从口腔送入食道，将异物推入胃中。如在颈后部或胸腔内，一般均采用食道切开术，取出异物，切开部进行双层缝合，闭合食道。

流 涎 症

唾液腺分泌过剩称为流涎症。相反，由于咽下障碍引起的流涎称为假性流涎症。

病因 因刺激性药物而流涎，如铋、水银、吗啡、乙醚、作用于副交感神经和交感神经药等，均可引起流涎。口炎、唾液腺感染症、痉挛、恐怖等也可造成流涎。假性流涎症，因头盖骨骨折、下颌骨骨折、牙齿脱落、口、咽、食道异物、口、舌、咽麻痹等引起。

症状 分泌过剩和咽下障碍其主要症状是涎流。流涎症和假性流涎症的区别，只能从病原的症状来确认，仅从流涎的状态很难加以鉴别。

治疗 可查明病因的，进行病因疗法。制止流涎，用硫酸阿托平0.1—1.0毫克，皮下注射。

钩端螺旋体病

病因 主要病原体是犬疫螺旋体和黄疸出血螺旋体，前者发生较多。感染途径是直接摄取被污染的食物和饮水。除此之外，从皮肤和粘膜的外伤也可感染。潜伏期为4—12日。

症状 大部分感染犬取无症状的经过，成为传染源，从尿中排泄病原菌。

犬疫钩端螺旋体感染，以肾炎为主要特征。体温升高，精神沉郁，肌肉疼痛。病初结膜和口腔粘膜发红，以后病犬约15%可见黄疸。呕吐、血便，口腔粘膜出现溃疡，开口时，口内发出臭味。后期有脱水症状，尿量减少或无尿。

黄疸出血性钩端螺旋体感染，一般症状比犬疫钩端螺旋

体感染严重。病初体温升高，食欲废绝，呕吐，振颤，衰弱。结膜和口腔粘膜充血或出血。血便。病犬约70%可见黄疸症状。也有的犬发病后数小时至2—3日死亡。

血液学所见：白细胞总数增加，各种程度的血小板减少症和贫血。

临床生化学所见：BUN和肌酸酐增加。碱性磷酸酶和SGPT增加。总胆红素量增加。

尿检查：蛋白尿，胆红素和尿胆素尿；多数出现尿圆柱，有时可见菌体。

治疗 投给抗生素药剂，青霉素2万单位/公斤体重，每日2次，连用5日，有效。或用四环素7毫克/公斤体重，肌肉注射。同时给予大量维生素B和C。对出血的病犬可每日给予大量维生素K。

支持疗法：纠正脱水和电解质不平衡，一般采用输液疗法。投给利尿剂，利尿磺胺2—4毫克/公斤体重，每8—12小时静注或经口投给，总量不能超过40—50毫克。

预防 疫苗接种，仔犬在9周龄以上时进行第一次接种，2—3周后进行第二次接种。如果可能在2—3周后进行第三次接种。其后一年一次。

病犬及时隔离治疗。对污染和可疑污染的犬舍、用具和水源等进行彻底消毒。

对治愈犬注意检查，因其数月至数年，尿中继续排菌，防止人畜感染。

（二）下痢和伴有血便、粘液便、脂肪便的疾病

新生仔犬疱疹病毒感染症

新生仔犬疱疹病毒感染症是全身性出血和灶性坏死为特征的急性、致死性疾病。1965年美国 Carmichael 首次报告本病发生。现已广泛存在于世界各地。

病因 本病是疱疹病毒的感染而引起，从出生后至2—3周龄的新生仔犬易感。新生仔犬的感染径路尚不十分清楚。实验证明，产道、胎盘以及接触可以引起本病的感染。

症状 本病的潜伏期为1周左右。从发病到死亡，大多数为4—7日。也有的不出现症状1—2日内突然死亡。

病初排出黄绿色至绿色的下痢便，无臭乃至恶臭。食欲不振，呕吐，流涎。末期变成水样下痢便。食欲废绝，短期内死亡。也可见排出浆液性鼻汁、呼吸困难和肺炎症状等。

病犬末期出现神经症状，运动失调，四肢紧张呈弓状或呈游泳样运动等。不见体温升高。

治疗 无特殊的治疗方法。用感染仔犬的免疫血清2毫升，皮下或腹腔内注射，对发病犬可免于死亡。并采用补液和消炎对症治疗。

犬的蛔虫症

寄生于犬的蛔虫有犬蛔虫和犬小蛔虫两种。这些蛔虫的成虫在小肠内寄生。犬蛔虫幼虫在发育期间在肝脏、肺脏或其它脏器中移行，造成这些器官障碍。

表 4 下痢和伴有血便、粘液便、脂肪便的疾病

疾 病	主 要 症 状
新生仔犬痘疹病毒感染症	食欲不振或废绝，呼吸促迫，呼吸困难，腹部压痛，持续性鸣叫，急死，出现神经症状
犬蛔虫症	食欲减退，呕吐，腹部膨满，瘦，出现神经症状，肺炎。幼犬易发
轮状病毒感染症	粘血便，脱水，循环障碍，后期体温下降。冬季常发，幼犬易发
冠状病毒性肠炎	精神沉郁，食欲废绝，呕吐，血便，急死。群发，脱水，无热
砷中毒	呕吐，腹痛，咽下困难，下痢，急死
吸收不良综合症	多便，脂肪便，食欲不定或增加，下痢，消瘦，低蛋白血症
犬钩虫症	粘液性血便，贫血，消瘦，步样蹒跚，虚脱，嗜酸性白细胞增加
犬旋毛虫症	粘液性血便，精神不振，呕吐，食欲不定，营养障碍，消瘦，嗜酸性白细胞增加
犬细小病毒感染症	下痢，西红柿样血便，呕吐，脱水，心肌炎。群发，急死
犬绦虫病	食欲异常增加，消瘦，腹痛，软便，摩擦臀部出现神经症状，可见绦虫体节
胃肠炎	呕吐，下痢，腹部压痛，腹痛，血便，脱水，食欲减少
犬瘟热	发热，呼吸困难，结膜炎，发咳，鼻汁，下痢，癫痫，硬蹄症，皮肤发疹
弓形体病	发热，发咳，视力障碍，运动障碍，神经症状
磷中毒	下痢，腹痛，出血，黄疸，休克

病因 犬蛔虫的成虫为淡黄白色。雄虫长4—10厘米，雌虫长5—18厘米。虫卵随粪便排出体外，在适当条件下发育成侵袭性幼虫。侵袭性幼虫随食物、饮水被犬吞食后，在肠内孵出幼虫，幼虫进入肠壁血管，随血液移行至肺，经支气管、气管至咽，又被咽下至小肠，在小肠内发育为成虫。妊娠母犬可经胎盘感染胎犬，出生后在小肠内已有蛔虫体存在。

症状 幼犬在重度感染时，可出现临床症状。食欲不振，呕吐，出现腹痛症状，腹部膨满。瘦弱，发育迟缓，下

痢。多数寄生时，虫体集成团块，常引起肠闭塞、肠叠套和肠穿孔而急性死亡。也可出现兴奋、痉挛、麻痹、游泳运动、意识消失和癫痫发作等神经症状。少数寄生时则不出现症状。

治疗 抗虫灵（噻嘧啶）制剂10毫升／公斤体重，经口投给，每日一次。或用盐酸左旋咪唑，10毫克／公斤体重，一次口服，7日后服一次。或用驱虫净片10毫克／公斤体重，一次口服。

每年春秋两季进行定期驱虫。驱虫药同上。

轮状病毒感染症

轮状病毒已从人、猿、牛、马、猪、家兔、老鼠、鸟、猫和犬的粪便中检出，已知该病毒是动物幼龄期急性下痢症的原因。

病因 由于感染轮状病毒而发病。病毒在全部肠管粘膜细胞内增殖。下痢的发生机制，是伴有分泌腺窝细胞的移动增殖，小肠绒毛萎缩。绒毛中未成熟的分泌细胞比正常细胞多，水和钠分泌增加，引起水样下痢便。

症状 冬季发病多，生后1周龄以下的仔犬突然发病，排出带有粘液和血样的下痢便。造成急性死亡。末期，由于显著的脱水，引起循环障碍，心跳增加，皮温和体温下降。

治疗 输液疗法为首选方法，输给林格儿氏液和5%葡萄糖溶液等量混合液。输入量根据脱水程度来计算。其次是防止细菌的二次感染，给以抗生素药剂或磺胺类药物。母犬接种疫苗时，由于初乳中含有抗体，可以防止仔犬发病。

冠状病毒性肠炎

1978年以北美为中心流行一种以剧烈下痢和呕吐为主要症状的胃肠炎，其病原是冠状病毒。冠状病毒1970年在犬的下痢便中发现，当时一般认为病原性弱。1978年在美国发生时，突然发生了强的病原性。现在已在世界广泛蔓延。近年来，英、德、美、比利时、澳大利亚、日本等国均有报道。在我国东北、华北、西北等地也有发生。

病因 由于冠状病毒感染而发生本病。

症状 突然发病，精神沉郁，食欲废绝，排出粥状或水样下痢便，呕吐。下痢便呈橙色，有强恶臭味，有时混有血液和脱落的粘膜，这时则成为血样下痢便。剧烈的下痢造成高度脱水状态。本病与细小病毒感染症不同的是白细胞不减少。多数情况无热。一般7—10日可恢复。本病的传染力非常强，集中饲养的犬舍，短时间内所有犬均发病。

治疗 除对症疗法以外，无特效疗法。

对脱水症状的病犬，大量输液是必要的，用复方生理盐水、5%葡萄糖溶液、人造血浆等药液。为了防止二次感染用抗生素药物，氨苄青霉素10—20毫克/公斤体重，经口投服，每日3次。也可用四环素、庆大霉素、链霉素等。同时给以大量维生素B、C。

砷中毒

病因 使用砷制剂作为杀鼠、杀虫、抗真菌、除草剂等，由于误食而发病。使用砷制剂驱除犬丝状虫、住白吸虫等，用药过量而发生中毒。犬一次中毒剂量亚砷酸（三氧化二砷）为100—150毫克，亚砷酸钠为50—100毫克。

症状 急性中毒突发剧烈的胃肠炎症状，病犬表现呕吐，剧烈腹痛，呕吐物呈大蒜臭味。流涎、不安，呻吟。咽下困难，下痢，脱水，衰弱，贫血。结膜发紫，脉搏微弱。四肢疼痛，痉挛，昏睡。毒物食入后1—3小时发病，12—18小时死亡。

慢性砷中毒，食欲不振，消化不良，眼结膜呈红砖色，眼睑浮肿，精神不振。除此之外，伴有骨髓障碍，出现嗜碱性斑点红细胞、嗜酸性白细胞增多，嗜中性白细胞减少。

治疗 中毒早期用1—2%碳酸氢钠溶液100—200毫升或生理盐水洗胃。硫酸镁1克/公斤体重，内服。催吐剂用0.1%盐酸阿扑吗啡液1毫升/公斤体重，皮下注射。

二巯基丙醇是砷中毒的特效解毒剂。用10%二巯基丙醇4毫克/公斤体重，肌肉注射。最初二日，每日6次，以后每日4次。

对症治疗：疼痛时，用盐酸哌替定10毫克/公斤体重，皮下注射。对顽固性下痢给以输液。输以电解质液、葡萄糖液、复合维生素、氨基酸溶液等。并投给粘膜保护剂，如氢氧化铝凝胶。

吸收不良综合症

吸收不良综合症是由于小肠粘膜代谢不全而引起各种营养素的吸收障碍，致使营养状态异常低下的病态的总称。本综合症包括消化不良和吸收不良多种疾病。

病因 原发性吸收不良由小肠粘膜自身障碍而引起。小肠粘膜绒毛萎缩、融合和消化，粘膜面变为平坦而不能吸收。

继发性吸收不良：由于各种各样的消化器官疾病或全身

性疾病继发，引起二次吸收不全。增殖性浸润性疾病，如肠炎、钩端螺旋体病、球虫症等。先天性异常，如乳酸酶缺乏症。肠壁淋巴管扩张症可引起脂肪吸收障碍。

消化障碍性吸收不良：胰脏、肝脏、胆道疾患，造成消化液（胆汁、胰液）分泌和排泄障碍，引起脂肪消化障碍。

症状 原发性吸收不良一般取慢性经过。食欲良好，但体重减轻，明显消瘦。多数有呕吐，顽固的消化不良，排出大量软便乃至下痢便，伴有酸败性恶臭。排出脂肪便或灰白状软便乃至下痢便为其特征。病犬有脱水、贫血、低蛋白血症、低钙症和低血糖症。

继发性吸收不良：精神沉郁，大量脂肪便，腹部膨满，消瘦，贫血。

消化障碍性吸收不良：体重减轻，消瘦，食欲增加，下痢和轻度乃至重度脂肪便为特征。大便次数增加，每日数次。

治疗 改变食物，停止给予含有谷蛋白的食饵，变为高蛋白、高热量和低脂肪食饵。

清理胃肠，保护胃肠粘膜。用硫酸镁1克／公斤体重，经口投给。或用植物油10毫升，口服。然后投给氢氧化铝凝胶10—15毫升，口服。

给予维生素制剂。维生素B₁₂ 3微毫克／公斤体重，一日量；叶酸0.5毫克／公斤体重，一日量；铁剂0.5—1片，一日量，经口投给。

补给营养剂。显著食欲减退和脱水者，进行输液疗法。

犬钩虫症

犬的钩虫症是由于钩虫寄生于犬小肠内而引起的疾病。

是犬常见的线虫病之一。临床上主要是贫血、消化器官障碍和营养障碍为特征。幼犬最易受害。广泛地分布于世界各地，尤其是热带和亚热带地区，我国温暖地区也广泛流行，如华东、中南、西北等地。

病因 主要为犬钩虫，其次有窄头钩口线虫、美洲钩虫、巴西钩虫、十二指肠钩虫等为病原。钩虫寄生于小肠，以十二指肠多见。据日本材料记载，捕获的野犬有80%以上有钩虫寄生，有20%以下出现症状。钩虫虫体呈灰色或红色，坚硬。在虫体前端背面开口和口缘的腹侧面各有锐利钩状齿三个。犬钩虫成虫，雄虫10—12毫米，雌虫9—20毫米。

生活史和感染经路：虫卵随粪便排出体外，在适宜温度下，一周内发育成侵袭性幼虫。钩虫多经皮肤侵入静脉，经心脏而达肺，经呼吸道、喉头、咽部、食道经胃进入小肠而定居。也可经口感染。新生仔犬可经母乳而感染。经胎盘也可感染。

症状 主要症状贫血，腹疼，排出多量恶臭的粘液血便。幼犬表现明显，成年犬，营养状况良好，虽有少数虫体，不一定出现症状。严重感染者，消瘦，食欲不振，下痢，排出暗黑色粘液血便。慢性者，幼犬发育受阻，营养不良，消化障碍，消瘦，被毛粗刚，衰竭。有时皮肤发痒，又称钩虫痒症。窄头钩虫感染所致的皮炎多发生于指（趾）间隙。

诊断 根据临床症状可初步诊断。从粪便中查出虫卵即可确诊。

治疗 同蛔虫病。

犬旋毛虫病

犬旋毛虫病是由旋毛虫亚目毛形科的旋毛虫所引起的。成虫寄生于肠道，幼虫则寄生于横纹肌内。本病分布于世界各地，在我国也广泛存在，黑龙江、甘肃、辽宁、云南、四川等地均有报道。本病除犬感染外，也见于人、猪、狼、猫、狐等感染，是人畜共患的一种寄生虫病。特别是在室内饲养的玩赏犬和护卫犬，在公共卫生上极为重要，要特别注意，防止感染人。

病因 旋毛虫的成虫是细小线虫，虫体前半部为食道，后半部较粗。雄虫体长1.4—1.6毫米，雌虫体长为3—4毫米。幼虫是胎生的。

犬主要是吃了带旋毛虫包裹幼虫的猪肉或老鼠而感染。包裹在胃内被溶解，幼虫从包裹逸出，到小肠内迅速生长，经48小时性成熟，则成为肠旋毛虫。雌雄虫交配后，雌虫在第三天产出大量幼虫，幼虫经淋巴和血液被带到各横纹肌内生长，膈肌、舌肌、咬肌、肋间肌内较多。以后卷曲成螺旋状而进入停止状态。该肉被另一动物吞食而感染。

症状 轻度感染无明显症状。严重感染时，病犬发生肠炎，排出带血的下痢便。有时呕吐，精神不振，食欲时好时坏。时间长则消瘦，营养障碍，有的行走困难，吞咽困难，肌肉疼痛。嗜酸性白细胞增多。

诊断 生前取舌肌一小片，做压片镜检。死后取膈肌做同样检查，发现幼虫即可确诊。

治疗 试用硫苯咪唑，50毫克/公斤体重，内服，对旋毛虫未成熟虫体有效率为99.2%，但对成虫无效。上述用药量连用7日，对移行期幼虫有效率为88.7%，对包裹期幼虫

无效。

预防 做好肉类检疫，不喂生肉或动物尸体。不准犬吃老鼠和粪便。做好防鼠灭鼠工作。检出的旋毛虫的肉类要焚烧处理，不准上市。

犬细小病毒感染症

本病是由犬细小病毒引起的一种病毒性传染病。主要以出血性肠炎和急性心肌炎为特征。1978年首次在美国发现，相继在亚洲、澳大利亚、日本、欧洲、加拿大、中美等地发生。80年代，在我国各地也相继发生，据西安市报告，共诊治9千多例，初期呈散发，以后呈地方性流行，甚至有些地区呈大流行。本病主要侵害幼犬，不同季节和性别均可发病。一般每年4—10月份发病较多。

病因 本病病因为细小病毒，是无囊膜等轴对称的DNA病毒。病毒存在于病犬的粪便、尿液、呕吐物和唾液中，污染食物、食具、用具以及周围环境而感染犬。福尔马林、氧化物、 β -丙内脂和紫外线对病毒有灭活作用。

症状 分为肠炎型和心肌炎型

肠炎型：又分为急性型和慢性型。急性型，突然重度下痢，食欲废绝，急速脱水，体温升高。先呕吐，后腹泻，排出从泥状至水样便，从黄灰白色便至血样下痢便，有恶臭味。脱水严重时，特别是仔犬1—2日，陷于休克而死亡。慢性型是从急性转变而来的，各种症状程度较轻，可见长时期下痢。

心肌炎型：发生在3—9周龄的仔犬，呈心功能不全而死亡。有的外观上看健康，突然虚脱，呼吸困难，30分钟之内死亡。剖检主要为肺水肿，左心室纤维性水肿、变性、坏

死。

治疗 本病无特效疗法。应早期发现，及早采取对症疗法。对肠炎型主要是防止脱水，大量补液，主要补林格氏液或乳酸林格氏液。同时给以抗生素药剂，防止继发感染，氨苄青霉素20—30毫克/公斤体重·日，每日2—3次，肌肉注射。或用链霉素50—100万单位，庆大霉素4—24万单位，卡那霉素50—150万单位，柱晶白霉素20—50万单位，肌肉注射，每日2次。止吐以盐酸氯丙嗪12.5—50毫克，每日2次，效果较为理想。一般不用止泻，在恢复期开始进食后，仍拉稀排水样稀便，可适当止泻，用硫酸阿托品1—2毫克，肌肉注射，或用复方樟脑酊4—6毫升，加水适量，内服，或用阿片酊0.5—2毫升，加水适量，内服。止血用维生素K₁10—40毫克，肌肉注射；止血敏250—750毫克，肌肉注射；或用安络血10—20毫克，肌肉注射。每日1—2次。激素类药物视病情而用，一般用地塞米松5—50毫克或氢化可的松25—500毫克，静脉注射。抗病毒药，用中药抗病毒针剂2—6毫升，肌肉注射；或用盐酸吗啉双胍针剂500—1500毫克，肌肉注射。补充维生素类药物，维生素C、B₁₂、复合维生素B等。

预防 常用的疫苗有犬细小病毒灭活苗和弱毒苗，猫瘟病毒弱毒苗。犬细小病毒活弱毒苗优于其它疫苗，接种后不仅免疫期长，而且对含有母源抗体值低的幼犬也有保护作用。幼犬初次免疫时间为6—8周龄，第二次免疫时间为10—12周龄，14—16周龄时再免疫一次。以后每年接种一次。

犬绦虫病

犬绦虫是寄生在犬和猫的小肠中最一般的绦虫，成虫节

片如瓜籽状，又名瓜实绦虫。可感染人和其它动物，尤其幼虫对人和家畜以及食品卫生危害较大。犬的感染率为10—75%。

病因 犬绦虫虫体全长50厘米以上，体节超过100个。头节有四个吸盘和1个顶突。白色的受精节片长为8—12毫米，宽2—3毫米，卵囊内具有8—15个虫卵。

孟氏裂头绦虫体长为80—100厘米，长的可达250厘米。节片数达1000个以上。生殖孔后方有产卵孔。虫卵呈椭圆形，两端尖。

豆状绦虫寄生于小肠内。成虫体长30—200厘米，宽4—7毫米。体节约为400个。节片后端比前端宽。肉眼观察成虫虫体节片侧缘呈锯齿状，又称锯齿绦虫。虫卵为褐色，呈球形或椭圆形。

绦虫的生活史比较复杂，均需要一个或两个中间宿主，才能完成其生活史。

绦虫大部分进行自体受精。受精的虫卵为圆形，经分裂发育成为六钩蚴。六钩蚴被中间宿主（牛、羊、猪、人等，豆状绦虫为兔及其它啮齿类），吞食后，立即钻入组织内，发育成囊状幼虫，当这种囊状幼虫被终末宿主吞食后，其囊壁被消化，头节逸出，就在肠道内形成成虫，而成虫多寄生在小肠内。囊状幼虫多寄生在中间宿主的脏器的实质内，危害性更大。

症状 轻度感染时，症状不明显。偶然从粪便中排出体节或附着在肛门周围。多数寄生时，食欲减退或亢进，排软便，下痢，呕吐。肛门发痒，与物体摩擦。营养不良，被毛无光泽。有的因犬绦虫排出神经毒，出现乏力、呕吐、痉挛，引起癫痫样发作。当虫体大量成团时，则形成堵塞，导

致肠梗阻、肠套叠和肠扭转等。

诊断 在粪便中发现绦虫节片即可确诊。

治疗 硫双二氯酚，100 毫克/公斤体重·次，连用 2—3 次，经口投服，对各种绦虫有效。有时可见呕吐、腹痛和不整脉的副作用。建议空腹投给。或用吡喹酮，2.5—5 毫克/公斤体重·日，口服，连用 2—3 日；或用氯硝柳胺（灭绦灵）100—150 毫克/公斤体重，空腹口服；或用二氯酚，200 毫克/公斤体重，空腹口服；或用盐酸丁萘脒，25—50 毫克/公斤体重，口服。

预防 对工作犬、猎犬等每季度驱虫一次。保持犬舍清洁卫生，消灭老鼠和蚤类等。病犬排出的粪便和虫体应深埋发酵，彻底销毁，以防人为地扩大感染。与犬经常接触的人员应定期检查，一旦发现感染，应立即治疗。为犬驱虫人员，应加以防护，严防感染。加强饲养管理，防止采食带有幼虫的中间宿主的肉或脏器。

（三）表现努责、腹痛和便秘的疾病

肛门囊炎

肛门囊是犬特有的肛门腺。位于肛门内外括约肌之间，从外侧观是在 5 时和 7 时的位置上，是两侧性球状囊。其大小因犬的大小而异，中型犬约 1 厘米左右。囊壁中有许多顶泌腺和皮脂腺，是肛门皮脂腺的开口。这个开口用力举尾时突出肛门，即可看见。

肛门囊内分泌物贮留、腐败，刺激粘膜而发生炎症称之为肛门囊炎。

病因 肛门囊内分泌物的性状变化：分泌物粘稠度增

高，分泌物中混有颗粒物将导管闭塞而发生，老龄犬易发。分泌过剩，特别是脂溢性体质的犬。室内小型犬运动不足，限制排便次数的犬易患本病。

症状 病犬频频摩擦肛门部，努责或舔其肛门部。患部疼痛，将尾根部上举可见肛门囊部隆起，触之疼痛而躲闪。持续闭塞易发生脓肿，继而自溃形成瘻管。局部疼痛剧烈，病犬骚动不安。

治疗 除去内容物。从外部挤出，高举尾根部，在突出肛门的侧下方，顺着导管开口部的方向，用手指挤出内容物。从内部压出，带上胶皮手套，涂抹润滑剂后将手指伸入肛门内，用手指挤出内容物。

局部涂擦药物：内容物除去后，用抗生素软膏、肤氢松软膏、磺胺软膏，从开口部挤入或注入。也可局部注射青霉

表 5 表现努责、腹痛和便秘的疾病

疾 病	主 要 症 状
肛门囊炎	摩擦臀部，肛门周围肿胀，肛门周围糜烂，排便时努责，排便时疼痛
便秘	排便停止，努责，触知硬结肠，食欲减退，粘液便，摩擦臀部，肛门部肿胀
疝	局限性肿胀，便秘，腹痛，呕吐，脱水。幼犬易发
锁肛	不能排便，努责，腹部膨满，呕吐，脱水，呼吸困难
腹膜炎	弓背姿势，腹部疼痛，腹部紧张，发热，腹水
胃扩张和捻转	腹部膨满，呕吐，流涎，急死，脾脏肿大。大型犬易发，突发疝痛
胃肠炎	下痢，腹部压痛，腹痛，脱水，食欲减少
急性胃炎	食欲减退，胃部压痛，腹痛，口腔恶臭，脱水
犬绦虫症	软便，消瘦，被毛无光泽，摩擦臀部，出现神经症状，可见米粒状虫体
砷中毒	胃肠炎症状，腹痛，下痢，咽下困难，急死
磷中毒	下痢，腹痛，黄疸，出血，休克

素或链霉素。

摘除瘻管：如已形成瘻管，进行手术摘除。

便秘

正常犬每日进行1—3次排便。由于肠内容物通过障碍，粪便主要停滞在结肠，一部停滞在直肠，这种异常状态称为便秘。长时间便秘，肠内容物水分减少而硬化，造成通过困难，由于肠内容物的蛋白异常发酵和分解产物的吸收，发生自家中毒，导致全身状态恶化。老龄犬多发。

病因 采食异常和环境改变：采食多量的骨片、干燥食物；误食异物（被毛、砂、草类、针及金属破片等）；饮水不足。饲养环境和生活习惯的突变皆可发生本病。

继发于其它疾病：直肠和肛门部的疾患，骨盆骨折、后肢骨折等也是发生的原因。

机械性通过障碍：结肠和直肠的外部压迫，如骨盆腔内肿瘤、前列腺肥大等；肠管内通过障碍，如结肠和直肠肿瘤、会阴疝等；部分犬种的肛门周围被毛长而且密，如贵妇犬，粪便与被毛粘在一起成块状，干燥，妨碍排便。这种状态称为伪性便秘。

支配神经异常：中枢神经性机能下降，招致后肢麻痹的脊髓疾患，迷走神经兴奋性减退，导致便秘。

症状 食欲不振或废绝，不安，有时伴发呕吐。排便停止，时间较久（1周），脉搏增数，可视粘膜呈发绀状。轻症时，可见努责，排出少量粪便；经1周左右，则反复努责，排出少量混有血液和粘膜的液状便，肛门发红，浮肿。腹部触诊或直肠内指检，可触及硬固的粪块。

治疗 灌肠：甘油水（甘油1份，水2份）、微温肥皂

水、5%重曹水等20—200毫升，注入直肠内。必要时每日2—3次。

破除结粪：从腹壁将结粪块压碎，后送。或从直肠触知，用手指或钳子将其破碎。直肠便秘，用大量温肥皂水（2—3升）灌肠，如有骨片必须用钳子取出。取出后，用5%磺胺剂混入油剂10—20毫升，注入直肠内。

泻剂，油类泻剂，如液体石蜡、植物油等，大型犬10—15毫升，经口投给。盐类泻剂可用硫酸镁、硫酸钠等10—20克，内服。

疝

疝又称赫尔尼亚，是内脏器官、组织或其一部分被膜（腹壁腹膜）由生理孔或病理孔脱出至皮下所引起的疾病，或者在体腔内肠系膜、横膈膜、大网膜等迷入其裂隙时所引起的疾病，总称之为“疝”。前者称为外疝，后者称为内疝。依其解剖部位又有许多种疝。从病的发生原因又可分为先天性疝和后天性疝，后天性疝亦称获得性疝。

病因 先天性疝多为腹肌弱，脐孔和鼠蹊环等发育不良，犬出生后由于腹压增加，内脏从这些环中脱出而形成疝。这样的体质也有遗传因素。

幼龄和老龄动物由于衰弱等，肌肉萎缩或无力，因为争斗、坠落、急剧运动等，易发生疝。

症状 疝由其内容物可以还纳、非还纳、嵌顿等，其症状有所不同。

还纳性疝：局限性肿胀，柔软，无痛，有弹性。加压时内容物容易还纳回去。时大时小，吃饱后增大。内容物为肠管时，多数有波动性，可听到肠蠕动音。慢性时伴有臃胀、

便秘和下痢等消化器官障碍。

非还纳性疝：由于疝轮与疝内容物愈着而失去还纳性，其症状除非还纳性外与还纳性同。

嵌顿性疝：其疝内容物除与疝轮愈着外，还绞窄嵌闭于疝轮，因此而产生循环障碍，发生腹痛、炎症、坏死等。如内容为肠管时，则出现食欲废绝、呕吐、脱水和电解质异常等肠闭塞症状。

疝的内容物：除肠管、大网膜外，还有子宫、膀胱等器官。

治疗 幼犬脐疝，疝门小时，生后6—12个月可自然治愈。这时要防止犬大声叫、咳嗽、下痢和排尿障碍。改善营养等措施是有效的

压迫法：在患部皮肤上涂擦刺激剂或皮下注射刺激剂，如95%酒精溶液等保守疗法，是使局部炎症加剧和肥厚。效果不十分确切。

手术疗法：是彻底根治的方法。在全身麻醉下进行。采用846注射液1毫升，肌肉注射，作全身麻醉。切开皮肤，注意不要破坏疝囊，将皮肤与疝囊进行钝性分离。

疝轮小的可还纳疝：还纳内容物，捻转剥开的疝囊，在其根部结扎，切除，缝合皮肤。

疝轮大，内容物愈着的疝：切开疝囊，剥离愈着部，还纳内容物后，闭合疝轮，缝合皮肤。

鼠蹊疝和阴囊疝：缝合疝轮之时，将睾丸摘出。

非还纳性疝：疝内容物还纳困难，切开疝轮一部分或全部，扩大疝轮，还纳内容物后，缝合疝轮。如有嵌顿、内容物坏死应切除，再行肠管吻合术。

锁 肛

锁肛是胚胎末期胎儿的总排出腔膜裂开不全或未裂开，膜状物闭锁肛门。其原因不明，有人认为是遗传因素所造成的。

症状 多数在出生后不能排便，腹部胀满，不安，呕吐等。频频努责，努责时肛门周围隆起。肛门闭锁，触诊内有粪便。

治疗 行人造肛门手术。局部麻醉或硬膜外麻醉。在肛门部皮肤进行圆形切开，将皮肤与粘膜分离，再切开粘膜，排出粪便，彻底冲洗、消毒后，将粘膜与皮肤缝合在一起。

腹 膜 炎

腹膜炎系指腹膜的炎症性疾病。根据其经过分为急性腹膜炎和慢性腹膜炎；根据其炎症的范围和程度分为局限性腹膜炎和弥漫性腹膜炎。

病因 急性腹膜炎，多由于消化道穿孔（异物、重叠、破裂、肠闭塞等），内容物漏出腹腔内，刺激腹膜和感染，膀胱穿刺操作失宜，使尿液漏入腹腔内，生殖器官穿孔、手术后感染皆可引起。

慢性腹膜炎，腹腔内器官的炎症蔓延，由急性腹膜炎转为慢性的腹膜炎；胆管、胆囊穿孔、破裂。在犬多数取慢性经过。

症状 急性腹膜炎，一般初发症状为剧烈疼痛，弓背，食欲不振，精神沉郁，不爱活动，继而出现呕吐，体温上升。局部的炎症中心部发热，触之躲闪、疼痛、腹部紧张，不敢卧地。有大量渗出液时，腹部下垂，叩诊呈水平浊音。

慢性腹膜炎，病情发展缓慢，症状轻微。消化不良，病犬消瘦，腹部紧缩。如有肠管愈着粘连，则影响肠管运动，发作时疼痛。腹腔穿刺，流出多量混浊液体。

治疗 制菌消炎，制止渗出，防止败血症。

制菌消炎：投给 抗生素药物，全身或腹腔内注射青霉素、链霉素、磺胺等。

制止渗出：5 % 葡萄糖氯化钙注射液10—20毫升，静脉注射，每日 1 次。

根据病情，进行强心、补液、缓泻等对症治疗。

（四）腹部膨大的疾病

腹 水

腹水系指腹腔内的液体非生理性贮留。贮留的液体分为伴有炎症的渗出液和非炎症性的漏出液。

病因 渗出液的贮留：主要的是伴有腹膜炎，腹膜通透性异常亢进而发生，如腹膜炎、腹膜瘤等。

漏出液的贮留：低蛋白血症引起胶质渗透压下降，如肾病变综合症、低营养和蛋白漏出性胃肠炎等。

肝实质障碍（肝硬变）：由于肝血流障碍引起门脉压亢进，肝淋巴液的漏出，醛固酮的增加，水和钠的贮留而引起腹水。

心功能不全造成的腹水：大动脉管残留的末期肺动脉压上升而引起腹水。

症状 腹围膨隆是本病的特征性症状。腹壁紧张，腹部触诊有波动感，对侧腹壁有液体的反拨感。呼吸困难，呼吸增数，食欲减退，呕吐，结膜发绀，脉搏异常增加，一般体

温正常。

治疗 病因疗法：腹水可见于多种疾病，应治疗原发病，如对化脓性腹膜炎的抗生素药剂治疗。

对症治疗：使用利尿剂，利尿磺胺 2—5 毫克 / 公斤体重，1 日量，分两次经口投服。利尿素 0.1—0.2 克，每日 3 次。用双氢克尿塞 10—25 毫克，每日 2—3 次。经口投服。

除去腹水：穿刺排液，最大量为 40 毫升 / 公斤体重以内。

保肝剂：葡萄糖制剂、右旋糖酐等注射液，静脉滴注。维生素 B₁ 10 毫克经口投给。或用 10% 葡萄糖溶液和 40% 氨基酸溶液，静脉滴注。

改善饲养管理，给予高蛋白、低钠的食物，限制饮水，给 1/2 量。同时给以肾上腺皮质激素。

表 6 腹部膨大的疾病

疾 病	主 要 症 状
腹 水 胃扩张和捻转	腹部波动感，腹壁紧张，呼吸困难，消瘦，乏力 腹部膨满，呕吐，流涎，急死，脾脏肿大。大型犬易发，突发病痛
犬丝虫症	咳嗽，贫血，腹水，浮肿，呼吸困难，黄疸，皮肤炎，易疲劳，收缩期心杂音
蛔虫症	食欲减退，呕吐，腹部膨满，消瘦，肺炎，出现神经症状。幼犬易发
腹膜炎	弓背姿势，腹痛，腹部紧张，发热，腹水，呕吐
巨大结肠症	腹腔内硬固物，努责，粘血便，呕吐，脱水，便秘，衰弱，生后 2—3 周龄幼犬易发
锁 肛	不能排便，努责，腹部膨满，呕吐，脱水，呼吸困难
膀胱破裂	无尿，强直步样，血尿，尿毒症，休克
肠闭塞	腹围膨满，腹痛，粘液便，肠蠕动音减弱或废绝

胃扩张和捻转

胃扩张分为单纯性胃扩张和伴有捻转的胃扩张。前者突然发生，出现疝痛症状的同时腹部显著膨大，后者出现休克，以急性死亡为特征。

病因 单纯性胃扩张：仔犬过食，采食大量适口性好、难于消化的干燥食物，摄取大量水，加之剧烈运动；或因喂饲大量玉米片、麦片之后，又大量饮水所引起。或由各种原因（分娩、呕吐、全身麻醉等），使胃的运动和分泌机能受抑制而引起。

伴有捻转的胃扩张：多见于大型犬，如大丹犬、大型贵妇犬、拳师犬、英国牧羊犬、圣伯纳犬等有多发的倾向。

胃捻转原因很多，如胃韧带的牵张，钙、磷平衡失调，胃下垂，胃膨满，食后过度运动，遗传因素和虚弱等。多数病例是在给水和饲料后进行强烈运动，或在发病2—6小时前采食大量饲料。

症状 单纯性胃扩张：以腹部膨满和疝痛为主要症状，比胃捻转症状轻。

病犬突发腹痛，表情淡漠。大量流涎，干呕，可视粘膜不洁，脉细而快。腹部膨大，腹壁紧张，触之疼痛，硬，叩打呈鼓音。有时伏卧于地、滚转等。

伴有捻转的胃扩张：从胃的附着部捻转 90° — 360° ，食道和幽门闭塞，胃显著膨满。可见剧烈疝痛，脾肿大。一般在食后3小时内发病。干呕，喜卧。有粘膜苍白，脉频，脉弱，血压下降等的休克症状，如治疗不及时，24小时以内死亡。

治疗 单纯性胃扩张：麻醉下将胃导管插入胃内，排除

胃内气体或食物，然后用温盐水反复洗胃，排出胃内容物。

轻度单纯性胃扩张给予催吐剂治疗：0.1%盐酸阿扑吗啡液 1 毫升/公斤体重，皮下注射。或注射碳酰胆碱0.001克/25公斤体重。

若胃导管不能插入时，应立即进行开腹手术以排除胃内容物。急性病例应避免全身麻醉，进行局部浸润麻醉或腰旁传导麻醉。

对于休克病例，给予地塞米松 2 毫克/公斤体重，静脉注射，或给予低分子葡聚糖和乳酸钠等。

对于已耐过的犬，应空腹24小时，以后给予流食。

犬丝虫症

犬丝虫以蚊作为中间宿主，最终宿主寄生在犬的右心室和肺动脉内，也造成呼吸器系统、循环系统和泌尿系统的多种障碍。本病在世界范围内广泛存在，凡是蚊子生息的地方就可见本病。

病因 犬丝状虫为其病原。雄虫为12—18厘米，雌虫为25—30厘米。最终寄生在犬的右心室和肺动脉内。

成虫在犬的血液中产生微丝蚴，在血液中生活 2—2.5 年，当蚊子吸血时吸入蚊体内，发育成感染幼虫，然后移行至蚊的口器中，在蚊子叮咬犬时，从口器中逸出进入犬体内。在犬的皮下组织和肌间生长发育，3—4 个月后移行至肺和心脏。进而未成熟的虫变为成虫。

症状 感染初期临床症状不明显，但是过劳时有轻度湿咳，逐渐地活动耐力降低，食欲和体重减少。严重病例，食欲不振，日渐消瘦，被毛粗刚。易于出现瘙痒症和脱毛等皮肤病。贫血，呼吸困难，结膜发绀，出现腹水、四肢浮肿、胸

水、肺水肿等。

诊断 根据临床症状可怀疑为本病。在血液中查出微丝蚴即可确诊。

治疗 对本病有化学疗法和手术疗法两种。

化学疗法：砷制剂对成虫有效，0.75毫克/公斤体重，静脉注射，2—3次。或用噻唑青胺5毫克/公斤体重，经口投服，连用1—2周。或用乙胺嗪（海群生）55毫克/公斤体重，内服，或配成30%溶液，一次肌肉注射，连用3—5周。

若体内有大量虫体存在，可进行手术疗法。

预防 可在蚊子活动之前，每日口服乙胺嗪，直至无蚊子后1个月，可防止幼虫活动。

（五）呕吐和腹部压痛的疾病

急性胃炎

本病主要是摄取有刺激性药物引起胃粘膜的急性炎症。其主要特征是呕吐、胃压痛和脱水。是临床上频发的疾病。

病因 饲养管理不当：摄取大量的不易消化、变质腐败的食物，摄取不洁的饮水等为主要原因。另外，给以过冷或过热的食物、快速采食、给食时间不一、仔犬过食、感冒等均可诱发本病。误食有毒物质：如磷、砷等化学药品、驱虫剂、杀鼠剂等。变态反应：给以鸡蛋、牛奶、鱼肉和马肉等，成为变态反应原而引起胃炎。继发某些传染病：如犬瘟热、传染性肝炎、细菌性肾炎、食物中毒等。

症状 病犬大部分都出现呕吐。病初吐出食糜、泡沫性粘液和胃液，呕吐物中混有血液、胆汁、粘液片等。食欲异

常是必发的症状，食欲不定、食欲不振乃至废绝。渴欲初期减少，但呕吐后则亢进。胃部触诊有压痛、腹壁显著紧张。由于摄取腐败食物而发生的，在剧烈呕吐的同时，出现腹疼症状。进而则发生神经症状和尿毒症。

精神沉郁、不爱活动、时有大便秘结，继发肠炎则下痢。常常可见带黄白色的舌苔和口腔有恶臭味。

表 7 呕吐和腹部压痛的疾病

疾 病	主 要 症 状
急性胃炎	食欲减退，胃部压痛，腹痛，口腔恶臭，脱水
胃肠炎	下痢，腹部压痛，腹痛，脱水，食欲减退和废绝
肠闭塞	腹部膨满，腹痛，粘液便，肠蠕动减少或废绝
胃内异物	食欲不定，渴欲增加，胃部压痛，消瘦
幽门狭窄	采食后24小时内发病，喷射状呕吐，持续性发育迟缓，脱水
胃肿瘤	吐血，胃部压痛，腹痛，血便，贫血
犬瘟热	肺炎，胃肠炎，神经症状，结膜炎，皮肤发疹
冠状病毒性肠炎	精神减退，食欲减退，下痢便，血便，脱水，急死
细小病毒感染症	下痢，血便，脱水，心肌炎，急死
新生犬疱疹病毒感染症	食欲不振或废绝，腹部压痛，呼吸促迫，呼吸困难，急死，持续性鸣叫，出现神经症状
犬传染性肝炎	虚脱，急死，呕吐，腹部压痛，发热，粘膜出血，角膜混浊与溃疡，淋巴结肿大，白细胞减少
钩端螺旋体病	精神沉郁，食欲减退，口腔粘膜炎症，口臭，血便，黄疸，发热，胃部压痛，舌炎
磷中毒	下痢，腹痛，出血，黄疸，休克
腹膜炎	腹部疼痛，弓背，腹肌紧张，发热，脱水
蛔虫症	食欲减退，下痢，腹部膨满，出现神经症状
砷中毒	胃肠炎，腹痛，下痢，咽下困难，急死
眩晕病	流涎，恶心，不安，呕吐
食道梗塞	流涎，不安，咽下困难，恶心

治疗 食饵疗法：轻症时，改变食饵即可治愈。一般要

绝食12—24小时，多饮水。严重病例，应静脉滴注生理盐水和5%葡萄糖溶液。给以易消化的稀食，减少牛奶、肉类食物，应少量多次喂食。排出有毒物质：硫酸铜0.1—0.5克，制成1%水溶液，内服；或用盐酸阿扑吗啡2—10毫克，皮下注射。投以泻剂：豆油15—50毫升，内服；或用鸡蛋白或生鸡蛋1—5个，顿服。止吐剂：呕吐频繁者，给以止吐剂，氯普马嗪1—6毫克/公斤体重，内服，每日1—4次。亦可用灭吐灵0.3毫克/公斤体重，内服；呕泻宁注射液，0.5毫升/公斤体重，肌肉注射。为了增进食欲，给以健胃剂，苦味酊1—2毫升、稀盐酸0.2—1.0毫升、龙胆酊1—2毫升、人工盐0.5—1.5克，内服，每日1—3次。给以维生素B₁和C。

胃 肠 炎

胃和肠粘膜及其深层组织的急性炎症。由于各种原因引起胃肠粘膜出血、化脓、格鲁布性和伪膜性炎以及坏死的疫病。

病因 单纯性胃肠炎和食饵性胃肠炎：由于饲料失宜，胃肠内异物。感冒，过劳以及肠内细菌毒力作用而发生。中毒性胃肠炎：采食腐败变质的肉类、内脏器官等；摄取含有化学药品、杀鼠剂和其它毒物的食饵而引起。传染性胃肠炎：由于细菌、病毒等感染而发生。寄生虫性胃肠炎：由于寄生虫寄生于消化道内而引起。还有犬嗜酸性白细胞性肠炎和溃疡性结肠炎等。

症状 胃炎的症状：食欲废绝，频频呕吐，呕吐物中一般混有血液。口腔粘膜发红、干燥，渴欲增加，饮水过多则呕吐。腹部紧张，胃部压痛明显，出现疝痛症状。体温

稍升高，但传染性的则发高烧。由剧烈呕吐而出现脱水症状。

肠炎的症状：腹部紧张，触诊可见高度的压痛、知觉过敏。可见剧烈的持续性疝痛。病初肠蠕动亢进，里急后重，下痢，排有血液和粘液便。末期排有恶臭的下痢便，往往失禁。体温升高至40—41℃。脉数增加，结膜呈不洁的暗红色。以上症状进一步恶化，出现明显的脱水症状，四肢冷厥，疝痛减轻，呈昏睡状，发生搐搦而死亡。

中毒性和传染性胃肠炎：除上述胃肠炎症状外，常常并发肾炎，尿中混有蛋白、肾上皮细胞和血液。出现神经症状，有时兴奋，有时沉郁，有时痉挛，有时麻痹。

犬嗜酸性白细胞性肠炎：可见持续性出血性下痢。血液中嗜酸性白细胞增加为特征性所见。

犬溃疡性结肠炎：排出混有血液和粘液的恶臭下痢便，持续的顽固下痢。

治疗 单纯性胃肠炎：食饵疗法，注意饲养管理，初期应绝食，充分给水；绝食后给以易消化的流食；注意腹部保温。药物疗法，排除胃肠道内的内容物，投给吐剂、泻剂，进行灌肠等；长期持续性下痢时，使用止泻剂，鞣酸蛋白0.5—1.0克，或次硝酸铋0.2—0.6克，每日2—3次，内服，同时并用磺胺类药物和抗生素药物，效果更好；剧烈呕吐和下痢时，必须补液，同时给以大量维生素B₁、C、K等。中毒性胃肠炎：以解毒为主，按单纯性胃肠炎方法治疗。传染性胃肠炎：用抗生素药物或磺胺药物治疗。寄生虫性胃肠炎：以驱虫为主，按单纯性胃肠炎的药物疗法治疗。嗜酸性白细胞性胃肠炎：用肾上腺皮质激素治疗有效。溃疡性结肠炎：用强的松龙0.1—1.0毫克/公斤体重，内服；或用地塞米

松0.5—2.0毫升，肌肉注射；同时给大量抗生素药物，氯霉素55毫克/公斤体重，内服，每日3次。投给大量维生素制剂和输液。

幽门痉挛

病因 幽门前庭运动减少或缺，幽门括约肌紧张。十二指肠溃疡和重度胃炎均可引起。

症状 短头种犬和易兴奋的犬多发。一般3岁以下犬多见。摄取食物或水之后，引起间歇的、不规则的喷射状呕吐。呕吐物是新摄取的物质。一般临床检查几乎没有任何异常。幽门痉挛长时间发生，则形成肥厚性幽门狭窄。发育迟缓，消瘦。

治疗 根本疗法是幽门肌切开术。对症疗法，投给阿托品和东莨菪碱制剂，0.05—0.1毫克/公斤体重，食前20—30分钟投给。或用氯普马嗪1—2毫克/公斤体重，食前30分钟，经口投给，制止幽门痉挛。改变饲喂方法，每次喂少量，每日分3—4次喂给。

磷中毒

磷有黄磷和红磷，引起中毒的是黄磷。红磷是不溶性的，经口摄取不引起中毒症状；黄磷是脂溶性的，胃肠内存在脂肪和胆汁等，则变为可溶性的，在小肠内几乎完全吸收而发生中毒。

病因 黄磷是杀鼠剂、杀虫剂和农药的主要成分。由于广泛应用杀鼠剂、杀虫剂和农药，造成误饮、误食而中毒。驱虫、灭鼠时药量过大或用药不当而发生中毒。还可由食入被杀虫药杀死的鼠类而引起本病。

症状 病犬出现大量流涎，显著口渴。呕吐和下痢，常常可见血性呕吐物，呕吐物和排泄物具有蒜臭味，呕吐物放在暗处发出荧光。腹痛，不安，结膜呈现点状出血。肌肉震颤、全身抽搐等神经症状，最后昏迷、呼吸困难、心力衰竭而死。

治疗 催吐剂：硫酸铜0.1—0.5克，溶于5—10毫升水中，内服。洗胃：0.1—0.2%高锰酸钾溶液50—100毫升，进行洗胃。泻剂：硫酸镁5—10克，一次量，加适量水，内服。可用4%解磷定5—10毫升，静脉注射，每2—3小时一次。或用1%硫酸阿托平0.5—1毫升，肌肉注射。补液：补以5%葡萄糖溶液和林格儿氏液等量混合液，以40毫升/公斤体重，点滴静注。给以强心剂、维生素制剂。

（六）伴有鼻汁和发咳的疾病

鼻 炎

鼻炎是多种原因所致的鼻腔粘膜炎症。以鼻粘膜充血、流鼻汁、打喷嚏为特征。春秋季节易于发生。

病因 按病因分为原发性和继发性。

原发性鼻炎主要是鼻粘膜受寒冷、化学性的、机械性的因素刺激而引起。

寒冷刺激：由于气温骤变，冷空气刺激鼻粘膜而引起，该原因占的比例较大。

继发性鼻炎：多继发于犬瘟热、传染性鼻气管炎等传染病。由犬的鼻螨等寄生虫寄生也可引起粘膜发炎。此外，邻近器官炎症的蔓延，如副鼻窦炎的蔓延引起鼻炎。

症状 分为急性和慢性鼻炎。

急性鼻炎：两侧鼻孔或单侧鼻孔流出鼻汁，鼻汁呈浆液性、粘液性、脓性或血样。由于鼻汁的存在，造成吸入性呼吸困难，呼吸促迫，结膜潮红，有时出血。眼有分泌物。频发喷嚏，前爪搔抓鼻端。

慢性鼻炎：病情进展缓慢，长期流鼻汁，多呈脓性，在鼻孔周围附着，有时发出鼻塞音。下颌淋巴结肿胀。

治疗 除去病因，将病犬移至通风良好、温暖的地方。轻症可自然治愈。对重病犬，清洗鼻腔，保持清洁。对于有大量浆液性鼻汁的病例，用2—3%硼酸溶液或1%明矾溶液、0.1%高锰酸钾溶液、0.1%鞣酸溶液清洗鼻腔，每日2—3次；对于有粘液性和脓性鼻汁的病例，用1%碳酸氢钠溶液或温生理盐水清洗鼻腔，每日2—3次。清洗后，注入抗生素药物或软膏，如青霉素、四环素等，或用1%氨苯磺胺溶液或0.1%蛋白银溶液。

表 8 伴有鼻汁和发咳的疾病

疾 病	主 要 症 状
鼻 炎	鼻汁，喷嚏，眼分泌物，鼻出血，颜面变形
副鼻窦炎症	脓性鼻汁，喷嚏，食欲不振，流涎，口臭，轻度发热
支气管炎	阵发性咳嗽，急性期为干咳，强咳，鼻汁，支气管呼吸音粗厉，有食欲和精神
支气管肺炎	发热，湿性，痛性深咳，粘液性和脓性鼻汁，水泡音，呼吸促迫和困难
弓形体病	发热，下痢，视力障碍，运动障碍，意识障碍，出现神经症状
副流感病毒感染症	发咳，鼻汁，发热，突然发生，群发，扁桃腺肿大
犬瘟热	发热，呼吸困难，结膜炎，发咳，鼻汁，下痢，癫痫，硬脑病，皮肤发疹
咽头炎	食欲减退，流涎，发咳，呕吐，咽下困难压痛(+)，呼吸困难，下颌淋巴结肿大
犬丝状虫病	咳嗽，贫血，腹水，浮肿，呼吸困难，黄疸，易疲劳，收缩期心杂音

对于慢性鼻炎，除局部清洗外，用地塞米松0.12—1 毫升/公斤体重，口服或肌肉注射，每日 1 次。

副鼻窦炎

副鼻窦炎即副鼻窦——上颌窦、额窦和蝶腭窦的粘膜炎症。临床上以脓性鼻涕、压痛为特征。

病因 由细菌、寄生虫等感染而发生。也可继发于鼻炎、牙齿疾病、鼻腔肿瘤等。

症状 疼痛反应：急性、慢性副鼻窦炎均有疼痛反应，表现为惊恐不安，狂叫，上窜下跳。少数病例局部有压痛，躲闪。

鼻涕：一侧或两侧流有浆液鼻涕，不久则流有黄色脓性鼻涕，有恶臭味。当低头、咳嗽、打喷嚏时大量流出。结膜潮红、流泪，呈吸气性呼吸困难。

局部变化：局部出现不同程度肿胀，触诊有热、痛、下颌淋巴结肿大。时间长者，局部膨隆、变形。叩诊呈浊音。穿刺可抽出红色渗出液或脓汁。

治疗 穿刺或排液孔排液，排出窦腔内贮留的脓汁。用 0.5% 高锰酸钾溶液或 1% 明矾溶液清洗鼻腔，清洗窦腔。然后注入青霉素、四环素等。全身用药：氨苄青霉素 20—40 毫克/公斤体重，每 6 小时经口投服；土霉素 30 毫克/公斤体重，每 8 小时经口投服，连用 15 日。必要时可进行圆锯术手术治疗。

支气管炎

支气管炎是大、中支气管的粘膜、粘膜下组织和气管周围组织的急性和慢性炎症。临床上以咳嗽、流鼻涕、肺部听

诊有罗音，并有不同程度的呼吸困难为主要症状。本病易发于春秋季节。

病因 感染：由细菌、病毒感染而发病，有时可见真菌和支原体感染。

机械的和化学的刺激：尘埃、刺激性和有毒气体、杀虫剂等吸入。

其它：环境的改变，如长途运输、潮湿和冷空气的刺激，冬季打猎或执行任务时都易发本病。

症状 急性支气管炎，病初为短而干的强咳，压迫气管部易诱发，特别是运动、采食和气温变化等也易发咳。病犬精神、食欲无明显变化，无热。排出水样鼻汁。听诊支气管音粗厉。细菌等感染波及细支气管发炎时，湿性痛咳，排出粘液或脓性鼻汁，呼吸数增加，肺部听诊可听到湿性罗音。连续体温升高，应怀疑犬瘟热和肺炎。

慢性支气管炎以顽固性湿咳为主要特征，也有发生连续的干咳的。肺呼吸音不见异常，有时在肺部可听见湿性罗音和捻发音。胸部X线所见，急性支气管炎，沿支气管有斑状阴影，慢性支气管炎，肺纹理清晰，有较粗的肺纹理阴影。

治疗 保持病犬安静，放在保温、通风良好、干燥的地方。急性期青霉素、链霉素单独或联合使用，或用磺胺类药物。也可用四环素、土霉素等。

使用镇咳、去痰和解痉剂：镇咳剂给以磷酸可待因1—2毫克/公斤体重，经口投给，每日2—3次，也可用氯化铵、咳必清、复方甘草片、诺司咳平制剂、美纱劳制剂和乙酰半胱氨酸等。去痰剂：氯化铵0.2克/公斤体重，一次量经口投给，每日2—3次。解痉剂：用盐酸苯海拉明、盐酸异丙嗪和氯苯吡胺等。或用痰易净（乙酰半胱氨酸）喷雾，以

每小时50毫升速度向呼吸道喷雾30—60分钟，每12小时一次。给以肾上腺皮质激素类药物。急性或慢性病例，也有用抗炎症酶剂，糜蛋白酶5000—10000单位/日，皮下注射，连用数日。吸入疗法：用吸入器将药物（重曹、食盐水、抗生素等）吸入。

支气管肺炎

支气管肺炎系指包括细支气管和肺泡的肺的急性和慢性炎症，或称为支气管肺炎和卡他性肺炎（小叶性肺炎）。临床上以弛张热型、咳嗽、流鼻汁及呼吸困难为特征。春冬季多发。老龄犬和幼龄犬易发。

病因 主要原因和支气管炎相同。除此之外，特殊的原因是由误咽性肺炎、异物性肺炎等形成支气管肺炎。营养下降、体力消耗、气候骤变也可诱发本病。

症状 精神不振，食欲不振或废绝。体温升高到40℃以上。流鼻汁，病初为粘液性，以后变为脓性，有时混有血液。发生湿性痛咳、深咳。脉搏增数，可视粘膜发绀。严重病犬，出现呼吸促迫，呼吸困难，可见鼻翼开张，呼气时颊部呼吸等。

肺部叩诊时出现浊音区，听诊时可见湿性罗音和捻发音，支气管呼吸音粗厉。随着病程发展，肺泡音减弱或消失。

X线检查，肺纹理增强，小片状的灶性阴影。

治疗 同支气管炎。

弓形体病

弓形体病是由粪地弓形体引起的人犬共患的原虫病。本

病在世界各国广泛存在，我国在家畜、豚鼠、猫等均有发生的报道。

病因 弓形体是寄生于猫体内的一种肠道球虫。根据其不同的发育阶段，分为滋养体、包囊、裂殖体、配子体和卵囊。前二型寄生在中间宿主人和家畜体内，而后三型则寄生在猫的体内。猫是终末宿主。

当猫吞食感染弓形体包囊的动物组织（如小田鼠、鸟类等），在猫的肠上皮细胞内发育成卵囊，卵囊随猫粪排出体外，在适宜的环境中经2—4日发育成感染卵囊，被中间宿主吞食后，在肠内子孢子逸出，侵入血液分布全身，钻入各类细胞内繁殖。通过口、眼、呼吸道、肠道以及皮肤而感染犬，也可通过胎盘感染。

症状 一般呈隐性和亚临床感染。多为散发。幼犬：体温升高，食欲不振或废绝。精神沉郁，结膜苍白，咳嗽，呕吐；排出水样和出血性下痢便；流鼻汁，呼吸困难；黄疸和贫血，痉挛和麻痹等中枢神经障碍。成犬感染多为慢性经过，出现食欲减退，精神不振，下痢，视力障碍，麻痹，运动失调等神经障碍。

治疗 用磺胺二甲氧嘧啶100毫克/公斤体重。一日量，分4—6次内服。肌肉注射用量为60毫克/公斤体重。亦可用磺胺异噻唑。亦可用磺胺-6-甲氧嘧啶5份、磺胺增效剂1份，混合，20—25毫克/公斤体重，每12—24小时1次，口服，连用3—5日。或用增效磺胺-5-甲氧嘧啶注射液2—3毫升，肌肉注射，每日1次，连用3—5日。

预防 犬舍定期消毒，保持清洁。病犬严格隔离。控制犬与猫接触，严禁猫进入犬舍，切断传染源，防止感染。与病犬接触人员做好防护工作，特别孕妇更应注意，以免感

果。

副流感病毒感染症

犬的副流感是1967年在英国发现的，以呼吸器官症状为主要特征的病毒性疾病。群发是其特征。在我国已有发生的报道。

病因 本病的发生原因是副流感病毒感染。从感染犬的鼻汁和咽头部可分离出本病毒。由于飞沫吸入而感染。集团饲养下容易蔓延。仔犬、衰弱犬和处于应激状态的犬易感。

症状 突然发病，体温上升，病初流有多量浆液性和粘液性鼻汁。有一部分病例，可见咳嗽，扁桃腺发红，肿胀。

治疗 本病无特效药，应防止二次感染和对症治疗。可用氯霉素10—30毫克/公斤体重，肌肉注射。或用泰乐菌素5毫克/公斤体重，肌肉注射。或用四环素7毫克/公斤体重，肌肉注射。镇咳剂：氨茶碱10毫克/公斤体重，肌肉注射。消炎剂：地塞米松0.25—2.0毫克/公斤体重，一日量，肌肉注射；或强的松龙0.5—1.0毫克/公斤体重，一日量，肌肉注射。给予大量维生素C2000—4000毫克/日。

预防 犬副流感疫苗接种可以防止本病发生。按疫苗说明书使用。

（七）出现呼吸困难的疾病

横膈膜疝

肝和胃肠等的腹腔脏器通过膈的裂隙进入胸腔内的疾病称横膈膜疝。属于内疝之一。

病因 膈疝有先天性和后天性两种。先天性的由膈肌发

育不全，某一部分缺损，导致本病发生。后天性的大部分病例都是由外伤所致，如从高处摔倒，交通事故，畜主粗暴对待以及被火动物踢伤等，使腹腔压力急骤增加，致使膈肌破裂所造成。其破裂部大部分在横膈膜的肌质部或食道裂孔的腹侧部。右侧较多。

症状 先天性一般发病缓慢，逐渐恶化。有的仔犬在断奶后出现症状，采食固体食物时，出现腹痛、呕吐、下痢、呼吸困难等。

后天性发病急，伤后表现疼痛不安，呼吸浅表而快，呈

表 9 **出现呼吸困难的疾病**

疾 病	主 要 症 状
气 胸	腹式呼吸，发绀，胸壁起伏，易疲劳，肺部鼓音
横膈膜疝	腹部缩小，持续性犬坐姿势，咳嗽，疲劳，突然发生，胸部可听见肠蠕动音
犬瘟热	发热，呼吸困难，结膜炎，发咳，鼻汁，下痢，皮肤发疹，出现神经症状，硬脑病
产后急病	强直性间歇性痉挛，流涎，发热，异常兴奋，呼吸促迫，呼吸困难。多产的小型犬易发
胸膜炎	浅而快的呼吸，发热，发咳，发绀，胸部压痛，胸膜摩擦音，胸壁疼痛，呼吸困难
腹 水	腹部波动感，腹壁紧张，呼吸困难，易疲劳
热射病	明显体温升高，呼吸促迫，呼吸困难，瞳孔散大，痉挛抽搐，起立困难，结膜发绀，红细胞增多
疱疹病毒感染症	急速死亡，食欲废绝，腹部压痛，呼吸促迫和困难，出现神经症状。新生仔犬易发
支气管肺炎	发热，湿性，痛性深咳，粘液性和脓性鼻汁，水泡音，呼吸促迫和困难
犬丝状虫病	咳嗽，贫血，腹水，浮肿，呼吸困难，黄疸易疲劳，收缩期心杂音，嗜血
动脉导管未闭	呼吸困难，易疲劳，心杂音，结膜发绀，左前胸震颤，红细胞增加，生后3个月至3岁犬易发
法乐氏三联症	呼吸困难，结膜发绀，虚脱，收缩期心杂音，右2—3肋胸壁震颤，红细胞增加

腹式呼吸。有时伤后很久才出现症状。病犬呼吸困难，不愿活动和侧卧，喜欢呈犬坐和起立位姿势。若小肠进入胸腔，在胸部可听到肠蠕动音。若胃进入胸腔，有不同程度扭转。因此，病犬食欲减少，采食后立即出现呕吐。

治疗 手术治疗，闭合疝孔。手术通路应根据病情确定。手术切开后将进入胸腔的器官还纳回腹腔，以连续缝合法闭合疝孔。手术宜早不宜迟。

犬 瘟 热

犬瘟热是犬的代表性、急性、热性病毒性疾病，传染性强。其发生无地区和季节的不同，死亡率也高。本病的特征性变化是全身的粘膜发生急性卡他性炎症和非化脓性脑炎。未满1岁犬，特别是3—6个月龄的仔犬多发，有时大些犬也发生。本病也见于多种野生动物。

病因 本病由犬瘟热病毒感染而发病。犬瘟热病毒属于副粘膜病毒科麻疹病毒属，为RNA型。经口或经气管而感染。潜伏期为3—6日，平均为4日。

感染途径 主要是飞沫感染。其次是被病犬鼻汁、眼分泌物和尿污染饮水、食物、饲养用具、犬舍等间接感染。

症状 精神不振，食欲减少，体温升高达39.5—41.0℃，呈弛张热型。消瘦，脱水，可视粘膜发绀。心跳增加，可见有粘液性、脓性眼分泌物。角膜干燥，发痒，用前爪搔抓。鼻镜干燥，流有粘液性或脓性鼻汁，打喷嚏，咳嗽，初期为干咳，进而变为湿性痛咳。呼吸促迫。在肺部可听见呼吸音粗厉，湿性罗音和捻发音。

食欲不振，继之呕吐。多数发生肠卡他，腹部压痛，下痢。粪便恶臭，混有粘液，或排泄暗红褐色的血便。

神经症状首先出现过敏症状和口唇、耳、眼睑麻痹，继之出现兴奋、癫痫样发作、回转，一旦反复发生数次，发生时间较短，数秒乃至数分钟。癫痫发作时，流涎，污染口角部被毛。多数病例还发生头部、颈部、四肢及躯干诸肌的麻痹、运动失调和后肢麻痹等。

病幼犬早期在皮肤、下腹部和股内侧出现丘疹，米粒大乃至豆粒大脓疱，散在。有些病犬在鼻部和足垫部发生表皮角化症。最近发生的犬瘟热病犬极少发生脓疱。

诊断 幼犬发热首先应考虑为犬瘟热，发热卡他病，伴有神经续发症时，可初步诊断为犬瘟热。分离到犬瘟热病毒可以确诊。在感染的组织内或在血细胞内（红细胞、白细胞）找到典型的包涵体，也可作为诊断依据。

治疗 怀疑犬瘟热或病的初期，使用大量抗犬瘟热血清和 γ -球蛋白，或立即接种致弱的活毒疫苗。

防止继发感染：使用磺胺制剂或抗生素药物，防止细菌的继发感染。如氨苄青霉素、氯霉素、四环素、土霉素、柱晶白霉素等，四环素禁用于未长出永久齿的幼犬。

对症治疗：使用抗癫痫剂和脑代谢赋活剂，抗癫痫剂，麦苏林250—1000毫克/日，分2—3次内服。或用复合苯妥因钠100—200毫克/日，分2—3次内服。脑代谢赋活剂，羟丁氨酸200—1000毫克/日，分2次内服。

使用强的松龙2—10毫克/日，皮下注射。或用地塞米松1—5毫克/日，皮下注射。控制中枢神经系统水肿，不同程度中止神经症状。

其它可配合使输液、强心、利尿、止吐、镇咳、去痰剂，给以大量维生素B₁和C。

预防 采取综合性预防措施，定期预防注射。病犬早隔

及早治疗，严格消毒，防止传染。

目前使用的疫苗：鸡胚弱毒疫苗、细胞培养弱毒疫苗、犬瘟热与犬传染性肝炎联合疫苗等。现在认为活的病毒疫苗免疫效果最好，安全性也好。免疫程序如下：每年对所有犬用鸡胚弱毒疫苗或细胞培养弱毒疫苗进行免疫接种。3个月龄以上的犬只接种一次疫苗，3个月龄以下的犬则应接种两次，第一次在断奶以后接种，第二次在12—15周龄时接种。未断奶的小犬，可在2周龄时以活毒疫苗接种。

产后急病

产间急病又称子痫、产褥性强直。本病是以低钙血症为特征。是运动神经异常兴奋，导致肌肉强直性痉挛的疾病。小型犬、少数中型雌犬在分娩后大约7—20日间发生。少数发生在分娩当中或分娩前。

病因 发病原因尚不十分清楚。初步认为在胎儿形成时骨骼形成需要钙，新生犬哺乳量增加，细胞外液中的钙明显下降，神经被刺激性增高，引起肌肉的兴奋和痉挛。小型玩赏犬多胎时，泌乳开始后1—3周发病。

症状 病初病犬不安，流涎，呻吟和步样强拘。数分钟至数小时内，发生不能起立，肌肉震颤，激烈的呼吸促迫和呼吸困难，强直性或间歇性痉挛。进而病情进展，频繁的痉挛，同时呼吸促迫，连续性明显的流涎，体温上升，脉频数，结膜充血。

治疗 补充钙剂。葡萄糖酸钙0.5—2克，静脉注射。或口服碳酸钙1—2克，每日1次。或维生素D₂胶性钙2500—5000单位，每日1次，6—7日为一个疗程。镇静剂，戊巴比特钠10毫克/公斤体重，静脉注射。

胸 膜 炎

胸膜炎系指胸膜发生炎性渗出和纤维蛋白沉积的炎症疾病。胸膜炎分为干燥型和渗出型，渗出型又分为浆液性、脓性和凝乳糜性。按病程分为急性和慢性胸膜炎。

病因 原发性胸膜炎在犬比较少见。多发生于交通事故胸壁挫伤以及穿透性创伤等。大多数病例继发于胸部器官疾病的蔓延，如肺、心包、肋骨、胸骨骨折感染等。也可继发于某些传染病，肺结核常引起亚急性或慢性浆液性和浆液渗出性胸膜炎。化学因素与寄生虫的刺激也可发生本病。

症状 病初食欲不振，精神沉郁，呼吸快而浅表，体温升高。喜欢站立和犬坐姿势，不愿活动。结膜发绀，咳嗽，肺部听诊可听见摩擦音。随着渗出液的增加，摩擦音消失。大量渗出液贮留，出现呼吸困难。触诊胸壁有疼痛反应。叩诊出现水平浊音，超声波检查出现液平段。

胸腔穿刺可流出大量黄色渗出液，含有大量纤维蛋白凝块，易凝固。堵塞时用注射器抽取。渗出液呈红色为出血性胸膜炎；渗出液有脓汁时为化脓性胸膜炎。

嗜中性白细胞增多，并伴有核左移。

1. Rivalta's 反应：取量筒加水200毫升，再加冰醋酸两滴，混合均匀，静置数分钟，从接近液面处加穿刺液一滴，观察液面上层生成的云状白色絮状物的沉淀状态。

渗出液——白色絮状物较快形成沉淀，并下降量筒的底部。

漏出液——白色絮状物较快形成沉淀，但未降至筒底即迅速消失。

2. Moritz反应：取小试管加穿刺液2毫升，再加3%

表10

渗出液和漏出液的鉴别

性 状		渗出液	漏出液
		炎 症	非炎症
物理学的性状	粘稠度	粘稠、混浊	水样、透明
	颜 色	白色、黄色、红色	无色或淡白色、淡黄色
	气 味	+	-
	凝固性	凝 固	不凝固
化学的性状	纤维素片	多	少或无
	比 重	1.018以上	1.015以下
	蛋白质含量	3.5克/100毫升	2.5克/100毫升
	酸碱反应	碱 性	酸 性
细胞学特征	细胞数	非常多、嗜中性的细胞增多	少或无
	细 菌	多	少或无
	Rivalta反应	+	-

附：检查方法引自《小动物疾病》南京农业大学1989。

醋酸液1—2滴，观察结果。

渗出液——加醋酸后液体变混浊不透明。

漏出液——加醋酸后液体不变混浊。若再加醋酸可出现分子反应。

治疗 消除炎症，减轻疼痛，制止渗出和促进吸收为原则。消除炎症，全身或胸腔内注射抗生素或磺胺类药物治疗，同时胸壁上涂擦10%樟脑酒精溶液，或松节油，或芥子泥等。

制止渗出，促进吸收：用10%氯化钙注射液5—20毫升，40%乌洛托平3—5毫升，混合静脉注射，每日1次，连用3—5日。适当地应用强心、利尿及缓泻剂，如安那加、利尿磺胺2—4毫克/公斤体重，8—12小时1次，

经口投服或静脉注射。内服硫酸镁等。

消除疼痛：疼痛时，给以度冷丁11毫克/公斤体重，8—12小时重复一次，肌肉注射。

渗出液过多，高度呼吸困难时，应穿刺排液。穿刺排液后，若胸腔内渗出液混有脓汁，可用0.01%呋喃西林等消毒液冲洗胸腔，抽净洗液，再往胸腔内注入青霉素、链霉素等抗生素药液。

（八）心音、脉搏异常和可视粘膜发绀的疾病

动脉导管未闭

动脉导管是胎儿时期肺动脉和主动脉之间的通道，生后不久即闭合，如持续不闭，则成为病态，在临床上称为动脉导管未闭。是先天性心脏病之一。动脉导管未闭在先天性心脏病中占25—36%，是发病率最高的疾病。

病因 发病原因尚不明确。根据疾病学研究结果，贵妇犬、柯利犬、松鼠犬和德国牧羊犬易患本病。

症状 病犬在生后数周或数月之内出现症状。一般病犬无特殊症状。大多数病犬结膜无异常，少数病犬结膜发绀，心悸，脉搏频数，强度减弱。哺乳力下降，发育迟缓，可见腹水贮留、四肢浮肿。心脏听诊，出现连续性杂音，杂音在收缩期末及舒张期开始时最明显。心音第二音亢进和分裂。

胸部X线检查，可见左心室和左心房扩大。肺动脉阴影增强（扩张）。

治疗 以手术闭锁导管。手术先打开胸腔，细小的导管

以缝合线双重结扎。粗大导管要结扎并切断。逆向分流者禁忌手术。

表11 心音、脉搏异常和可视粘膜发绀的疾病

疾 病	主 要 症 状
动脉导管未闭	呼吸困难，易疲劳，连续性机械性心杂音，连续性左胸部震颤，体重减少，红细胞增加。生后3个月至3岁犬易发，结膜发绀
法乐氏四联症	呼吸困难，发绀，右2—3肋胸区震颤，虚脱，红细胞增加，收缩期心杂音
气 胸	呼吸困难，腹式呼吸，易疲劳，患侧胸壁隆起，叩诊呈鼓音
热射病	明显体温升高，呼吸促迫，呼吸困难，瞳孔散大，痉挛和抽搐，起立困难，红细胞增多，结膜发绀
产后急病	多产的小型犬易发，呼吸促迫和困难，异常兴奋，强直性间歇性痉挛，流涎，发热
犬丝状虫病	咳嗽，贫血，腹水，浮肿，呼吸困难，黄疸，易疲劳，收缩期心杂音

(九) 排尿异常的疾病

肾 炎

肾炎系指肾皮炎和髓质的炎症。临床上以肾区敏感、疼痛、尿量减少、尿中含有病理性产物为特征。

病因 肾炎的病因尚不完全清楚。目前认为首先是感染的原因，某些传染病，如犬瘟热、钩端螺旋体病等疾病中，其病毒、细菌及其毒素作用于肾脏或由变态反应而发生。受寒感冒以及使机体抵抗力下降的因素均可诱发本病。某些中毒疾病、严重饲料腐败或某些药物过量也可引起肾炎。也可继发于泌尿系统疾病、湿疹、黄疸等。

症状 在临床上分为急性肾炎和慢性肾炎。

急性肾炎：病犬食欲减退，精神沉郁，呕吐，体温升高。病犬不愿活动，站立时拱背、后肢开张。触诊肾区病犬躲避，或抗拒检查，严重者，强行检查病犬尖叫或呻吟。由于肾区检查的反射刺激，病犬频频排尿，尿液量很少或无尿。

尿液检查：尿液比重高，尿色暗混浊，有蛋白质。若有血液则呈黄红色或红色。尿沉渣镜检时，有红、白细胞、肾上皮细胞以及肾管型。

慢性肾炎：急性肾炎治疗不及时，常转为慢性肾炎。其症状基本与急性肾炎相同，但慢性肾炎发展缓慢，症状不十分明显，病情时好时坏。

治疗 消炎。全身给以大量青霉素、链霉素、卡那霉素等药物治疗。有人认为呋喃咀啉效果最好。也可用乌洛托平。病犬出现浮肿时，给以利尿剂，醋酸钾 1—2 克/日，分 3 次内服。利尿素 0.1—1 克/日，硝酸钾 0.2—0.5 克。输液补糖。应用肾上腺皮质激素药物，强的松龙 1—2 毫克/公斤体重，倍他米松 1—2 毫克，经口投服。消炎痛 20—50 毫克，经口投服。或用环磷酰胺 2 毫克/公斤体重，皮下注射。

加强护理，改善饲养。避免激烈运动，注意保温，防止感冒。限制饲喂食盐，给高能量、低蛋白饲料，减少饮水。

膀胱破裂

膀胱破裂系膀胱发生裂伤造成膀胱壁破裂，尿和血液流入腹腔的疾病。

病因 膀胱内充满尿液，容积增大，内压增高，膀胱壁变薄。任何引起腹内压增高的因素，如卧地、努责、挤压、

表12

排尿异常的疾病

疾 病	主 要 症 状
肾 炎	食欲减退，精神沉郁，体温升高，尿频，弓背，肾部疼痛，白细胞增加，尿圆柱
膀胱破裂	乏尿或无尿，腹部膨满，步样强拘，血尿
膀胱炎	排尿痛，尿频，尿混浊，尿血，脓尿
尿石症	尿频，尿闭，尿血，腹部膨满
前列腺肥大症	便秘，努责，粘液便，排尿困难，消瘦。老龄犬易发
前列腺囊肿	便秘，尿急后重，粘液便，尿闭，尿失禁
前列腺炎	体温升高，食欲减退，便秘，努责，血尿，排尿困难。老龄犬易发

殴打、争斗、从高层建筑跌落等都可导致膀胱破裂。交通事故可造成骨盆骨折片刺入而破裂。猎枪弹和刀等刺入也可造成破裂。

症状 初期膀胱的抵抗感突然消失，疼痛，运动不灵活，出现强直步样。导尿管导尿减少或无尿。出现明显的血尿。穿刺排液，腹水具有尿的气味，而且量多，混浊。时间较久，随着尿液进入腹腔，则腹膜炎和尿毒症症状逐渐加重。病犬精神沉郁、眼结膜高度弥漫性充血，体温升高，肌肉震颤，食欲废绝。触诊腹部敏感，有时出现起卧、打滚等腹痛症状。贫血和脱水，血压下降，频频呕吐。

治疗 行膀胱破裂修补术。修补时间越早越好。采取腹正中切开，脐至耻骨前缘之间。切开腹腔后除去腹腔内容液，吸净内容液后，再用灭菌温生理盐水冲洗腹腔。除去膀胱内结石、血凝块，冲洗膀胱和尿道结石。缝合膀胱壁，采取伦贝尔氏缝合法。再次冲洗腹腔，洗净腹腔内脏器和腹腔。腹腔内投入抗生素药剂、青霉素G100万单位/10公斤体重。闭合腹腔。

控制和治疗腹膜炎：全身使用抗生素药物或磺胺类药物，这些药物也可腹腔注射，对控制和治疗腹膜炎更为有利。

治疗原发病：及早治疗原发病，务必使尿路及早畅通，恢复排尿功能。

膀胱炎

膀胱炎系膀胱粘膜表层或深层的炎症。

病因 主要是由葡萄球菌、链球菌等经血液或尿道侵入膀胱内而引起。肾炎、尿道炎、阴道炎等蔓延，以及导尿时消毒不严或损伤膀胱粘膜均可引起本病的发生。先天性和后天性免疫障碍也可引起。

症状 病犬排尿时疼痛不安，频尿，每次尿量较少，尿液混浊，有恶臭味，也有的引起排尿障碍。有的排血尿，末期特别重。触诊膀胱，病犬表现疼痛，膀胱收缩、空虚。慢性经过时，可触知膀胱粘膜肥厚。也有的可触知肿物和结石。全身症状一般变化不大，但病情严重者，表现精神沉郁，食欲减少或废绝，体温升高等。

治疗 给尿道防腐剂，乌洛托品0.25—1克、氯化铵2—3克，加水混合，一次内服，连服数日。必要时用温生理盐水、1—2%硼酸溶液等冲洗膀胱。可反复冲洗。冲洗后放入抗生素药物。全身应用抗生素药物，青霉素、氨苄青霉素、四环素、氯霉素等。

禁喂带刺激性食物，多饮水。

尿石症

结石在肾盂或膀胱内形成，刺激损伤尿路粘膜，引起尿

道和尿管闭塞的疾病。

病因 尿中的胶体与晶体不均衡引起盐类沉积而形成结石。结石的形成尚需一核心，其上皮细胞、尿圆柱、凝血块、纤维蛋白、坏死组织等均可成为核心。尿的 pH、温度、离子浓度等的变动也是促进沉淀的主要原因。维生素 A 缺乏和雌激素过多症可促进上皮脱落，易形成核心。饮水量不足和代谢障碍，造成尿中矿物质浓度增加，促进晶体沉淀。

发生频率约占犬的 0.4—2%，纯种犬约占 3%。

结石种类：磷酸铵镁结石，占尿结石的 60%。雌犬多发；尿酸胺结石，占尿结石的 6%，雄性斑点犬易发；胱氨酸结石，约为 20%，各种犬的幼雄犬，特别是斗牛犬；草酸结石，约占 14%，雄犬多发。

症状 由于结石存在部位不同而异。

膀胱结石：可见频尿、血尿和努责。由于结石致使排尿障碍和尿闭。腹围膨隆。腹部触诊可触及结石。

尿道结石：努责、尿淋漓、血尿和尿闭。尿闭后腹围很快膨隆，产生尿毒症，易发生膀胱破裂。

输尿管结石：呕吐、重度疼痛，感染则体温上升。有时可见血尿，症状急，严重。发生频率极低。诊断极为困难。

肾结石：不并发肾盂肾炎时，不见临床症状。一般排血尿，若细菌感染时，在尿中混有细菌、脓球、红细胞和细尿管上皮细胞。

治疗 膀胱结石的治疗：大块结石行膀胱切开术，取出结石；小块结石可用超声波击碎。术后给以透明质酸酶 10 V R 单位，肌肉注射，连用 7 日。以后每周 1 次，连用 4 周。

尿道结石：轻症可用尿道探子插入，来回抽动，再用生理盐水和液体石蜡等量混合液注入，高抬马上放低使液体流出，或逆方向冲进膀胱内。重症可行尿道切开术。

预防 食盐疗法，根据犬的大小，可在饮水和食物中添加食盐0.5—10克/日，分2—3次。饮水量增加2倍以上，以图利尿排石。

为防止磷酸铵镁结石和草酸结石，给予米饭和动物性蛋白为主体的酸性食物，以图尿呈酸性化。

为防止胱氨酸结石和尿酸结石，给予低蛋白食物混合重曹，以图尿呈碱性化。

为防止草酸结石，给予低钙食物。

溶解胱氨酸结石，可用右旋青霉氨25毫克/公斤体重·日，经口投给，每日2次。

溶解尿酸结石，可用别嘌呤醇4毫克/公斤体重·日，经口投给，每日2次。

前列腺肥大症

前列腺肥大症系尿道前列腺部的肌纤维组织和邻近的腺组织增生所致，形成大小结节、因有前列腺萎缩，从外部压迫直肠，因此，又称“结节状增殖”。与肿瘤有明显区别。犬的前列腺肥大症由于压迫直肠大部分以排粪障碍是主要特征，这与人显然不同，人压迫尿道引起排尿障碍。本病的发生率约占前列腺异常的60%。多见于老龄犬。

病因 前列腺肥大主要是由于性激素不平衡所致。

症状 前列腺肿胀，向头侧伸张可达骨盆边缘，显著肿胀可见临床症状。多数伴有排粪障碍。顽固性便秘，频频努责，排出少量粘液便，尿闭、尿失禁。直肠触诊可触知左右

对称的肿大部，无痛。

病理变化为不规则、多发性的肌纤维性间质的结节增殖，为良性肿大。在组织学上分为腺型、肌纤维型和肌纤维腺型（混合型）三种。腺型肥大是雄激素过剩所引起，肌纤维型肥大是雌激素过剩所致。

治疗 根治疗法是在适当时期进行被膜下摘出手术。

药物治疗，采用乙烯雌酚30—60毫克/日，经口投给。亦可与去势相结合。

前列腺囊肿

前列腺囊肿系前列腺导管和腺管闭塞，其分泌物贮留形成囊状所致，使前列腺局部或全部扩张，压迫尿道和直肠引起排尿和排便障碍。在临床上常伴发前列腺肥大。

病因 由于组织畸形致使囊肿形成，常伴随前列腺肥大而引起，睾酮过剩也可发生。

症状 本病与前列腺肥大症状相似。囊肿增大时，压迫邻近器官，引起便秘和排尿障碍，如在腺体后侧，可见会阴鼓起。直肠触诊可触知具有可动性、波动的非对称性前列腺肿大，无痛。如排出囊肿之内容物，可见排尿和排便障碍一时改善，数日后内容物充满，则又复发。

治疗 穿刺排出囊肿内容物，可一时地改善症状，不是根治疗法。多次穿刺易引起二次感染而发炎。

手术疗法，手术摘出囊肿及其内容物，结合去势术是有效的疗法。

前列腺炎

前列腺炎是炎性疾病，有急性和慢性前列腺炎、化脓

性前列腺炎和前列腺脓肿等。除慢性前列腺炎，都列入急性前列腺炎。多呈化脓性。老龄犬多发。

病因 一般认为是由于变形杆菌、葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌等细菌经尿道上行性感染所致。也可由血行感染。频繁导尿和前列腺穿刺时也可发生。

症状 便秘和里急后重是必发症状。体温升高，食欲不振，精神沉郁。病犬不安，呈拱背姿势、强拘步样。腹部后方压诊时躲闪，有疼痛表现。从阴茎流出血样乃至脓性排泄物。前列腺脓肿可见尿闭、排尿障碍。直肠触诊，可触知前列腺肿大、紧张，压诊时疼痛。前列腺脓肿时，可感知波动、柔软。白细胞增多。

慢性前列腺炎：症状不明显，间歇性出现体温升高、疼痛。从阴茎流出血样或脓样排泄物为主要特征，并发尿道炎。

治疗 抗生素药物单独或两种以上并用，特别是头孢菌素类抗生物物质，如头孢菌素，40毫克/公斤体重，分4次口服。

对于便秘和尿闭者，可进行灌肠和导尿。

对已形成脓肿者，进行外科手术引流或抽吸，配合应用抗生素疗法。大的脓肿可作前列腺切除术。

（十）骨、关节异常和跛行的疾病

佝偻病与软骨症

由于饲料中的钙和磷绝对不足、不平衡和代谢障碍而引起骨的钙化不全的疾病。在幼犬称佝偻病，成犬称软骨症。

表13

骨、关节异常和跛行的疾病

疾 病	主 要 症 状
佝偻病与软骨病	关节肿大，腕关节变形，异嗜，跛行，肋骨捻珠肿，胃肠卡他
慢性风湿性关节炎	跛行，关节肿胀，疼痛，捻发音，限制运动，发热
骨 折	局部肿胀，出血，疼痛，变形，功能障碍
膝盖骨脱臼	跛行，疼痛，股内翻转

病因 饲料中钙不足，钙磷比例失调（钙磷比例为1:1，矿物质在饲料中含量为0.3%），维生素D缺乏，紫外线照射不足，长期慢性消化障碍以及寄生虫的寄生，皆可引起本病发生。

症状 本病1—3个月龄的幼犬易发。关节肿胀，前肢腕关节变形和疼痛。跛行，四肢变形，呈X或O形。肋骨与肋软骨的结合部肿大，出现捻珠肿。病犬异嗜，发生胃肠卡他，消瘦。容易发生骨折和龋齿，有的不能站立。

治疗 加强饲养管理，合理搭配饲料，适当运动，多晒太阳，增加光照。

药物治疗，补充钙质和维生素D，乳酸钙、磷酸氢钙等，0.5—5克，混于饲料中喂服。或用5%葡萄糖酸钙30—50毫升，静脉注射，每日1次，连用数日。维生素D₃10—30万单位，肌肉注射，每日1次，连用数日。

慢性关节风湿症

风湿性疾病是关节周围、肌肉、骨骼、腱等广泛的运动器官，伴有慢性疼痛性疾病的总称，也称为风湿性综合症。这里重点叙述关节炎。

病因 真正原因不明。目前认为由于细菌感染，在体内产生代谢性和抗原性副产物，由这些副产物的作用引起一系列的变化。其次是病犬的血清中的异常 γ -球蛋白增加，发生免疫反应，所谓的风湿性因子。

症状 病初出现跛行，程度不一。患部不见肿胀，有时可听见捻发音。随着病情的进展，关节肿胀，运动障碍。关节腔内出血和形成腐骨，捻发音逐渐明显。股关节和膝关节最易发生。局部肿胀、疼痛的同时，出现热感。

治疗 最重要的是缓解疼痛，抑制炎症，其次是维持机能，防止关节变形。

水杨酸制剂，阿司匹林100—200毫克/日，分3—4次内服；水杨酸钠注射液，0.1—0.2克/次，每日1—2次，静脉注射。或用水杨酸钠粉，0.15—0.2克/次，每日0.5克以内，内服。

保太松制剂，初次量45毫克/公斤体重·日，每日分3次服用。最大量为800毫克/日，7—10日后无效停止用药。或用强的松龙0.5—1.0毫克/公斤体重，15—20毫克/日，最大量为30毫克/日，每日分2—3次内服。7—10日后渐轻，给以维持量5—15毫克/日。或用地塞米松，初期量0.5—2.5毫克/日，维持量为0.25—1.25毫克/日，每日分2—3次内服。或用水溶性强的松龙，5—20毫克/次，关节腔内、肌肉、静脉注射。也可用消炎痛、氯唑等药物。

温热疗法能减轻疼痛，可用温敷法、温水浴、红外线灯照射、超声波等治疗。

一般疗法，保持全身和关节的安静，适当的运动。补充维生素。

骨 折

骨和软骨组织的完整性完全或不完全断裂称为骨折。

病因 由于外力作用而引起，如打击、冲撞、压伤、从高处坠落、奔跑、枪击等。大部分是由车祸而引起，训练不慎也可发生。其次是由于佝偻病、骨脆弱症和骨肿瘤等，骨的抵抗力下降而发生。

症状 在临床上分为闭合性骨折和开放性骨折。犬的骨折多发生于四肢骨，后肢尤为多见。

骨折必发疼痛，在负重和运动时疼痛更明显。局限性疼痛可触知，并且和骨折纹相一致。肿胀，局部增温，出血。闭合性骨折发生血肿或组织内出血。开放性骨折外部可见明显出血。变位与转位，异常运动，可听见骨的摩擦音。四肢骨折出现明显机能障碍——跛行。神经受损则出现麻痹，颌骨骨折则咀嚼障碍。有的有并发症，体温上升，其它器官损伤。

治疗 以整复、固定和功能锻炼为原则，配合镇疼、消炎、止血和促进机能的恢复。

整复：以抻、按、压、揉等手法使骨骼恢复原位。复位越早越好。为了减轻疼痛和骚动不安，采用局麻或全身麻醉进行整复。

固定：为了防止再移位和保证愈合，应进行固定。固定方法很多，有外固定法（竹板固定法、石膏绷带固定法等）、内固定法（骨髓内轴固定、钢板固定法、钢螺丝固定法等），后者为观血固定法。

开放性骨折的治疗：全身麻醉，彻底消毒清洗，彻底除去坏死组织和污物，根据骨折性质和不同部位，选用接骨

板、骨髓内针、骨螺钉等进行内固定。闭合创口，再进行外固定。

术后护理和治疗：术后禁止活动 2—3 周。以后逐步活动，逐渐增加活动量。为了促进骨折愈合，可在饲料中加喂碳酸钙、维生素 A、D，也可注射葡萄糖酸钙、维生素胶性钙等。严重骨折或防止感染，可全身应用抗生素药物、肾上腺皮质激素药物。注射破伤风抗毒素防止发生破伤风。

膝 盖 骨 脱 臼

膝盖骨脱臼是膝盖骨从正常的位置向内侧或外侧滑脱，出现异常。本病是极其常发的疾病。一般小型犬多发，约占脱臼的 20%。

病因 由于外伤和骨折直接冲击膝盖骨周围而发生。先天性畸形和滑车沟缺损等遗传因素，或由急剧的外力作用于膝盖骨和韧带也能发生。

症状 在临床上有关节先天性、习惯性和外伤性膝盖骨脱臼。

外伤性：大部分为膝盖骨内方脱臼，突然发生，剧烈疼痛、肿胀。与犬种和年龄无关。触诊膝盖骨在内侧。

习惯性：脚弯曲，呈间歇性跛行。病犬脱臼时，患肢上举，飞节向外侧方弯曲，多用三肢跳行。触诊时可以整复回位，可是当再运动时又发生脱臼。跛行逐渐加重，并且呈现持续性。

先天性：生后就出现脱臼，6 周以上症状明显，膝关节明显变形，如两侧均发生，步行和起立困难。

治疗 首先应将膝盖骨整复原位，包扎固定绷带，以防再发。

对先天性膝盖骨脱臼，可行手术治疗。

（十一）眼的疾病

眼睑内翻

眼睑内翻系指眼睑向眼球侧弯曲，眼睑皮肤呈内翻状态。

病因 眼睑内翻有先天性、痉挛性和瘢痕性之分。

先天性眼睑内翻：犬多见。下眼睑外侧向内翻转，有时上眼睑和下眼睑的一部分或全部发病。塞特犬、贵妇犬、拉布拉多猎犬、中国松狮犬等品种多发，可能是遗传缺陷所造成。

痉挛性眼睑内翻：由于眼轮匝肌痉挛所致，也可继发于结膜炎、角膜溃疡、异物等激烈的眼痛。

瘢痕性眼睑内翻：犬发生较少。

症状 常见一侧或两侧眼睑边缘向内翻转，有流泪、羞明、疼痛等结膜和角膜炎症状。

鉴别先天性和痉挛性眼睑内翻的方法是在病眼上滴数滴2—3%盐酸普鲁卡因溶液，如果内翻解除，则为痉挛性眼睑内翻。

治疗 先天性和瘢痕性眼睑内翻行手术矫正。病犬进行全身麻醉，眼周围剃毛、消毒。创布盖于头部，露出患眼。用有齿止血钳距内翻部分的眼睑2毫米处钳起皮肤，使之形成一皱襞，用钝头剪刀剪去皱襞部分皮肤。止血后，再切除与皮肤相等的眼轮匝肌。最后缝合皮肤。10—14日后拆线。

瘢痕性眼睑内翻的矫正，切除瘢痕组织的同时，进行口腔粘膜移植。

表14

眼的疾病

疾 病	主 要 症 状
眼睑内翻	流泪，眼分泌物，瞬膜颤动，眼睑痉挛，角膜混浊，结膜充血
眼睑外翻	流泪，眼分泌物，结膜充血，角膜混浊，结膜露出
结膜炎	眼分泌物，结膜充血，流泪，结膜肿胀，羞明
角膜炎	角膜周围充血，羞明，角膜混浊，前房渗出，角膜新生血管
颜面神经麻痹	颜面肌麻痹，流涎，眼睑闭锁不全，结膜炎，耳下垂，唇下垂
犬瘟热	发热，呼吸困难，发咳，鼻汁，下痢，出现神经症状，结膜炎
破伤风	强直性痉挛，步样强拘，刺激过敏，角弓反张，瞬膜脱出，开口障碍
犬传染性肝炎	水样鼻汁，呕吐，角膜炎（混浊、溃疡），急死，出血倾向

眼睑外翻

眼睑外翻系指眼睑向外弯曲，眼睑皮肤呈外翻状态。是许多品种犬常见眼病。尤其是多见于美国柯卡、圣伯纳犬、巴斯克提、哈巴狗等。

病因 眼睑外翻有先天性、瘢痕性、无力性的眼睑外翻。

先天性眼睑外翻：已知有些犬种发生先天性眼睑外翻，如美国柯卡犬、圣伯纳犬、马士迪夫犬等。

瘢痕性眼睑外翻：由于外伤、热伤、手术、长期的眼睑炎等而引起瘢痕收缩所致。

无力性眼睑外翻：又称老年性眼睑外翻，老龄犬较多。眼睑皮肤弛缓和眼轮匝肌纤维变性引起下眼睑外翻。

症状 流泪污染颜面，出现眼分泌物，结膜长期露出而充血和肥厚。眼睑闭锁困难而引起角膜炎。

治疗 手术矫正。全身麻醉，眼周围剪毛、剃毛、消毒。先在眼睑外翻的下缘2—3毫米处，切一“V”形切口，V形上部应宽于外翻缘，在其尖端钝性分离皮瓣，分开后，从其尖端向上作“Y”形缝合，向上移动皮瓣至外翻矫正为止，确定缝合针数，进行缝合，最后形成Y字形。10—14日后拆线。

结 膜 炎

结膜炎系指眼结膜的炎症，主要发生于眼睑结膜和穹窿部结膜。眼结膜是被覆于眼睑内面和眼球表面的一层薄的透明膜，分为眼睑结膜、眼球结膜和穹窿结膜三部分。

病因 多为外伤、各种异物等机械性刺激，毒性气体和化学药物的化学性刺激以及光、热等物理性刺激均可引起，或继发于角膜炎及犬瘟热、钩端螺旋体病。

症状 结膜充血，肿胀，疼痛，流有浆液性、粘液性分泌物。羞明，流泪。严重时肿胀明显，疼痛加剧，流有黄白色脓性分泌物，上下眼睑闭合。

治疗 除去病因，消除炎症。

除去病因：首先治疗原发病，如与传染病并发，可全身用抗生素药物治疗，并局部用抗生素眼药水或眼膏点眼，每日3—4次。

洗眼，除去异物：用0.1%食盐水或2—3%硼酸溶液或1%明矾溶液清洗患眼，再用可的松眼膏、氯霉素眼膏等点眼。分泌物多时，可用生理盐水或2—3%硼酸溶液，加热至40℃左右，用数层纱布浸药温敷于患眼，装眼绷带，每日更换3—4次。也可用青霉素、0.5%盐酸普鲁卡因溶液，作眼睑结膜内注射或眼底注射。

角 膜 炎

角膜炎系指眼的角膜炎症，比较多发。一般可分为外伤性、表层性、深在性和溃疡性的四种。

病因 外因性由于风、尘土、创伤、异物、热伤、酸碱刺激，或由于眼睑内翻、睫毛乱生、睫毛异生等刺激而引起。

内因性由于变态反应、维生素A、B₂和C的缺乏、雌激素不足、应激反应、三叉神经麻痹引起角膜的营养障碍所致。或继发于某些传染病、眼球干燥病等。

细菌、病毒以及真菌等感染也可引起。

症状 角膜上形成不透明的白色瘢痕称之角膜混浊或角膜翳，是各种角膜炎的症状之一。角膜周围充血，角膜上有呈树枝状的新生血管。患眼怕光、羞明、流泪、疼痛。

表层性角膜混浊，呈淡蓝色或灰白色；深在性角膜混浊，呈白色不透明。外伤性的有浅创、深创和穿透创。角膜呈点状、弥漫混浊。

治疗 与结膜炎治疗相同。为了防止虹膜粘连，可用镇痛散瞳药，0.5—1%硫酸阿托品点眼，每日1—3次。为了促进角膜混浊消散，有甘汞粉或甘汞和乳糖等量，研细，吹入眼内，每日1—2次。配合使用自家血眼睑皮下注射，从病犬静脉采血2毫升，立即注入眼睑皮下，每隔2天注射一次。地塞米松软膏或肤氢松软膏点眼，每日2—4次。给以维生素制剂，可以促进角膜代谢。

颜面神经麻痹

颜面神经麻痹系指面神经干暂时或永久丧失其传导功

能。

病因 大多数是由于外伤而引起，如交通事故撞击、摔跤、冲击等。或由于长时期的中耳和外耳的炎症的继发。或由颜面神经中枢的延脑障碍和占位性病变而引起。

症状 由于颜面神经障碍的程度和患病部位的不同而出现完全麻痹或部分麻痹。中枢性面神经麻痹发生两侧性症状；慢性麻痹时，颜面神经萎缩和一侧性症状，患侧拘缩。外周性面神经麻痹多为一侧性。

完全麻痹表现鼻、唇松弛，耳下垂，音响等刺激时不动，眼睑反射消失，下眼睑下垂。口唇和口角下垂并流出唾液。采食困难，从口内掉出。

一侧性麻痹时，上述诸症状在患侧出现。患侧肌肉失去紧张性，颜面部不对称。肌肉软弱，鼻向正常侧扭曲。

治疗 早期发现，及时治疗。对急性炎症和水肿，采用肾上腺皮质激素治疗有效。对于感染可采用抗生素药物治疗。由中耳和外耳炎症而引起的抓紧治疗原发病。针灸或电针治疗：上关、下关、开关、锁口等。局部涂擦刺激剂：四三一合剂、松节油、樟脑酒精等面部涂擦。

（十二）耳的疾病

外 耳 炎

外耳道的炎症。主要症状是炎症和痒觉。常发生于犬，发病率为3—16%。

病因 主要是由于水浴时水浸入外耳道或残留于内而引起。或由于耳垢贮留和腐败的刺激而引起。

由于黄色葡萄球菌、链球菌、变形杆菌、大肠杆菌或真菌等二次感染而引起。耳疥癣的寄生可以引起外耳炎。长耳和垂耳犬种易患。

症状 由于外耳的炎症而发痒，病犬摇头摩擦或用后肢挠抓病耳，因此，引起外伤、破溃、疼痛不安。有的从外耳道排出渗出液、粘液或脓汁，被毛湿润，被耳的分泌物粘连，并散发臭味。

治疗 除去异物，用3%双氧水清洗外耳道，边洗边清除耳垢、分泌物及痂皮。充分清洗后，用细棉花卷将外耳道内剩余液体吸干。如深部存有异物，用小镊子仔细取出深部异物。每天清洗1次，保持外耳道清洁干燥。

轻症病例涂抹抗生素软膏，如正泰霉素软膏、氯霉素软膏、氟氢松软膏等，每日2—3次。

重症病例，用3%双氧水清洗之后擦干，隔日或3—4日一次。抗生素药物点耳或涂布。或用碘仿磺胺粉（1：9）撒布。分泌物较多者，可用氧化锌糊剂（氧化锌2份、淀粉3份、凡士林1份，混合）涂于患部。或涂擦碘甘油。也可用抗生素与皮质激素类合剂，即正泰霉素3毫克/克，新霉素碱3毫克/克，杆菌肽500单位/克，硫酸多粘菌素B 1000单位/克，醋酸氢化可的松10毫克/克，蓖麻油和凡士林适量。将蓖麻油和凡士林加热，趁热将上述4种药物混入备用。将药剂滴入外耳道，轻轻按揉，每日1—2次。也可全身用抗生素药物。

中 耳 炎

中耳炎是鼓室的炎症。常发生于犬。

病因 从病因分为原发性中耳炎和二次性中耳炎。

原发性：由于上部呼吸道感染通过骨性耳咽管或血行而引起。

二次性：从外耳炎的继发或者由于不慎致使鼓膜穿孔而引起感染。

表15

耳的疾病

疾 病	主 要 症 状
外耳炎	外耳痒觉，摇头，排出粘液，耳壳内恶臭，耳根部压痛
中耳炎	精神沉郁，发热，咽部淤血，扁桃体肿胀，头部歪斜，耳根部肿胀
内耳炎	发热，疼痛，恶心，呕吐，斜颈，眼球震颤，姿势异常

症状 急性炎症，体温上升，精神沉郁，摇头，咽部淤血，扁桃体肿胀，耳根部疼痛。不吃食和饮水，有的不能站立。眼球颤动，运动失调。

治疗 全身疗法，采用大分子霉素系抗生素药剂。交沙霉素25毫克/公斤体重，分3—4次内服；氨苄青霉素25毫克/公斤体重·日，分3—4次内服；或用潘别丁25毫克/公斤体重·日，分3—4次内服。剧烈疼痛和体温上升时，用25%安乃近，中型犬以上1毫升，小型犬0.5毫升，皮下注射。配合使用地塞米松，小型犬10毫克，大型犬20毫克，皮下注射，效果更好。

局部处置：用3%双氧水清洗外耳，除去耳垢及污物，洗后擦干，涂布抗生素软膏。每日2—3次。

内 耳 炎

内耳炎是迷路的炎症。犬少发。

病因 多由中耳炎、外耳炎蔓延而发病。也可由血液、外伤或其它感染而引起。

症状 无特征性症状。一般的为单侧性患病。在临床上与中耳炎的区别困难。体温上升，恶心，呕吐，疼痛。多数病例出现斜颈。伴有半规管障碍时，出现眼球震颤、歪头、异常姿势和异常运动，向患侧倒转或作圆圈运动。

治疗 同中耳炎的治疗

断耳整形术

耳的整形术是为了某些犬种的要求，整形后耳直立，美观大方。或由于肿瘤、溃疡等作断耳术。整形术在生后3—6个月龄时为宜。

器械：除一般外科手术器械外，要有断耳用夹子，可用肠钳子、大镊子代替。

保定和麻醉：横卧保定。局部盐酸普鲁卡因浸润麻醉。

术部：一般标准从内耳边缘上1/3至外耳边缘的下端画一线，在线的外侧切除。或在其耳的尖端切除，或根据犬主要求切除。

手术方法：用脱脂棉球将外耳道堵塞，防止血液流入。装着断耳夹子。在断耳夹子外侧0.5厘米左右，剪毛、消毒。切开皮肤，在断耳夹子外侧0.5厘米处切开皮肤。在皮肤和软骨之间进行钝性分离，分离至露出软骨为止。然后将剥开软骨靠近断耳夹部切除软骨及应去掉的耳。这时剩下一个皮套（皮瓣）。然后结节缝合皮肤闭合创口。涂布碘酊，取下断耳夹子。保留切除片，以使对侧耳按相等地切除，要求左右对称。包装绷带。

术后按一般创伤处理，2—3日后除去绷带。适当按摩

耳的边缘，防止形成瘢痕。

(十三) 产科疾病

阴道炎和阴门炎

急性阴道炎和阴门炎是难产后急性子宫炎的继发症。在临床上主要是慢性型。这个病的发生与年龄无关。

病因 因大肠杆菌群、链球菌、葡萄球菌和真菌类等感染而发病。或继发于阴道和阴道前庭的肿瘤及异物。

症状 阴门肿大、充血，从阴门流出粘液性或脓性分泌物。病犬舔阴门，特别是排尿后尤为明显。阴门周围发生皮肤炎症和湿疹。

治疗 用0.5%高锰酸钾溶液清洗阴道及阴门部，除去污物。也可用2%硼酸溶液清洗。清洗后，阴道内放入抗生素药物或涂擦抗生素软膏。外阴部保持清洁，按皮肤炎治疗。

表16

产科疾病

疾 病	主 要 症 状
阴道炎和阴门炎	阴门肿大，阴门流出脓性物，阴门周围皮肤炎
布氏杆菌病	流产、死产，附睾和睾丸炎，不妊，角膜炎，淋巴结肿大
阴道脱	阴门肿物，阴门肿大
子宫脱	阴门肿物，轻度努责，不安，腹部紧张
难 产	食欲不振，尿频，努责，阴门流出绿色液体
乳腺肿瘤	乳房肿大，食欲不振，咳嗽，皮肤和皮下肿物
卵巢摘除术	
公犬去势术	

犬布氏杆菌病

犬布氏杆菌病是由布氏杆菌所引起的一种人畜共患传染病。以妊娠母犬发生流产、公犬发生睾丸炎为特征。

病因 犬布氏杆菌是革蓝氏阴性短杆菌，经呼吸道、消化道和生殖器官的粘膜而感染，引起菌血症。

症状 公犬一侧或两侧附睾肿大、硬化，睾丸萎缩。阴囊发红，出现皮肤炎，病犬舔其阴囊。前列腺肿大，性欲减退，不妊。

母犬不妊或妊娠后期（约50日以后）发生流产、死产。流产或死产后母犬排出绿褐色乃至灰绿色恶露，从数日至数周。这样的病母犬反复流产，多数终生不妊。

治疗 对流产母犬可用0.1%高锰酸钾溶液或1%食盐永洗涤子宫和阴道，开始每日1—2次，以后每隔2—3日一次，直至无恶露排出为止。

各种抗生素药物长期大量使用，四环素60毫克/公斤体重·日，分两次口服；链霉素40毫克/公斤体重·日，分两次口服；二甲胺四环素50毫克/公斤体重·日，分两次口服。

预防 感染的阳性犬杀死或隔离治疗。犬舍充分消毒，保持清洁卫生。阳性犬不能做繁殖用。护理病犬或接产人员等，必须加强防护，严格执行消毒制度，以防感染。

阴道脱出

阴道脱出是阴道壁的一部分突出于阴门外。犬的阴道脱出大部分发生在发情前期或发情期。极少数发生在妊娠末期。

病因 雌激素过剩，在发情前期和发情期分泌多量雌激素，引起阴道粘膜浮肿性肥大，会阴部各种组织松弛所致是主要原因。其次是小型母犬与大型公犬交配时或交配当中无理由而脱离所造成。也有些是遗传因素。

症状 阴道壁的一部分形成红色球状物从阴门露出。轻症时，病犬起立时还回阴道内。重症时，站立时也不还回。粘膜水肿、出血和糜烂。因接触异物发生损伤。老龄犬易发。

治疗 对于轻症病犬，应增加运动，防止伏卧，使病犬处于前低后高的斜坡上，以减低腹内压，即可自然恢复。对于不能自然缩回的，应采取还纳整复。使病犬取前低后高姿势，用2%明矾溶液，或0.1%高锰酸钾溶液，或1—2%食盐溶液彻底清洗，除去异物、坏死粘膜，清洗后涂以复方碘溶液或碘甘油。手垫纱布将脱出之阴道送至阴门内，再用拳将其顶送至原位。然后在阴门上方和两侧各点注射90%酒精溶液3—5毫升，以防再脱。或用子宫托、铁环等加以固定。

子宫脱出

子宫脱出是指子宫的部分或全部由子宫颈脱出于阴道内或阴门外。多发生于分娩后，有时是在分娩后数小时内发生，极少发生在分娩后2—3日。一般是一侧子宫角脱出，有时也有两侧子宫角完全脱出。

病因 确切的原因不明。在分娩时由于产道损伤等，阵痛过强，或在助产时无理的牵引胎儿等诱发。

症状 子宫脱出分为不完全脱出和完全脱出。

不完全脱出：病犬不安，轻度努责，不自然的姿势，举

尾，腹部紧张。阴道检查时，用手可触及脱出的子宫。

完全脱出：一侧子宫角由阴门突出呈棒状，或两侧子宫角和子宫体全部脱出。脱出的子宫粘膜淤血或出血，有时陷于坏死，有的水肿。如子宫体发生嵌顿时，则出现腹痛可触及肥厚部。

治疗 清洗脱出部，除去异物。用0.1%高锰酸钾溶液或2%明矾溶液清洗。清洗后，采取前低后高位，用手指轻轻推回，同时用另一只手从腹壁上往前方引导子宫，经阴道整复还纳。

完全脱出或高度淤血和浮肿病例，从阴道还纳有困难者，在下腹正中部剪毛、消毒，切开腹腔，从腹腔内将脱出之子宫牵引回位。

整复后全身投给抗生素药剂和子宫收缩剂。阿托宁5—10单位，皮下或肌肉注射。或脑下垂体后叶素0.1—0.5毫升，皮下注射。

脱出子宫严重损伤时，可行卵巢子宫全摘出术。

难 产

难产是分娩经过显著延迟，呈分娩困难或不能产出的状态。是犬的常见疾病之一。约占全分娩的3.3%。

病因 遗传因素，波上顿梗、北京犬、斗牛犬等品种发生率高，杂种犬发生率低。胎儿过大，胎儿变位，死胎和胎儿畸形，初产犬多发。软骨病或外伤等引起骨盆变形、肥胖、消瘦、运动不足和老龄犬易发生阵痛微弱而难产。

症状 有下列征候者均可怀疑为难产：连续阵痛4小时，无仔犬产出者；娩出1—2头仔犬之后，经过4—6小时，无仔犬产出者；母犬食欲不振、精神沉郁、频繁排尿

时；从阴门排出绿色的排泄物，经过数小时，无仔犬产出者。

治疗 给予子宫收缩剂：用阿托宁或催产素 5—20 单位，肌肉注射，间隔 20 分钟后，可行第二次注射。从产道抽出：消毒阴部，以手指插入阴道进行内诊，如触及胎儿，可先注入润滑剂（消毒的液体石蜡或植物油）使产道滑润，从内用手指牵引胎儿，从外部压迫产道，使仔犬产出。或用分娩钳子取出胎儿。

药物治疗无效者，作剖腹产手术。

病犬行仰卧保定，全身麻醉或硬膜外麻醉。

腹下部中线切开。术部剪毛、消毒。

打开腹腔后，先取出子宫角，放在创口外，再取另一侧子宫角，取出后用大块温湿纱布将子宫与其它器官隔开，防止污染腹腔。在子宫角大弯处纵行切开 4—6 厘米，一侧胎儿取出后，在同一创口取出另一侧胎儿。

取出胎盘后，冲洗子宫，放入抗生素药物或磺胺类药物后，缝合子宫。

腹膜行连续缝合，肌层和皮肤行结节缝合。

术后给以催产素 5—10 单位，肌肉注射，促进子宫收缩。在 3—5 日内给以抗生素药物。

母犬卵巢摘除术

为了避免无计划繁殖及便于管理，进行母犬卵巢摘除术。无年龄限制，一般在生后 6 个月进行手术为宜。秋季施术为宜，春季应防止出血。

犬卵巢的位置比较靠前，在季肋骨与髁结节之间，第 3—4 腰椎下方，两侧肾脏的直后方。卵巢被卵巢囊包围

着，幼犬是一薄膜，可直视卵巢；成犬有脂肪沉着，多数不能直视。卵巢囊的一端有短的固有韧带与子宫相连。另一侧以卵巢系膜与腹壁相接。

保定与麻醉：仰卧保定，全身麻醉。

术部：腹下白线纵切开法、腹部切开法、腹下白线横切开法等，一般采用腹下白线纵切开法，创口小，不易出血。

手术方法：术前应绝食12小时以上。便于手术，防止呕吐。术前剃毛、消毒。在脐部后方2—3厘米处切开皮肤，长约6—10厘米。腹肌及腹膜切开后，打开腹腔。

寻找子宫角，探查卵巢。用手指伸入腹腔，探查子宫，子宫为灰白色呈索状，与肠有明显区别。将子宫角从创口拉出，然后向前顺子宫角提起卵巢和输卵管。用食指和拇指钝性分离其韧带，不要撕裂其血管，提起卵巢分别结扎卵巢动脉和子宫动脉或集束结扎两个动脉，防止术后出血。切断后除去卵巢及输卵管。以同样方法摘除对侧卵巢。向腹腔撒布抗生素药物。缝合腹膜和肌层，再结节缝合皮肤。缝合部涂布碘酒。

术后给以抗生素药物和磺胺类药物，体温不高者也可不给。术后2—3日内给以易消化的流食，渐渐恢复正常。术后7—8日拆线。

公犬去势术

公犬去势的目的是使公犬变得温顺，易于管理和调教。有的是便于有计划的繁殖，将不可作种用的公犬淘汰。再者，为了治疗的目的，如睾丸创伤、肿瘤、严重的睾丸炎。

犬的阴囊位于股间，中间有线状纵沟，将左右睾丸分开，阴睾颈部较短，精索比较长。睾丸近球形。

备一般手术器械。侧卧保定。

手术方法：用左手将两侧睾丸挤于阴囊底部，使阴囊缝在两睾丸正中间。以3—5%碘酊消毒后，沿阴囊缝侧方0.2—0.5厘米处与阴囊缝平行切开皮肤和总鞘膜，挤出睾丸。剪断或撕断鞘膜韧带，再用指甲刮断精索取下睾丸。如成犬、精索较粗，可用结扎法，结扎精索后，切断精索取下睾丸。再在同一切口切开睾丸中隔和对侧总鞘膜，挤出睾丸，用同样方法取出对侧睾丸。涂3%碘酒消毒。创口不必缝合。

(十四) 出现神经症状和运动麻痹的疾病

狂 犬 病

狂犬病是由狂犬病病毒引起的极危险的人畜共患病毒性疾病，也是犬的主要传染病之一。狂犬病毒具有特异的与中枢神经的亲合性，在临床上以神经兴奋和麻痹为特征。本病在世界各地流行。

病因 狂犬病病毒属于弹状病毒属。主要存在于病犬的脑脊液、唾液腺和唾液中。感染犬唾液中带毒，咬伤其它犬及动物均可发病。亦可通过皮肤和粘膜的损伤感染。也可经口或呼吸道而感染。病毒对火碱、酒精、热、升汞等抵抗力弱。

当被动物咬伤后，病毒在附近的肌肉细胞内局限性繁殖，由邻近的知觉神经末梢侵入，经过脊髓到达脑干，在大脑细胞内繁殖。这时在内部形成尼氏小体，在外部反射机能亢进，出现攻击性、狂暴性的神经症状，不久增殖的病毒沿着神经元的突起下行，广泛地分布于全身，则出现麻痹。

症状 本病潜伏期为10—16日，症状在15—25日出现，有的长达数月或更多。潜伏期的长短与感染部位、病毒的数量和毒力有关。一般临床分为狂暴型和麻痹型。

狂暴型：病初表现不安，抓地，变换蹲卧地点或躲于阴暗的角落，唤之不愿出来。有的则不安地走动或无原因空吠。食欲不振，异嗜，流涎。注意力提高，对外界刺激敏感，尤其是对光线或突然的喊声，高度惊恐或跳起。有的病犬自咬受伤外，甚至咬伤其它组织，如四肢、尾部和阴部。性欲亢进，嗅舔自己或其它犬的性器官。有的无目的地逃窜，狂乱攻击人畜，易咬伤人畜。由不安、兴奋变成剧烈狂暴，然后沉郁，当再次受刺激时，就再一次发作。有的犬给水，则引起狂暴发作，所以又称恐水症。以后叫声嘶哑，消瘦，食欲废绝，卧地不起，呼吸中枢麻痹而死亡。

麻痹型：又称沉郁型。有短的兴奋或者表现不明显就进入麻痹期。有的精神沉郁，食欲不佳或废绝。喉、舌脱出口外，下颌下垂，口内流出大量泡沫性唾液。声音嘶哑，吞咽困难，病犬出现噎塞声，误认为有物体卡在咽喉部。麻痹很快传播全身，因呼吸中枢麻痹而死。

诊断 早期诊断困难，易与其它疾病相混淆。如病犬出现典型症状，结合病史可初步诊断。对可疑病犬，将其拴留10日，以便观察，观察病犬每日活动、食欲、表现以及声音变化等。在唾液腺或中枢神经查到尼氏小体即可确诊。

治疗 对已确诊为本病的病犬，无治疗价值，又因是人畜共患病，易传染给人，危及人的生命，不进行治疗，应予以扑杀。

预防 定期预防注射。对所有饲养的犬均应定期进行预防注射，每年注射两次。对无人认领的病犬和野犬，也应予

以扑杀。

被可疑犬咬伤后，对伤口应彻底消毒，从伤口挤出血来，再用2%肥皂水或0.1%升汞液冲洗，再涂碘酊。应立即进行紧急预防注射。也可用免疫血清治疗。

表17 出现神经症状和运动麻痹的疾病

疾 病	主 要 症 状
狂犬病	流涎，食欲不振，不安，异嗜，出现神经症状，麻痹
热射病	明显体温升高，呼吸促迫，呼吸困难，瞳孔散大，痉挛和搐搦，起立困难，结膜发绀，红细胞增多
破伤风	强直性痉挛，瞬膜突出，步样强拘，角弓反张，开口障碍，过敏
斜 颈	斜颈，圆周运动，颈部疼痛和热感，起立困难
椎间盘疾病	后躯麻痹，运动障碍，腰背部压痛
产后急病	强直性间歇性痉挛，流涎，发热，异常兴奋，呼吸促迫，呼吸困难，多产小型犬易发
蛔虫症	食欲减退，呕吐，腹部膨满，肺炎出现神经症状，幼犬易发
犬瘟热	发热，呼吸困难，结膜炎，发咳，鼻汁，下痢，皮肤发疹，出现神经症状，继发病

热 射 病

日射病系指在炎热的夏季，受强烈的日光直接照射时间较长，引起脑及脑膜充血，使中枢神经系统的机能紊乱而发生的疾病。热射病系指外界环境过于闷热、通风不良，致使机体产热过多或机体散热受阻，造成中枢神经系统机能紊乱而发生的疾病。两者在实际工作中鉴别困难，主要以体温升高、突然虚脱为特征。

一、病因 高温，换气不充分，通风不良，环境温度比体温高，热的放散受到限制等均可引起本病。

二、症状 突然发病，急剧的体温升高，可达41—42℃。呼

吸促迫，高度呼吸困难。结膜初期呈鲜红色，逐渐变成发绀。脉搏增加，末梢静脉怒张。瞳孔散大，病情有所好转时则缩小。数小时后，呈现起立困难，出现痉挛和抽搐。

治疗 以尽快促进体热放散，缓解心肺机能障碍为原则。首先将病犬放在通风良好、阴凉的地方。用冷水浇头部或用大量冷水灌肠。

放血。放血后，静脉输给生理盐水、糖盐水等。

对于全身痉挛和抽搐病犬，给以杜冷丁2毫克/公斤体重，输液剂100毫升，静脉滴注。或2.5%氯丙嗪注射液0.3—0.5毫升，肌肉注射。

对于重度休克犬，采用肝素1毫克/公斤体重，静脉注射。地塞米松1毫克/公斤体重，静脉注射。或用氯普马嗪1—2毫克/公斤体重，静脉注射也有效果。

破 伤 风

破伤风是由破伤风杆菌引起的一种人畜共患传染病。本病特点是兴奋性增高，对外界的刺激反应敏感，全身肌肉呈持续性的痉挛收缩，但意识清醒。

病因 本病由破伤风杆菌产生外毒素而发病。破伤风杆菌在体外产生芽孢，存在于土壤和粪便中。主要经创伤感染。本病散在发生。外毒素有痉挛毒和溶血毒两种。

症状 本病潜伏期为5—8日，早的于第3日，晚的可达10日以上发病。

犬患本病的特征是强直性痉挛，先从头侧部肌肉开始，开张姿势，角弓反张，进而呈现全身性强直性痉挛。因头侧部肌肉的强直性痉挛而出现瞬膜脱出、上眼睑上举、开口障碍、鼻翼开张，不能咀嚼和饮水，耳、尾上举，呈现不安状

态。继而颈部肌肉强直，四肢关节不能屈曲，呈开张姿势，不能行走，但腹部卷缩。对外界的声音、振动、光线极为敏感，常常引起角弓反张，进而陷入呼吸困难而死亡。

病初无体温变化，死亡前出现体温升高，由于咽下困难、肌肉麻痹而引起营养不足，电解质和水分失调。

诊断 根据创伤病史和特征性的临床症状可初步诊断，分离出破伤风杆菌而确诊。

治疗 消灭病原，中和毒素：抗毒素血清0.1—0.2毫升，皮内注射。或抗毒素血清1000单位/公斤体重，静脉注射。抗毒素血清效果约持续14日左右。处置伤口：在原创伤感染部位用0.1%高锰酸钾液或双氧水彻底冲洗，充分暴露伤口，必要时可扩创或烧烙创口。创口周围用青霉素、普鲁卡因封闭。全身投给大量抗生素药物，青霉素、链霉素、四环素等。

解痉镇静：苯巴比特钠 6 毫克/公斤体重，肌肉注射，维持量 2—4 毫克/公斤体重，肌肉注射。麦酚生 0.25—1.09 克/头，每 4 小时经口投给。

对症疗法：输液补给水分、电解质和营养剂。防止褥疮，及时翻身，变更体位，对骨的突出部进行按摩。

加强护理：将病犬放于安静较暗的地方。定期排尿和排便。

预防 加强管理，防止发生外伤。一旦发生外伤，深的创伤进行扩创开放，并用双氧水充分消毒后，局部或全身使用青霉素。做各种手术时，应严格进行消毒。

斜 颈

斜颈系在临床上观察到头颈向一侧倾斜的症候性命名。

病因 先天性斜颈：胎儿在子宫内呈异常姿势，由颈部肌肉拘缩而引起。后天性斜颈：由颈部肌肉和颈椎的外伤而引起，如从高层建筑坠落，造成颈椎骨折、脱臼和皮肤的断裂而继发。肌肉风湿症和椎体外系统疾病之一也能发病。

症状 头颈部向一侧弯曲，多数在步行时向弯曲侧方向作圆周运动。局部有热、痛，由外伤引起的颈部肌肉和骨有伤害，高度疼痛，不能站立。疼痛减轻之始固定头部，原地慢慢地运动。为了减轻疼痛，头呈背弯姿势，颈曲方向的反对侧前肢上举。

治疗 犬瘟热的后遗症，颈部脱臼和骨折预后不良。局部外伤的，可进行冷敷、热敷、按摩等理疗法。也可局部涂擦刺激剂，如樟脑酒精、樟脑鱼石脂软膏等。神经和肌肉障碍，可用ATP制剂2毫克/公斤体重，维生素B₁1—2毫克/公斤体重和地塞米松0.2毫克/公斤体重，皮下注射。肌肉风湿可用10%水杨酸钠注射液10—20毫升/头，静脉注射，每日1次，或用保太松0.1克，内服，每日1—2次。亦可用消炎痛、强的松龙等。

（十五）贫血和出血性素质疾病

犬巴贝西虫病

犬巴贝西虫病是由犬巴贝西虫寄生在红细胞内的一种多形性原虫病。在临床上出现反复发热、高度贫血。世界各地均有发生，尤其是热带或亚热带国家。

病因 犬巴贝西虫病由三种虫体所致。即犬巴贝西虫、吉氏巴贝西虫和韦氏巴贝西虫。吉氏巴贝西虫为小型种，其余两个虫体为大型种。蜱是主要传播者，有血红扇头蜱、牛

羊蜱、李氏血蜱、双刺形盲蜱和边纹璃眼蜱。

症状 吉氏巴贝西虫症潜伏期为7—10日。体温升高为39—40℃，少数病例超过40℃。呈稽留热型。贫血是主要症状，贫血在发热后出现。尿呈黄褐或暗褐色，粪便由黄色转为砖红色。下痢和便秘交替出现。食欲减退，精神不振。重病例，可视粘膜苍白，出现频脉和细脉，营养明显下降，起立困难。脾肿大。本地犬抵抗力强，纯种犬抵抗力差。

犬巴贝西虫病潜伏期为2—3周。体温上升可达40℃以上。呈间歇热型。食欲减退，呕吐。尿色为黄褐色，可检出胆红素、血色素和蛋白。急性病例开始体温高达40℃以上，出现贫血，黄疸，很快陷于虚脱状态，体温下降直至死亡。慢性病例出现持续发热、贫血、轻度黄疸、肝脾肿大和胆红素尿。

诊断 根据典型临床症状可初步诊断，从病犬血中查到虫体可确诊。

治疗 1%台盼蓝溶液2.2毫升/公斤体重，静脉注射；或用0.5%阿卡普林溶液0.25毫克/公斤体重，肌肉注射。配合使用强的松龙1毫克/公斤体重·日，效果更佳。

输血、输液，对严重贫血犬应予输血，补充离子和防止酸中毒，给以维生素制剂。

使用抗原虫药剂，多数情况，初次治疗后15—30日左右再度出现贫血。对再发者进行与初次同样的治疗。但是为了防止再发，在初次治疗后10—14日后，再次进行治疗。

新生犬黄疸症

本病是由于父母犬的血型为特定的不合的血型，它们交配所产生的新生犬含有特定的血型时，在出生后吸吮初乳，

表18

贫血和出血性素质疾病

疾 病	主 要 症 状
溶血性贫血	
贫血症	粘膜苍白，黄疸，易疲劳，心悸亢进，消瘦，呼吸促迫，脾肿大，血色素尿，血色素血症
巴贝西虫症	发热，黄疸，黄褐色尿，脾肿大，粘膜苍白
新生犬黄疸症	血色素尿，黄疸，急死，血色素尿症，红细胞脆性增加
失血性贫血	
钩虫症	粘血便，消瘦，步样踉跄，食欲减退，嗜酸性白细胞增加
出血性素质	
犬传染性肝炎	虚脱，急死，腹部压痛，呕吐，发热，角膜混浊与溃疡，粘膜出血，淋巴结肿大，白细胞减少

便由于含有母源抗体而导致红细胞被破坏，引起贫血、黄疸和急性死亡的同种免疫性溶血性疾病。

病因 一般认为犬发病的血型因子是CEA—1型。母犬含有CEA—1阴性的血型，被CEA—1型阳性的血液所致敏，而且与CEA—1型阳性公犬交配，所产生的CEA—1型阳性仔犬而患病。发病随吸吮母乳而出现，因母乳中含有抗CEA—1型红细胞抗体，导致溶血反应。本病并不少发，认为是新生犬的重要死因。

症状 新生犬完全正常，由于吸吮初乳而发病。病情以吸吮母乳量而有所不同，吸吮母乳量越多，发病越急越重。因此，初生犬体格大，精神越好，发病越重。最急性病犬不见特有症状，短时间内死亡。这时可见血色素尿症和血色素血症。病犬精神沉郁，哺乳能力降低，生后次日可视粘膜苍白，第3日出现黄疸症状，并逐渐加重。出现血色素尿和胆色素尿，肉眼可见尿呈红色，将尿样采入小试管内进行潜血试验，呈阴性。若治疗不及时，全部仔犬在2—3日内死

亡。

诊断 根据特有的情况及典型临床症状可初步诊断。

治疗 首先断奶，怀疑本病时，则应立即断乳，改为人工乳。投给肾上腺皮质激素。为了抑制网状内皮细胞吞噬红细胞的作用，用强的松龙 2 毫克/公斤体重，口服。反复经口投给 2—3 % 葡萄糖溶液，以便迅速稀释和排除游离血色素，尽可能减轻对肾脏的损伤。对重症犬，输给除母犬以外的血液，经腹腔输给，按 20 毫升/公斤体重计算。

预防 应中止和过去曾发生过新生犬急死的公犬再进行交配。在预计有发病可能性时，应切断初乳，出生后立即进行人工乳哺乳。

犬传染性肝炎

犬传染性肝炎是由犬腺病毒感染引起的一种病毒性传染病。在幼犬发生重笃急剧型的急性肝炎。是传播广泛的病毒性传染病。一年四季均可发生。各种年龄犬均可发生，幼犬和刚断奶的仔犬发病率和死亡率最高。

病因 本病是由腺病毒科乳腺病毒属的犬腺病毒所引起。本病毒分为两个型，犬腺病毒—I 型，是本病的病原，犬腺病毒—II 型，主要引起呼吸器官疾病。这个病毒属 DNA 型。病毒分布于各种组织中和分泌液中，通过分泌物和排泄物排出体外，污染环境和物体，主要通过病犬或其污染物相接触而传播。

症状 本症由其临床症状和经过可分为四型。

突发致死型：新生仔犬乃至未满 1 岁的幼犬多发。突然发生重笃的腹部疼痛和体温显著升高，很快陷于虚脱。有时进而吐血和并发赤痢症状，在 12—24 小时以内死亡。

重症型：病初精神不振，体温高达41℃，流泪，流水样鼻汁，发热持续2—6日。其后腹部疼痛，食欲不振，渴欲增加，呕吐，下痢，齿龈和口腔粘膜充血和出现出血点。可见步样踉跄，知觉过敏等神经症状。扁桃腺和全身淋巴结肿大。

恢复期常常可见一侧角膜炎和角膜浮肿，呈现所谓的“蓝眼、青白色云雾”，1—2日间急速变成白色混浊。持续2—8日逐渐恢复。一部分残存角膜损伤，也有的视力永久消失。病的急性期继续4—7日后，大部分治愈。

轻症型：几乎不见特异的临床症状。轻度和中等程度的食欲不振，精神沉郁，流泪和流水样鼻汁，体温为39℃。常常出现狂躁状态，约2—3日左右，吠叫和来回走动。

不显型：不见临床症状出现，只有由血清学的特异抗体来证明。

诊断 一般根据流行病学、临床症状可初步诊断。本病早期症状与犬瘟热、钩端螺旋体病等相类似，且有时混感，应注意鉴别。本病可见核内包涵体，而犬瘟热为胞质包涵体。

治疗 早期可用大量高度免疫血清注射，缓解临床症状极为有效，突发致死型无效。

输血和输液：重症病例输全血有效，按17毫升/公斤体重，输给全血，48小时反复2次。输液，每日用5%葡萄糖溶液、5%蛋白质水解物的等渗盐溶液。

投给抗生素药剂或磺胺类药物，防止并发症。氯唑青霉素或氯唑青注射液100—250毫克，肌肉注射。或用土霉素注射液100—300毫克，静脉注射，每日1—2次。亦可用碘制剂和抗生素软膏点眼，对角膜混浊处置。

预防 预防注射用减弱的活毒疫苗。有单独的疫苗，也有与犬瘟热、犬钩端螺旋体的混合疫苗。一般在9—12周龄时，进行第一次接种，于15周龄时再做第二次接种。以后每年接种一次。

（十六）皮肤疾病

湿 疹

湿疹系皮肤的急性和慢性炎症。其临床特点是在患部皮肤发生红斑、丘疹、水泡、脓疱、糜烂、结痂和鳞屑等变化，伴有热、痛、痒等症状。

病因 本病原因不明。目前认为由于皮肤不洁，污垢积聚，犬舍潮湿，强烈日晒，昆虫叮咬以及各种物质刺激致使本病发生。腐败分解产物被吸收、病灶感染、微生物毒素等引起变态反应，促使本病发生。营养失调、代谢紊乱、内分泌机能障碍等疾病，均可诱发本病。

症状 在临床上分为急性湿疹和慢性湿疹。

急性湿疹：以红斑、湿润和瘙痒为特征。散在界限不清的各种皮疹，呈多形性，伴有瘙痒，湿润为主要症状。分为红斑期、丘疹期、水泡期、脓疱期、糜烂期、结痂期和落屑期。

犬的表皮菲薄，典型的急性湿疹，散在的湿润性丘疹和小水泡不见多形性，多数呈糜烂状。

慢性湿疹：以皮肤肥厚、皱裂的明显病变及“苔藓化”为特征。伴有皮肤肥厚、色素沉着和鳞屑。瘙痒增强，境界明显，湿润性较轻。急性湿疹连续地反复发生变成慢性的，慢性湿疹急剧恶化而变成急性湿疹。

治疗 消除病因，消炎，脱敏，及时治疗。

消除病因：经常给犬洗澡，梳刷身体，保持皮肤清洁、干燥。犬舍内保持清洁干燥，通风良好，阳光充足。加强运动。

消除炎症：湿性糜烂面用吸水性软膏。当出现水泡、脓疱破溃后，用2%明矾水或2%鞣酸溶液冲洗患部，去掉污物，擦干，涂5%紫药水，每日1—2次。对于干燥肥厚面采用亲水性软膏，用硼酸软膏或氧化锌软膏。也可用氢化可的松软膏、肤氢松软膏、抗生素软膏涂擦。

脱敏止痒：盐酸异丙嗪0.2—1.0毫克/公斤体重，内服或注射。盐酸苯海拉明2—4毫克/公斤体重，内服，5—50毫克/公斤体重·12小时，肌肉注射。强的松龙2毫克/公斤体重，内服。

肢端舐性皮肤炎

本病系犬本身对其四肢的同一部位不断舐而引起的皮肤炎。

病因 病因尚不清楚，一般认为与神经有关。多发于大型、短毛犬种。

症状 本病好发部位是指骨、掌骨的前部、桡骨、肱骨、胫骨的前部。病犬不断地对其部位舐触，开始患部脱毛、糜烂，继而形成溃疡。溃疡难以愈合。慢性化皮肤形成硬的结节状，肥厚。中心部溃疡，周边有高度色素沉着。

治疗 装着防舐装置，包扎绷带或缠以轮状物，防止舐。X线照射患部。肥厚者施行外科切除。定时拖曳运动，矫正恶习。

表19

皮 肤 疾 病

疾 病	主 要 症 状
湿 疹	搔痒，血疹，糜烂，痂皮，皮肤肥厚
肢端皮炎	脱毛，糜烂，溃疡，硬结
真菌性皮肤病	脱毛，丘疹，圆形病变，鳞屑斑，皮肤肥厚
疥 癬 病	脱毛，痒觉，湿疹，痂皮，皮肤敏感
虱 病	脱毛，痒觉，咬毛，擦伤，兴奋不安
蚤的侵咬	脱毛，断毛，痒觉，擦伤，兴奋不安
皮肤搔痒症	痒觉，皮炎
皮肤肿瘤	肿物，无痛
乳腺肿瘤	乳腺肿大，食欲不振，咳嗽
口唇炎	流涎，口部恶臭，口唇粘膜炎症，被毛脱落，口唇皮肤炎症
犬瘟热	腹下部发疹和脓疱，硬跛病，胃肠炎，脑炎，肺炎症状
犬断趾术	
犬断尾术	

真菌性皮肤病

真菌性皮肤病系由皮癣菌侵入皮肤角质层、皮肤附属器官、被毛和爪钩，在这些部位增殖发生的皮肤疾病。因病变多呈环状扩展，又名钱癣。是人畜共患病。

病因 是由皮癣菌感染而发生。犬的主要病原菌是犬小孢子菌、石膏状小孢子菌和须毛癣菌等。犬发生本症时各菌约为70%、20%、10%。

症状 病初有脱毛或断毛，病灶内残留折断的毛根。形状为圆形或类圆形，逐渐扩大。形成鳞屑斑，多发时相互融合成片，可见鳞屑。有时明显地形成痂皮。有的局部脱毛、丘疹，接着出现血痂样的小痂皮。有的可见全身的 皮肤 脱毛，明显的皮肤肥厚。大小孢子菌易感染人和其它动物，犬

主和其它动物出现相同的病变。

治疗 灰黄霉素10—20毫克/公斤体重，经口投给，每日1次或2次分服。或用2%氯苯咪唑溶液，每日涂擦3—4次。或用1:300环己烯亚胺溶液，每日洗刷2—3次。或用发癣退。

预防 早发现，早隔离，早治疗，防止感染犬主。治疗不彻底容易再发。搞好犬舍卫生，经常消毒。犬主注意卫生、消毒，以防感染。

疥 癬 病

疥癬病是由疥螨引起的传染性皮肤病，具有高度传染性，激烈瘙痒为特征。有时犬主也感染，伴有瘙痒，发生丘疹。

病因 犬疥癬病主要由犬疥螨所引起。当雌虫钻入皮肤时，在表皮隧道中产卵，孵化出幼虫，寄生在表皮层的虫道内。由于疥螨的唾液和代谢产物的刺激而引起炎症和瘙痒。

症状 本病的发生与年龄、品种无关。好发和初发部位是四肢末端、耳朵、颜面部、腹部和下腹部，最终扩展全身。开始出现红斑、丘疹、激烈的瘙痒。抓破、咬伤、往其它物品上摩擦，继而出血、结痂、形成痂皮，致使脱毛、皮肤肥厚，在尾根和额部等部位形成皱襞。多为干燥性病变，有时出现变态反应性病变，呈急性湿疹状。

诊断 根据瘙痒和皮肤病变可初步诊断，如查出螨虫即可确诊。

治疗 病犬应及时隔离，防止扩大蔓延。治疗前剪毛、水洗患部，除去痂皮，然后涂药。用敌百虫5克、来苏儿1毫升，加水100毫升，混合后涂擦患部，间隔1周涂擦第2

次。或用25%杀虫脒，用水配成0.1—0.2%溶液，洗擦或喷洒患部。给以强的松龙0.5—2毫克/公斤体重，或氟美松0.15—0.25毫克/公斤体重，皮下注射，或苯海拉明4毫克/公斤体重，皮下注射，有显著的止痒效果，抗炎性良好。如有脓皮症时并用抗生素药物。

虱 病

病因 犬受吸血虱或刺蜚虱的侵袭。虱卵寄生在被毛上，呈灰白色，半透明，亚卵圆形。经3—4周变为成虫。

症状 主要是刺激皮肤和瘙痒，病犬搔抓、摩擦和啃咬患部。严重侵袭时，发生脱毛和局部抓伤、贫血等。有的伤口发生感染。由于虱叮咬和不断爬行或刺蜚皮肤，病犬不安和神经过敏。

治疗 应用5—7%六六六粉剂，撒布于患部，或装入纱布袋内逆毛涂擦。0.1—0.5%敌百虫水溶液，喷洒。

蚤的侵咬

蚤是细小、无翅、扁平的昆虫，是吸血性外寄生虫。成蚤以吸吮血液和体液为食，在吸食时引起宿主的剧烈瘙痒。

病因 病原为犬栉头蚤。成年蚤产卵于宿主的被毛间，卵经7—10日孵化为幼虫，幼虫反复3次脱皮，在2—3周间变为成虫。成虫的寿命为30—40日。动物间由直接接触而传播。

寄生于犬的有犬蚤和犬羽蚤两种。

症状 羽蚤用锐利的爪刺激皮肤产生激烈瘙痒，病犬不安，进行抓咬，引起脱毛、断毛、擦伤。有时可见褐色的眼分泌物。

犬蚤吸血和分泌毒素直接刺激皮肤，症状比较重，蚤寄生部位发生二次外伤、二次感染而形成湿疹和化脓创。

治疗 一般用杀虫剂可以驱除。必须对动物及周围环境进行处理。

全身用肥皂水洗净后，1%鱼藤酮粉剂（4份硫磺与1份5%鱼藤酮粉混合）撒布或涂擦。鱼藤酮粉剂（鱼藤酮1%、白陶土或滑石粉2%、除虫菊素0.5%混合）充分撒布或擦抹，适于撒布睡床、犬箱等。防止感染可用氨苄青霉素5—10毫克/公斤体重，肌注。止痒用地塞米松和苯海拉明。

皮肤瘙痒症

皮肤瘙痒症系不伴发皮疹的瘙痒症。在临床上极为明显的唯一的症状是瘙痒感。

病因 潜在性疾病和伴发疾病而引起，如肝疾病、糖尿病、恶性肿瘤、犬瘟热、内分泌疾病、胃肠障碍、维生素（A、B、C）缺乏症、神经疾病、肠道寄生虫性疾病等。由于这些疾病的病理性产物进入血液，作用于神经系统而发病。

症状 瘙痒，病初是在局部发生，逐渐扩展全身。持续时间和痒的程度不等。病初皮肤无损伤，由于动物自行啃咬或与其它物品摩擦，致使皮肤发红、擦伤、渗出、湿润。

治疗 治疗潜在性疾病是根本疗法。止痒用水杨酸制剂、氢化可的松软膏、复方硫磺合剂涂擦患部。应用抗组织胺药物，可收到一定效果。